



Optimal  
Untuk  
Negeri



# Buku Ajar Nifas

Pande Putu Indah Purnamayanthi • Kusumastuti • Peny Ariani  
Ni Wayan Manik Parwati • Novi Eniastina Jasa • Ermawaty Arisandi Siallagan  
Emi Br Barus • Helti Lestari Sitinjak • Lia Fitria  
Ika Zakiah • Budi Rahayu • Erma Puspita Sari  
Uliyatul Laili • Iin Tri Marlinawati • Ayu Kurnia Anggraeni  
Lasria Simamora • Mariyatul Qiftiyah • Mastina  
Ranny Septiani • Rolita Efriani • Tonasih  
Yuni Kurniawati

**Editor:** Prof. Dr. Mufdlillah, S.SiT., M.Sc.



# Buku Ajar Nifas

Bdn. Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes.

Bdn. Kusumastuti, S.SiT., M.Kes.

Bd. Peny Ariani, SST, M.Keb.

Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.SiT., M.Keb.

Bdn. Novi Eniastina Jasa, S.ST., M.Kes.

Bd. Ermawaty Arisandi Siallagan, SST., M.Kes.

Bdn. Emi Br Barus, SST., M.Keb.

Bdn. Helti Lestari Sitinjak, SST., M.Keb.

Bdn. Lia Fitria, SST., M.Keb.

Bdn. Ika Zakiah, S.Tr.Keb., M.KM.

Budi Rahayu, S.ST., M.Keb.

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

Uliyatul Laili, SST., Bdn., M.Keb.

Iin Tri Marlinawati, S.Tr.Keb., MPH., M.Keb.

Ayu Kurnia Anggraeni, SST., M.Keb.

Lasria Simamora, SST., MKM.

Mariyatul Qiftiyah, SST., M.Keb.

Mastina, S.ST., M.Keb.

Ranny Septiani, SST., M.Keb.

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

Tonasih, SST., M.Kes.

Yuni Kurniawati, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Mufdlillah, S.SiT., M.Sc.



# Buku Ajar Nifas

Bdn. Pande Putu Indah Purnamayanthi, S.ST., M.Kes.

Bdn. Kusumastuti, S.SiT., M.Kes.

Bd. Peny Ariani, SST, M.Keb.

Bdn. Ni Wayan Manik Parwati, S.SiT., M.Keb.

Bdn. Novi Eniastina Jasa, S.ST., M.Kes.

Bd. Ermawaty Arisandi Siallagan, SST., M.Kes.

Bdn. Emi Br Barus, SST., M.Keb.

Bdn. Helti Lestari Sitingjak, SST., M.Keb.

Bdn. Lia Fitria, SST., M.Keb.

Bdn. Ika Zakiah, S.Tr.Keb., M.KM.

Budi Rahayu, S.ST., M.Keb.

Erma Puspita Sari, SST., Bdn., M.Kes.

Uliyatul Laili, SST., Bdn., M.Keb.

Iin Tri Marlinawati, S.Tr.Keb., MPH., M.Keb.

Ayu Kurnia Anggraeni, SST., M.Keb.

Lasria Simamora, SST., MKM.

Mariyatul Qiftiyah, SST., M.Keb.

Mastina, S.ST., M.Keb.

Ranny Septiani, SST., M.Keb.

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

Tonasih, SST., M.Kes.

Yuni Kurniawati, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Muftillillah, S.SiT., M.Sc.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN : 978-634-7426-01-7

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

**Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang  
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
*All Right Reserved***

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**



**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan  
Jakarta Barat, DKI Jakarta

Instagram: @bimbel.optimal

Tiktok: @maskokooo

www.optimaluntuknegeri.com

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

# Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini yang berjudul Buku Ajar Nifas dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi kami dalam bidang pendidikan kebidanan, khususnya untuk membekali mahasiswa dan tenaga kesehatan dengan pemahaman menyeluruh mengenai masa nifas yang merupakan sebuah periode penting dalam proses pemulihan ibu setelah persalinan.

Penyusunan buku ini didasarkan pada referensi ilmiah terkini, pedoman praktik kebidanan nasional maupun internasional, serta pengalaman lapangan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi pedoman akademik, tetapi juga menjadi panduan kerja di lapangan dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan empatik kepada ibu pada masa nifas.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kebidanan di Indonesia, serta menjadi bagian dari upaya menurunkan angka kematian ibu pascapersalinan.

## Penulis



# Daftar Isi

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Prakata .....</b>                                                         | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                                       | <b>iv</b>  |
| <br>                                                                         |            |
| <b>Bab 1 Konsep Dasar Masa Nifas.....</b>                                    | <b>1</b>   |
| A. Definisi Masa Nifas.....                                                  | 2          |
| B. Fisiologi dan Perubahan Anatomis serta Fisiologis Masa Nifas.....         | 2          |
| C. Durasi dan Fase Masa Nifas .....                                          | 3          |
| D. Tujuan Asuhan Kebidanan Masa Nifas .....                                  | 3          |
| E. Latihan Soal.....                                                         | 4          |
| F. Rangkuman.....                                                            | 7          |
| G. Glosarium.....                                                            | 8          |
| H. Daftar Pustaka.....                                                       | 9          |
| <br>                                                                         |            |
| <b>Bab 2 Perubahan Fisiologis dan Psikologis Pada Masa Nifas.....</b>        | <b>10</b>  |
| A. Perubahan Sistem Reproduksi pada Masa Nifas.....                          | 12         |
| B. Perubahan Sistem Kardiovaskular, Respirasi, Metabolik, dan Hormonal ..... | 15         |
| C. Perubahan Psikologis dan Emosional Ibu .....                              | 16         |
| D. Adaptasi Ibu terhadap Peran Baru sebagai Ibu .....                        | 17         |
| E. Latihan Soal.....                                                         | 19         |
| F. Rangkuman.....                                                            | 22         |
| G. Glosarium.....                                                            | 23         |
| H. Daftar Pustaka.....                                                       | 26         |
| <br>                                                                         |            |
| <b>Bab 3 Pemeriksaan dan Pengkajian Pada Masa Nifas .....</b>                | <b>27</b>  |
| A. Pemeriksaan Fisik Ibu Nifas.....                                          | 28         |
| B. Penilaian Tanda Vital dan Status Umum pada Ibu Nifas.....                 | 31         |
| C. Pemeriksaan Payudara dan Proses Menyusui .....                            | 34         |
| D. Pemeriksaan Kesehatan Mental Ibu Nifas .....                              | 37         |
| E. Pengkajian Kebutuhan Edukasi dan Dukungan Sosial pada Ibu Nifas.....      | 39         |
| F. Latihan Soal.....                                                         | 40         |
| G. Rangkuman Materi.....                                                     | 44         |
| H. Glosarium.....                                                            | 46         |
| I. Daftar Pustaka.....                                                       | 47         |

|                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bab 4 Perawatan dan Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas.....</b>                               | <b>49</b>  |
| A. Manajemen Perdarahan Nifas Normal dan Abnormal (Pencegahan dan Penanganan).....             | 50         |
| B. Perawatan Luka Bekas Persalinan (Perineum, Episiotomi, Operasi Sesar) .....                 | 52         |
| C. Dukungan dan Promosi Menyusui (Inisiasi Menyusui Dini, Teknik Menyusui, ASI Eksklusif)..... | 54         |
| D. Nutrisi pada Masa Nifas .....                                                               | 55         |
| E. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Nifas (Infeksi, Trombosis, Depresi Postpartum) .....   | 57         |
| F. Latihan Soal.....                                                                           | 59         |
| G. Rangkuman Materi.....                                                                       | 62         |
| H. Glosarium.....                                                                              | 64         |
| I. Daftar Pustaka.....                                                                         | 66         |
| <br><b>Bab 5 Edukasi dan Konseling Pada Masa Nifas .....</b>                                   | <b>67</b>  |
| A. Edukasi tentang Perawatan Diri dan Kebersihan Personal pada Ibu Nifas .....                 | 68         |
| B. Tanda-tanda Bahaya yang Harus Diwaspadai pada Ibu Nifas.....                                | 69         |
| C. Perencanaan Keluarga dan Konseling Kontrasepsi Postpartum.....                              | 70         |
| D. Dukungan Psikososial dan Pencegahan Depresi Postpartum .....                                | 72         |
| E. Edukasi tentang Perawatan Bayi Baru Lahir dan Imunisasi .....                               | 73         |
| F. Latihan Soal.....                                                                           | 75         |
| G. Rangkuman Materi.....                                                                       | 78         |
| H. Glosarium.....                                                                              | 79         |
| I. Daftar Pustaka.....                                                                         | 80         |
| <br><b>Bab 6 Komplikasi Masa Nifas dan Manajemen Keperawatan.....</b>                          | <b>82</b>  |
| A. Hemoragi Postpartum (PPH) dan Tindakan Emergensi .....                                      | 84         |
| B. Infeksi Postpartum (Endometritis, Mastitis, Luka Operasi) .....                             | 86         |
| C. Depresi dan Gangguan Mental Postpartum .....                                                | 88         |
| D. Pembekuan Darah dan Tromboemboli .....                                                      | 90         |
| E. Komplikasi Lain yang Mungkin Terjadi.....                                                   | 92         |
| F. Latihan Soal.....                                                                           | 94         |
| G. Rangkuman Materi.....                                                                       | 96         |
| H. Glosarium.....                                                                              | 99         |
| I. Daftar Pustaka.....                                                                         | 100        |
| <br><b>Bab 7 Peran Bidan Dalam Tim Kesehatan Masa Nifas .....</b>                              | <b>101</b> |
| A. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain .....                                               | 103        |
| B. Pendokumentasian Asuhan Nifas .....                                                         | 104        |

|                                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| C. Rujukan dan Tindak Lanjut Pasien dengan Risiko Tinggi.....                            | 106        |
| D. Pengembangan Kebijakan dan Program Kesehatan Maternal .....                           | 108        |
| E. Latihan Soal.....                                                                     | 110        |
| F. Rangkuman Materi.....                                                                 | 113        |
| G. Glosarium.....                                                                        | 115        |
| H. Daftar Pustaka.....                                                                   | 116        |
| <b>Bab 8 Aspek Etik, Legal, dan Budaya dalam Asuhan Nifas .....</b>                      | <b>118</b> |
| A. Hak Ibu Nifas dalam Pelayanan Kesehatan .....                                         | 119        |
| B. Penghormatan terhadap Kepercayaan dan Budaya Lokal terkait Nifas .....                | 120        |
| C. Privasi dan Kerahasiaan Pasien .....                                                  | 121        |
| D. Etika dalam Edukasi dan Konseling Nifas .....                                         | 122        |
| E. Latihan Soal.....                                                                     | 123        |
| F. Rangkuman Materi.....                                                                 | 127        |
| G. Glosarium.....                                                                        | 129        |
| H. Daftar Pustaka.....                                                                   | 130        |
| <b>Bab 9 Evaluasi dan Dokumentasi Asuhan Nifas .....</b>                                 | <b>131</b> |
| A. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan.....                                                  | 133        |
| B. Dokumentasi yang diperlukan Selama dan Setelah Masa Nifas .....                       | 134        |
| C. Penggunaan Alat Ukur dan Instrumen Evaluasi .....                                     | 135        |
| D. Latihan Soal.....                                                                     | 136        |
| E. Rangkuman Materi.....                                                                 | 140        |
| F. Glosarium.....                                                                        | 142        |
| G. Daftar Pustaka.....                                                                   | 144        |
| <b>Bab 10 Konsep Tren dan Isu Terkini Dalam Asuhan Nifas .....</b>                       | <b>145</b> |
| A. Digitalisasi dan Telehealth dalam Asuhan Nifas.....                                   | 147        |
| B. Pendekatan Berbasis Bukti ( <i>Evidence-Based Practice</i> ) dalam Asuhan Nifas ..... | 148        |
| C. Fokus pada Kesehatan Mental Ibu selama Masa Nifas.....                                | 150        |
| D. Integrasi Layanan Nifas dengan Keluarga dan Komunitas .....                           | 151        |
| E. Peran Menyusui dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dalam Asuhan Nifas .....              | 151        |
| F. Isu Kesetaraan Akses Pelayanan.....                                                   | 152        |
| G. Latihan Soal.....                                                                     | 153        |
| H. Rangkuman Materi.....                                                                 | 157        |
| I. Rangkuman Materi.....                                                                 | 159        |
| J. Daftar Pustaka.....                                                                   | 161        |

# Bab 1

## Konsep Dasar Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode penting dalam siklus reproduksi perempuan yang dimulai setelah kelahiran plasenta hingga organ-organ reproduksi kembali ke kondisi semula sebelum hamil. Periode ini membutuhkan perhatian khusus karena berbagai perubahan fisiologis, anatomis, serta psikologis yang terjadi pada ibu. Pemahaman tentang konsep dasar nifas sangat penting bagi bidan dan tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan kebidanan yang efektif dan aman guna meningkatkan kualitas hidup ibu serta mencegah komplikasi postpartum.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan yang berkualitas selama masa nifas dengan pemahaman mendalam tentang definisi, fisiologi, durasi, fase nifas, serta tujuan utama asuhan nifas.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan definisi dan pengertian masa nifas dengan tepat.
2. Menguraikan secara rinci perubahan anatomis dan fisiologis selama masa nifas.
3. Mengidentifikasi durasi dan fase-fase dalam masa nifas secara jelas.
4. Menguraikan tujuan asuhan kebidanan pada masa nifas.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

1. Mengidentifikasi berbagai definisi dan konsep dasar nifas.
2. Menjelaskan perubahan fisiologis dan anatomis ibu secara terperinci selama masa nifas.
3. Membagi dan menjelaskan secara sistematis durasi serta fase-fase masa nifas (*early postpartum*, *middle postpartum*, dan *late postpartum*).
4. Merumuskan tujuan utama dalam memberikan asuhan kebidanan masa nifas.



## A. Definisi Masa Nifas

Masa nifas atau puerperium adalah periode kritis pemulihan dan adaptasi pascapersalinan yang dimulai sejak keluarnya plasenta hingga organ reproduksi ibu kembali ke kondisi normal sebelum hamil. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari setelah persalinan. Masa ini sangat penting karena adanya berbagai risiko komplikasi yang memerlukan pemantauan intensif dari tenaga kesehatan profesional, khususnya bidan.

Lebih dalam, masa nifas merupakan fase transisi kompleks yang mencakup perubahan fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Selama periode ini, ibu mengalami proses pemulihan signifikan yang bertujuan mengembalikan tubuh pada fungsi sebelum kehamilan, sekaligus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai seorang ibu. Proses adaptasi ini membawa tantangan emosional seperti rasa bahagia bercampur dengan kecemasan, kelelahan, hingga kemungkinan mengalami gangguan psikologis seperti baby blues dan depresi postpartum.

Selain itu, risiko komplikasi postpartum seperti perdarahan hebat, infeksi, gangguan psikologis, dan masalah produksi ASI memerlukan pemantauan intensif dan intervensi cepat oleh tenaga kesehatan. Dengan memahami konsep dan definisi dasar ini secara komprehensif, tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan optimal guna mendukung pemulihan yang lancar dan meningkatkan kesehatan ibu serta bayinya.

## B. Fisiologi dan Perubahan Anatomis serta Fisiologis Masa Nifas

Pada masa nifas, tubuh ibu mengalami perubahan anatomi dan fisiologi yang kompleks. Berikut penjelasannya:

### 1. Perubahan Anatomis:

- **Involusi Uterus:** Rahim berkontraksi dan mengecil secara bertahap kembali ke ukuran sebelum hamil selama kurang lebih 6 minggu. Palpasi uterus secara rutin penting untuk memastikan proses involusi berjalan normal.
- **Lochia:** Cairan yang keluar dari vagina selama masa nifas. Lochia mengalami perubahan bertahap, dari lochia rubra (merah terang dalam 3-4 hari pertama), lochia serosa (merah kecoklatan hingga hari ke-10), hingga lochia alba (putih kekuningan hingga minggu ke-6).

### 2. Perubahan Fisiologis:

- **Hormonal:** Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron secara drastis setelah persalinan, sementara hormon prolaktin meningkat signifikan untuk merangsang produksi ASI.

- Kardiovaskular: Penyesuaian volume darah ke kondisi pra-kehamilan, sering ditandai dengan peningkatan diuresis (produksi urin) untuk menghilangkan kelebihan cairan tubuh selama kehamilan.
- Sistem Pencernaan dan Perkemihan: Fungsi usus dan kandung kemih kembali normal secara bertahap, namun ibu mungkin mengalami sembelit atau kesulitan buang air kecil sementara waktu.

### C. Durasi dan Fase Masa Nifas

Masa nifas secara umum berlangsung selama 6 minggu (42 hari) pascapersalinan dan terbagi menjadi tiga fase utama, yang masing-masing memiliki karakteristik fisiologis dan kebutuhan perawatan berbeda. Pemahaman terhadap pembagian fase ini sangat penting agar bidan dan tenaga kesehatan dapat memberikan pendekatan asuhan yang tepat.

1. Early Postpartum (0-24 jam)
  - Merupakan periode kritis setelah persalinan, dengan risiko tinggi perdarahan postpartum.
  - Diperlukan pemantauan intensif, terutama terhadap kontraksi uterus dan jumlah perdarahan.
  - Tindakan pencegahan seperti pemberian uterotonika dan observasi lochia secara berkala sangat dianjurkan
2. Middle Postpartum (24 jam - 7 hari)
  - Merupakan periode adaptasi dini dengan perubahan signifikan fisik dan fisiologis.
  - Fokus pada involusi rahim, manajemen nyeri postpartum, produksi ASI, dan mobilisasi dini ibu.
3. Late Postpartum (7 hari - 42 hari)
  - Merupakan periode lanjutan di mana organ reproduksi secara bertahap kembali ke kondisi semula.
  - Edukasi dan dukungan psikologis diperlukan untuk adaptasi peran ibu, perawatan bayi, dan perencanaan keluarga.

### D. Tujuan Asuhan Kebidanan Masa Nifas

Asuhan kebidanan masa nifas bertujuan holistik dalam memastikan kesejahteraan ibu dan bayi dengan tujuan utama:

- Pemulihan Fisik Optimal: Mendeteksi dini komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan involusi rahim.
- Dukungan Psikologis dan Emosional: Mengidentifikasi risiko gangguan emosional, memberikan dukungan dan intervensi awal bila diperlukan.

- Pemberian ASI Eksklusif: Mendukung ibu dalam inisiasi dini menyusui, edukasi teknik menyusui, serta memantau kecukupan ASI.
- Edukasi Perawatan Bayi Baru Lahir: Memberikan informasi tentang teknik perawatan bayi yang benar, pencegahan infeksi, dan imunisasi dasar.
- Konseling Perencanaan Keluarga: Memberikan edukasi tentang pilihan kontrasepsi pascapersalinan untuk mengatur jarak kehamilan berikutnya secara efektif.

Dengan memahami secara rinci konsep dan praktik masa nifas, tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, holistik, dan berbasis bukti. Hal ini secara signifikan akan membantu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu postpartum serta memastikan adaptasi keluarga berjalan dengan lancar.

## E. Latihan Soal

### Soal Tugas

#### **Tugas 1: Analisis Studi Kasus Masa Nifas**

Mahasiswa diminta untuk menganalisis studi kasus seorang ibu pascapersalinan yang mengalami perdarahan postpartum. Mahasiswa harus mengidentifikasi fase nifas yang sedang dialami, faktor risiko yang mungkin memengaruhi kondisi ibu, serta menyusun langkah intervensi kebidanan yang sesuai berdasarkan fase tersebut.

#### **Tugas 2: Penjelasan Perubahan Fisiologis dan Anatomis Masa Nifas**

Mahasiswa diminta membuat laporan tertulis yang menjelaskan secara rinci perubahan fisiologis dan anatomis yang terjadi selama masa nifas, termasuk proses involusi uterus, perubahan hormon, dan lochia. Laporan juga harus mencakup dampak perubahan tersebut terhadap perawatan ibu pascapersalinan.

#### **Tugas 3: Penyusunan Rencana Asuhan Kebidanan Masa Nifas**

Mahasiswa menyusun rencana asuhan kebidanan holistik untuk ibu dalam fase middle postpartum, dengan fokus pada pemantauan involusi uterus, produksi ASI, dan pengelolaan nyeri postpartum. Rencana harus meliputi tindakan pencegahan komplikasi dan edukasi untuk ibu.

#### **Tugas 4: Presentasi Edukasi Dukungan Psikologis Masa Nifas**

Mahasiswa membuat dan mempresentasikan materi edukasi yang berfokus pada pentingnya dukungan psikologis dan sosial selama masa late postpartum, termasuk cara mengenali tanda-tanda depresi postpartum dan strategi mendukung adaptasi ibu dan keluarga.

### **Tugas 5: Diskusi Kelompok tentang Tujuan Asuhan Kebidanan Masa Nifas**

Mahasiswa dibagi menjadi kelompok dan melakukan diskusi mendalam mengenai tujuan utama asuhan kebidanan selama masa nifas. Setiap kelompok harus memaparkan bagaimana asuhan tersebut dapat mencegah komplikasi, mendukung ASI eksklusif, dan membantu adaptasi ibu secara fisik dan psikologis.

#### **Pilihan Ganda**

---

1. Seorang ibu baru melahirkan anak pertamanya 12 jam yang lalu. Ia mengalami perdarahan ringan dan lochia berwarna merah segar. Apa fase nifas yang sedang dialami ibu tersebut?
  - a. Early postpartum (0-24 jam)
  - b. Middle postpartum (24 jam - 7 hari)
  - c. Late postpartum (7-42 hari)
  - d. Masa kehamilan
  - e. Masa menyusui
  
2. Ibu yang baru melahirkan 10 hari yang lalu datang untuk kontrol. Ia melaporkan adanya nyeri di daerah rahim dan keluarnya cairan keputihan dari vagina. Apa warna lochia yang paling mungkin dialami ibu saat ini?
  - a. Lochia rubra
  - b. Lochia serosa
  - c. Lochia alba
  - d. Tidak ada lochia
  - e. Darah menstruasi
  
3. Seorang ibu pascapersalinan mengalami penurunan kadar estrogen dan progesteron, serta peningkatan prolaktin. Apa efek fisiologis utama dari perubahan hormon tersebut?
  - a. Terjadinya kontraksi uterus yang intens
  - b. Meningkatkan produksi ASI
  - c. Menghambat pengeluaran lochia
  - d. Mempercepat proses involusi uterus
  - e. Menurunkan tekanan darah
  
4. Ibu yang baru melahirkan 3 hari yang lalu melaporkan merasa sedih dan mudah menangis, tapi tidak memiliki gejala psikotik. Apa kemungkinan diagnosis psikologis yang paling sesuai untuk kondisi ini?

- a. Depresi postpartum berat
  - b. Baby blues
  - c. Gangguan kecemasan umum
  - d. Psikosis postpartum
  - e. Stres akut
5. Dalam fase middle postpartum, bidan memberikan edukasi kepada ibu tentang pentingnya memantau tanda-tanda komplikasi. Manakah dari tanda berikut yang merupakan gejala komplikasi yang harus segera ditindaklanjuti?
- a. Lochia berwarna keputihan (lochia alba)
  - b. Nyeri perineum ringan yang membaik setiap hari
  - c. Demam di atas 38°C selama 2 hari berturut-turut
  - d. Produksi ASI yang meningkat secara bertahap
  - e. Kontraksi uterus yang terasa normal dan teratur

### Kunci Jawaban

---

1. Kunci jawaban: a. Early postpartum (0-24 jam)

Pembahasan:

Fase early postpartum berlangsung sejak persalinan hingga 24 jam setelahnya, ditandai dengan perdarahan ringan dan lochia rubra (merah segar), serta pemantauan ketat terhadap risiko perdarahan postpartum.

2. Kunci jawaban: c. Lochia alba

Pembahasan:

Pada fase late postpartum (7-42 hari), lochia biasanya berwarna keputihan atau putih kekuningan yang disebut lochia alba, menandakan proses penyembuhan rahim yang sedang berlangsung.

3. Kunci jawaban: b. Meningkatkan produksi ASI

Pembahasan:

Penurunan estrogen dan progesteron serta peningkatan prolaktin selama masa nifas mendukung produksi ASI sebagai persiapan pemberian ASI eksklusif kepada bayi baru lahir.

4. Kunci jawaban: b. Baby blues

Pembahasan:

Baby blues adalah kondisi emosional yang umum dialami ibu pascapersalinan dengan gejala sedih, mudah menangis, dan mood yang berubah-ubah, biasanya bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi ibu secara signifikan.



5. Kunci jawaban: c. Demam di atas 38°C selama 2 hari berturut-turut

Pembahasan:

Demam tinggi berkepanjangan dapat mengindikasikan infeksi postpartum dan memerlukan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi serius.

## F. Rangkuman

Masa nifas adalah periode pemulihan dan adaptasi yang dimulai sejak keluarnya plasenta hingga organ reproduksi ibu kembali ke kondisi sebelum kehamilan, yang berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari setelah persalinan menurut WHO. Periode ini sangat penting karena melibatkan risiko komplikasi yang memerlukan pemantauan intensif oleh tenaga kesehatan. Masa nifas merupakan fase transisi kompleks yang mencakup perubahan fisik, psikologis, dan sosial, di mana tubuh ibu kembali pulih dari proses persalinan dan kehamilan selama sembilan bulan. Selain itu, ibu juga harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai seorang ibu, yang membawa tantangan emosional dan psikologis tersendiri. Komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas seperti perdarahan, infeksi, gangguan psikologis seperti baby blues dan depresi postpartum, serta masalah dalam produksi ASI memerlukan intervensi segera dan pemantauan oleh tenaga kesehatan agar pemulihan berlangsung optimal dan kesehatan ibu serta bayi tetap terjaga.

Secara fisiologis dan anatomis, selama masa nifas rahim mengalami involusi untuk kembali ke ukuran normal sebelum hamil, yang biasanya memakan waktu sekitar enam minggu. Cairan lochia yang keluar dari vagina berubah warna dari merah (lochia rubra), menjadi merah kecoklatan (lochia serosa), hingga keputihan (lochia alba). Perubahan hormonal yang signifikan juga terjadi, dengan penurunan kadar estrogen dan progesteron serta peningkatan prolaktin untuk mendukung produksi ASI. Sistem kardiovaskular juga mengalami penyesuaian seperti perubahan volume darah, yang mendukung proses pemulihan serta persiapan menyusui dan perawatan bayi baru lahir.

Durasi masa nifas terbagi menjadi tiga fase utama. Fase awal (early postpartum) berlangsung dari 0 hingga 24 jam setelah persalinan dan merupakan periode kritis dengan risiko komplikasi seperti perdarahan yang tinggi sehingga memerlukan pemantauan ketat. Fase tengah (middle postpartum) berlangsung dari 24 jam hingga 7 hari, di mana ibu mulai beradaptasi dengan perubahan fisiologis dan anatomis yang signifikan, dengan perhatian khusus pada involusi uterus, produksi ASI, dan pengelolaan nyeri. Fase akhir (late postpartum) terjadi antara 7 hingga 42 hari setelah persalinan, merupakan periode adaptasi lanjutan di mana organ reproduksi kembali

secara bertahap ke kondisi sebelum kehamilan dan ibu membutuhkan dukungan psikologis serta edukasi tentang perawatan bayi dan perencanaan keluarga.

Tujuan utama asuhan kebidanan pada masa nifas adalah memastikan pemulihan fisik, psikologis, dan sosial ibu setelah persalinan dengan cara mencegah dan mendeteksi komplikasi secara dini. Selain itu, asuhan kebidanan bertujuan mendukung pemberian ASI eksklusif dan memberikan edukasi tentang perawatan bayi baru lahir serta perencanaan keluarga. Dukungan emosional dan psikologis juga sangat penting untuk memastikan adaptasi yang lancar bagi ibu dan keluarganya. Pemahaman yang baik terhadap konsep dasar masa nifas ini sangat penting agar tenaga kesehatan, terutama bidan, dapat memberikan asuhan yang efektif dan holistik serta berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu postpartum.

## G. Glosarium

**Baby blues:** Kondisi psikologis ringan yang dialami oleh ibu setelah persalinan, ditandai oleh perubahan suasana hati yang tiba-tiba, rasa sedih tanpa alasan jelas, kecemasan, dan mudah menangis. Biasanya terjadi dalam beberapa hari pertama hingga dua minggu setelah melahirkan dan tidak memerlukan pengobatan khusus, cukup dengan dukungan emosional dari keluarga.

**Depresi postpartum:** Gangguan mood serius yang dialami oleh ibu setelah persalinan, ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dan energi dalam aktivitas sehari-hari, sulit tidur atau tidur berlebihan, perubahan nafsu makan, perasaan tidak mampu merawat bayi, hingga pikiran negatif tentang diri sendiri atau bayi. Kondisi ini memerlukan intervensi medis dan psikologis yang tepat.

**Involusi uterus:** Proses alami di mana rahim mengecil secara bertahap dan kembali ke ukuran serta posisi sebelum kehamilan. Proses ini berlangsung sekitar enam minggu setelah persalinan, ditandai oleh kontraksi uterus yang kuat, penurunan tinggi fundus uteri, serta penurunan volume uterus.

**Lochia:** Cairan vagina yang keluar selama masa nifas, terdiri dari darah, jaringan endometrium, lendir serviks, dan bakteri. Lochia mengalami perubahan bertahap dari lochia rubra (merah terang, 3-4 hari pertama), lochia serosa (merah kecoklatan, hingga hari ke-10), dan lochia alba (putih kekuningan, hingga minggu ke-6).

**Masa nifas:** Periode kritis pascapersalinan yang berlangsung selama 6 minggu atau sekitar 42 hari, dimulai dari keluarnya plasenta hingga organ reproduksi ibu kembali ke kondisi sebelum hamil. Pada masa ini, ibu mengalami berbagai proses pemulihan fisik dan adaptasi emosional serta sosial.

**Pemantauan intensif:** Pengawasan ketat dan terus-menerus oleh tenaga kesehatan terhadap kondisi ibu setelah persalinan untuk mendeteksi komplikasi dini seperti perdarahan postpartum, infeksi, gangguan psikologis, dan masalah produksi ASI. Pemantauan intensif ini mencakup evaluasi tanda vital, pemeriksaan involusi uterus, dan observasi kondisi umum ibu.

**Plasenta:** Organ vital yang terbentuk selama kehamilan, berfungsi sebagai media pertukaran oksigen, nutrisi, serta zat sisa antara ibu dan janin. Plasenta keluar setelah bayi lahir dalam proses yang dikenal sebagai pelepasan plasenta atau kala tiga persalinan.

**Produksi ASI:** Proses fisiologis pembentukan air susu ibu, yang dikendalikan oleh hormon prolaktin, oksitosin, serta faktor emosional ibu. Produksi ASI dimulai segera setelah melahirkan, diawali dengan kolostrum yang kaya antibodi, lalu berkembang menjadi ASI matang dalam beberapa hari berikutnya.

**Preeklamsia:** Kondisi komplikasi serius pada masa kehamilan, persalinan, atau nifas, yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein dalam urin, pembengkakan pada wajah dan tangan, serta gangguan organ seperti ginjal atau hati. Preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia yang lebih serius jika tidak segera ditangani.

**Risiko komplikasi postpartum:** Potensi berbagai gangguan kesehatan yang muncul setelah melahirkan, seperti perdarahan hebat, infeksi luka persalinan, infeksi saluran kemih, mastitis (radang payudara), gangguan psikologis seperti depresi postpartum, dan kesulitan produksi ASI. Penting bagi tenaga kesehatan melakukan pemantauan ketat untuk deteksi dini dan penanganan segera guna mengurangi risiko komplikasi ini.

## H. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Postpartum care. *ACOG Practice Bulletin No. 183. Obstetrics & Gynecology*, 130(4), e208–e220. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002351>
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2016). *Maternity & women's health care* (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on maternal health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/260170>
- Pillitteri, A. (2017). *Maternal & child health nursing: Care of the childbearing and childrearing family* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Grady, M. A., & Bloom, K. C. (2004). Postpartum maternal health care in the United States: A critical review. *Journal of Perinatal & Neonatal Nursing*, 18(4), 385–405. <https://doi.org/10.1097/00005237-200410000-00006>

# Bab 2

## Perubahan Fisiologis dan Psikologis Pada Masa Nifas

Masa nifas adalah periode krusial yang dimulai setelah persalinan, di mana tubuh ibu mengalami berbagai proses pemulihan dan adaptasi fisik serta psikologis. Perubahan signifikan terjadi pada sistem reproduksi, termasuk involusi rahim, serta penyesuaian pada serviks dan vagina. Selain itu, sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan hormonal juga mengalami adaptasi penting selama periode ini. Perubahan psikologis dan emosional seperti postpartum blues dan depresi postpartum sering muncul, mempengaruhi kesejahteraan ibu dan interaksinya dengan bayi. Adaptasi ibu terhadap peran barunya sebagai orang tua menjadi aspek yang tidak kalah penting, memerlukan dukungan serta pemahaman dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang perubahan fisiologis dan psikologis selama masa nifas sangat penting untuk memberikan asuhan kebidanan yang optimal dan holistik.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, lulusan diharapkan mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif dan responsif terhadap perubahan fisiologis dan psikologis pada masa nifas, serta mendukung adaptasi ibu dalam menjalani peran baru sebagai orang tua.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan secara terperinci perubahan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi selama masa nifas.
2. Menguraikan penyesuaian sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan hormonal pada ibu pascapersalinan.
3. Mengidentifikasi dan membedakan gejala postpartum blues dan depresi postpartum serta implikasinya terhadap ibu dan keluarga.
4. Menjelaskan proses adaptasi psikologis ibu terhadap peran baru dan strategi pendukung yang efektif.

**Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu:

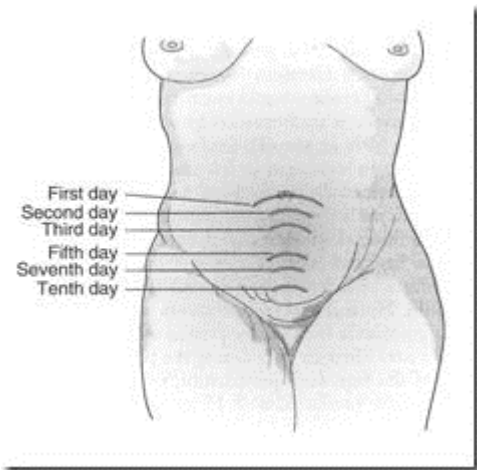
1. Memaparkan proses involusi uterus, perubahan pada serviks dan vagina selama masa nifas.
2. Mendeskripsikan perubahan fisiologis sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan hormonal secara komprehensif.
3. Menguraikan tanda-tanda postpartum blues dan depresi postpartum serta cara penanganannya.
4. Menjelaskan pentingnya dukungan psikososial dan cara membantu ibu beradaptasi dengan peran baru sebagai ibu.

## A. Perubahan Sistem Reproduksi pada Masa Nifas

### 1. Perubahan Uterus (Rahim)

Uterus merupakan organ yang mengalami perubahan paling dramatis selama masa nifas. Setelah melahirkan, uterus yang membesar secara signifikan selama kehamilan akan menjalani proses involusi, yaitu proses pengecilan secara bertahap kembali ke ukuran sebelum kehamilan.

Pada akhir kehamilan, berat uterus sekitar 1000 gram, dan ukurannya membesar hingga 20 kali lipat dibandingkan sebelum kehamilan. Setelah persalinan, terutama setelah keluarnya plasenta, uterus mulai berkontraksi kuat guna menghentikan perdarahan dan mengecilkan ukurannya. Pada hari pertama nifas, tinggi fundus uteri berada sekitar setinggi pusar (umbilikus). Selanjutnya, fundus uterus turun sekitar 1 cm per hari sehingga pada minggu kedua postpartum, uterus tidak lagi teraba di atas simfisis pubis. Akhir masa nifas, uterus memiliki berat sekitar 50–70 gram dan telah kembali sepenuhnya ke panggul kecil.



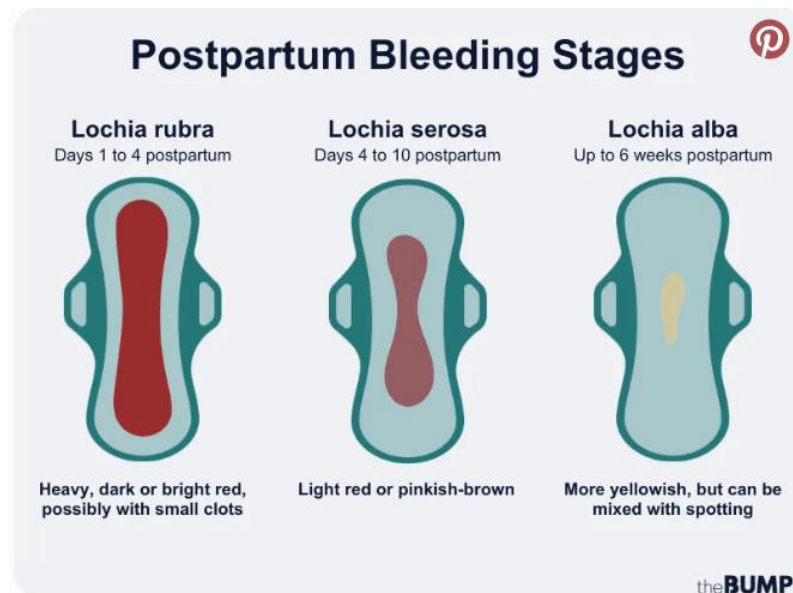
**Gambar 2.1 Tinggi fundus uteri**

Sumber: <https://lusa.afkar.id/perubahan-fisiologis-masa-nifas-pada-sistem-reproduksi-bagian-1>

Proses involusi uterus sangat dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang dilepaskan selama menyusui. Inilah alasan ibu menyusui sering merasakan nyeri ringan saat uterus berkontraksi (afterpain). Nyeri ini biasanya lebih terasa pada multipara (ibu yang sudah beberapa kali melahirkan) dibanding primipara (ibu pertama kali melahirkan). Selain itu, uterus juga mengalami proses regenerasi lapisan endometrium. Endometrium akan mengalami penyembuhan dan regenerasi secara bertahap, dimulai dari tempat implantasi plasenta. Selama proses ini, ibu akan mengalami keluarnya cairan vagina yang disebut lochia, yang berasal dari jaringan endometrium yang meluruh.

### 2. Proses Lochia

Lochia merupakan cairan vagina yang mengandung darah, mukus, jaringan plasenta, serta lapisan endometrium yang meluruh. Lochia mengalami perubahan dalam beberapa tahap:



**Gambar 2.2 Tahapan Perdarahan Pascapersalinan**

Sumber: <https://www.thebump.com/a/postpartum-bleeding>

- **Lochia rubra (1–3 hari postpartum)**

Cairan merah terang mengandung darah segar, potongan jaringan, dan sel darah merah.

- **Lochia serosa (4–10 hari postpartum)**

Cairan menjadi lebih tipis, berwarna merah muda atau coklat muda, mengandung sedikit darah, serum, leukosit, dan jaringan epitel.

- **Lochia alba (hari ke-10 hingga 6 minggu postpartum)**

Cairan putih atau kekuningan, terutama terdiri dari leukosit, mukus, sel epitel, dan bakteri normal.

Lochia yang tidak normal, seperti berbau busuk, perdarahan yang sangat deras, atau berwarna hijau kekuningan dapat menjadi tanda infeksi atau komplikasi yang membutuhkan perhatian segera.

### 3. Perubahan Serviks (Leher Rahim)

Selama persalinan, serviks mengalami dilatasi penuh sekitar 10 cm. Setelah persalinan, serviks mulai menutup secara bertahap. Dalam 24 jam pertama, serviks sudah menutup sebagian, namun masih dapat dilewati oleh dua jari. Pada hari ke-7 pascapersalinan, serviks umumnya sudah menyempit kembali menjadi kurang dari 1 cm. Meskipun ukuran serviks kembali mengecil, teksturnya tidak kembali sepenuhnya seperti sebelum kehamilan. Serviks setelah persalinan menjadi lebih lunak dan elastis, serta bentuk mulut serviks yang semula berbentuk bundar sempurna berubah menjadi bentuk seperti celah atau garis transversal permanen.



Perubahan serviks ini berperan dalam proses regenerasi dan mencegah infeksi dari vagina ke uterus selama masa nifas. Pemantauan serviks yang cermat sangat penting untuk mendeteksi komplikasi seperti infeksi atau perdarahan.

#### **4. Perubahan Vagina**

Vagina mengalami perubahan besar selama kehamilan dan persalinan, dengan tujuan mempersiapkan jalannya bayi saat proses persalinan. Selama kehamilan, vagina mengalami hiperemia (peningkatan aliran darah), sehingga dinding vagina menjadi lebih lunak, elastis, dan berwarna lebih gelap akibat vaskularisasi yang meningkat. Setelah persalinan, vagina akan menjalani proses involusi atau pengecilan secara bertahap. Dinding vagina mulai menebal kembali, dan rongga vagina mulai menyempit. Namun, vagina tidak pernah benar-benar kembali ke ukuran semula seperti sebelum persalinan, terutama pada wanita multipara. Proses ini berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan setelah persalinan.

Perubahan hormonal selama nifas, terutama penurunan estrogen, menyebabkan vagina menjadi lebih kering dibandingkan sebelumnya, terutama pada ibu menyusui. Kondisi ini sering menimbulkan rasa tidak nyaman atau nyeri saat berhubungan seksual (dispareunia). Karena itu, konseling tentang perawatan vagina serta edukasi tentang penggunaan pelumas yang aman menjadi bagian penting dalam asuhan kebidanan.

#### **5. Pemantauan dan Asuhan Kebidanan**

Pengetahuan tentang perubahan fisiologis sistem reproduksi ini penting bagi bidan dalam memantau pemulihan ibu selama masa nifas. Bidan harus rutin melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara mengenai gejala yang dialami ibu, seperti perdarahan abnormal, nyeri berlebih, bau tidak sedap, demam, atau tanda infeksi lainnya.

Pendidikan kesehatan tentang kebersihan alat genital, perawatan luka (jika ada jahitan perineum), dan tanda bahaya nifas harus diberikan kepada ibu untuk mencegah komplikasi. Pemantauan proses involusi uterus, karakteristik lochia, kondisi serviks, dan vagina sangat penting guna memastikan proses pemulihan berjalan lancar dan sehat.

## **B. Perubahan Sistem Kardiovaskular, Respirasi, Metabolik, dan Hormonal**

### **1. Postpartum Blues**

Postpartum blues merupakan kondisi emosional sementara yang dialami oleh sebagian besar ibu setelah persalinan. Gejala yang muncul meliputi perubahan mood yang cepat, mudah menangis, perasaan cemas, lelah, dan perasaan tertekan yang umumnya berlangsung selama beberapa hari hingga dua minggu pascapersalinan. Kondisi ini biasanya ringan dan tidak mengganggu kemampuan ibu untuk merawat bayi atau menjalani aktivitas sehari-hari. Postpartum blues disebabkan oleh fluktuasi hormonal serta perubahan psikososial yang cepat selama masa nifas.

### **2. Depresi Postpartum**

Jika gejala emosional yang mirip postpartum blues berlangsung lebih lama, intens, dan menyebabkan gangguan signifikan pada fungsi sosial dan emosional ibu, maka kemungkinan besar ibu mengalami depresi postpartum. Depresi postpartum adalah gangguan mood klinis yang serius dengan tanda-tanda seperti perasaan sedih mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya menyenangkan, gangguan tidur, nafsu makan menurun, rasa bersalah berlebihan, hingga pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi. Kondisi ini memerlukan intervensi medis dan psikologis yang tepat.

Depresi postpartum dapat mengganggu bonding antara ibu dan bayi, mempengaruhi perkembangan emosional dan kognitif bayi, serta berdampak pada kesehatan mental ibu dalam jangka panjang. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan cepat sangat penting untuk meminimalkan dampak negatifnya.

### **3. Faktor Risiko dan Pencegahan**

Berbagai faktor dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan psikologis pascapersalinan, termasuk riwayat depresi, kurangnya dukungan sosial, stres berat selama kehamilan atau persalinan, serta komplikasi medis. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi prenatal, dukungan keluarga dan komunitas, serta pemantauan rutin kesehatan mental ibu selama masa nifas.

### **4. Peran Tenaga Kesehatan**

Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda postpartum blues dan depresi postpartum melalui skrining rutin dan komunikasi terbuka dengan ibu. Memberikan dukungan emosional, konseling, serta rujukan ke tenaga profesional kesehatan mental merupakan bagian dari asuhan holistik yang dapat mempercepat pemulihan ibu dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

## C. Perubahan Psikologis dan Emosional Ibu

Perubahan emosional pada masa nifas terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan hormonal yang drastis, penyesuaian terhadap peran baru sebagai ibu, serta kondisi fisik yang belum sepenuhnya pulih pasca-persalinan. Berikut adalah rincian perubahan emosional yang umum terjadi:

### 1. Postpartum Blues

Postpartum blues atau "baby blues" adalah kondisi emosional ringan yang umum dialami oleh sekitar 50-85% ibu baru. Kondisi ini biasanya muncul dalam beberapa hari pertama setelah persalinan dan berlangsung sekitar dua minggu.

#### Gejala Umum Postpartum Blues:

- Perubahan suasana hati yang cepat dan fluktuatif
- Mudah menangis tanpa alasan jelas
- Merasa cemas dan khawatir berlebihan
- Merasa lelah secara fisik maupun mental
- Mudah tersinggung dan sulit tidur

#### Faktor Penyebab Postpartum Blues:

- Fluktuasi hormonal, terutama penurunan hormon estrogen dan progesteron
- Kelelahan fisik akibat persalinan dan perawatan bayi baru lahir
- Penyesuaian emosional terhadap peran baru sebagai ibu

### 2. Depresi Postpartum

Depresi postpartum adalah kondisi yang lebih serius dibanding postpartum blues. Diperkirakan sekitar 10-20% ibu mengalami kondisi ini. Gejala depresi postpartum berlangsung lebih lama, intens, dan dapat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari ibu secara signifikan.

#### Gejala Depresi Postpartum:

- Perasaan sedih yang mendalam dan terus-menerus
- Kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya menyenangkan
- Perasaan tidak berharga atau rasa bersalah berlebihan
- Gangguan tidur, seperti insomnia atau tidur berlebihan
- Kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan
- Pikiran negatif tentang diri sendiri atau bayi, bahkan pikiran menyakiti diri sendiri atau bayi

#### Faktor Risiko Depresi Postpartum:

- Riwayat gangguan mental sebelumnya (misalnya depresi atau kecemasan)
- Kurangnya dukungan sosial dari pasangan atau keluarga
- Pengalaman persalinan yang traumatis atau komplikasi selama kehamilan

- Stresor kehidupan seperti masalah ekonomi, konflik keluarga, atau kehilangan pekerjaan

### **3. Dampak Perubahan Psikologis terhadap Bonding Ibu-Bayi**

Perubahan psikologis yang dialami ibu pada masa nifas dapat mempengaruhi proses pembentukan ikatan emosional (bonding) dengan bayi. Gangguan psikologis seperti depresi postpartum dapat menyebabkan ibu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan emosional dengan bayinya. Hal ini bisa berdampak negatif terhadap perkembangan sosial, emosional, dan kognitif bayi dalam jangka panjang.

### **4. Strategi Penanganan dan Dukungan Psikologis**

Untuk membantu ibu melalui masa nifas dengan lebih baik, diperlukan pendekatan yang holistik dan dukungan psikologis yang komprehensif:

#### **a. Dukungan Sosial dan Keluarga**

- Menyediakan bantuan praktis seperti merawat bayi atau mengurus rumah tangga
- Memberikan dukungan emosional melalui komunikasi yang terbuka dan empati

#### **b. Konseling dan Intervensi Psikologis**

- Terapi kognitif-perilaku (Cognitive Behavioral Therapy - CBT)
- Terapi interpersonal (Interpersonal Psychotherapy - IPT)
- Konseling suportif dari tenaga profesional

#### **c. Intervensi Farmakologis**

Penggunaan obat antidepresan pada kasus depresi postpartum berat sesuai petunjuk medis dan pengawasan ketat dari tenaga kesehatan.

## **D. Adaptasi Ibu terhadap Peran Baru sebagai Ibu**

Ibu baru seringkali merasa cemas mengenai kemampuannya dalam merawat bayi. Pembelajaran tentang perawatan bayi yang benar adalah kunci untuk membangun kepercayaan diri ibu dalam menjalankan peran barunya.

### **1. Aspek Penting dalam Perawatan Bayi**

- Menyusui eksklusif dan teknik menyusui yang benar.
- Perawatan tali pusat dan kulit bayi agar terhindar dari infeksi.
- Teknik memandikan, mengganti popok, serta menjaga kebersihan bayi.
- Pemantauan tumbuh kembang bayi secara rutin.
- Menenangkan bayi yang menangis secara efektif.

### **2. Pengelolaan Waktu dan Rutinitas Harian**

Penyesuaian waktu dan manajemen rutinitas sehari-hari menjadi tantangan besar bagi ibu yang baru melahirkan. Ibu perlu mengembangkan strategi agar dapat menjalankan perannya secara efektif tanpa merasa kewalahan.

**Strategi Manajemen Waktu:**

- Membuat jadwal harian yang realistis dan fleksibel.
- Mengatur prioritas kegiatan sehari-hari berdasarkan kebutuhan bayi dan diri sendiri.
- Mengatur waktu istirahat yang cukup untuk pemulihan fisik dan mental.
- Memanfaatkan bantuan dari pasangan atau keluarga dalam tugas rumah tangga dan perawatan bayi.

**3. Adaptasi Peran Sosial dalam Keluarga dan Masyarakat**

Peran baru sebagai ibu membawa perubahan besar dalam dinamika sosial keluarga dan masyarakat. Ibu harus menavigasi perubahan ini dengan baik agar dapat mempertahankan keseimbangan hubungan sosial.

**Adaptasi Peran Sosial:**

- Komunikasi terbuka dengan pasangan tentang peran dan ekspektasi masing-masing.
- Membangun hubungan yang sehat dengan anggota keluarga lain agar mendapatkan dukungan emosional dan praktis.
- Menjaga interaksi sosial dengan teman dan komunitas untuk mengurangi perasaan isolasi.
- Memanfaatkan kelompok pendukung ibu baru untuk berbagi pengalaman dan dukungan sosial.

**4. Pentingnya Dukungan Keluarga dan Tenaga Kesehatan**

Dukungan yang kuat dari keluarga dan tenaga kesehatan sangat penting untuk membantu ibu melewati tantangan adaptasi ini.

**Peran Keluarga:**

- Memberikan dukungan emosional berupa empati, perhatian, dan penghargaan atas usaha ibu.
- Memberikan bantuan praktis dalam tugas-tugas domestik dan perawatan bayi.

**Peran Tenaga Kesehatan:**

- Memberikan edukasi komprehensif tentang perawatan bayi dan pemulihan ibu pasca-persalinan.
- Menyediakan konseling emosional dan psikologis untuk mendukung adaptasi mental ibu.
- Melakukan kunjungan rumah atau pemeriksaan rutin untuk memantau perkembangan kesehatan ibu dan bayi.

## E. Latihan Soal

### Tugas

#### **Tugas 1: Studi Kasus tentang Perubahan Fisik pada Masa Nifas**

- Mahasiswa diminta membuat laporan studi kasus tentang ibu nifas yang mengalami involusi uterus dan karakteristik lochia yang normal.
- Tugas mencakup pengkajian klinis secara mendalam, mencatat hasil observasi setiap hari hingga minggu kedua masa nifas, serta menganalisis apakah involusi uterus dan perubahan lochia berjalan sesuai tahapan normal yang telah dipelajari.

#### **Tugas 2: Penyusunan Leaflet Edukasi tentang Postpartum Blues dan Depresi Postpartum**

- Mahasiswa membuat leaflet edukasi yang menjelaskan tentang postpartum blues dan depresi postpartum secara singkat, jelas, dan menarik.
- Leaflet mencakup gejala, faktor risiko, perbedaan antara postpartum blues dan depresi postpartum, serta langkah penanganan dan pencegahan.
- Leaflet harus disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh ibu nifas dan keluarganya.

#### **Tugas 3: Role-play Intervensi Psikologis pada Ibu Nifas**

- Mahasiswa berkelompok melakukan simulasi role-play yang menunjukkan interaksi antara tenaga kesehatan (bidan/dokter) dan ibu nifas yang mengalami gejala depresi postpartum.
- Mahasiswa diminta mempraktikkan teknik komunikasi efektif, memberikan konseling suportif, serta menentukan kapan rujukan kepada profesional kesehatan mental harus diberikan.

#### **Tugas 4: Menyusun Rencana Jadwal Harian untuk Ibu Nifas**

- Mahasiswa membuat rencana jadwal harian yang realistis untuk ibu nifas dalam minggu pertama hingga keenam setelah melahirkan.
- Jadwal mencakup waktu istirahat, perawatan bayi (menyusui, mengganti popok, mandi bayi), serta aktivitas rutin ibu (makan, istirahat, aktivitas ringan).
- Tugas ini bertujuan membantu mahasiswa memahami manajemen waktu ibu nifas agar efektif dan tidak mengalami kelelahan berlebih.

#### **Tugas 5: Membuat Makalah tentang Adaptasi Peran Sosial Ibu Baru**

- Mahasiswa menyusun makalah yang mendiskusikan perubahan peran sosial ibu baru dalam keluarga dan masyarakat.
- Dalam makalah ini, mahasiswa diwajibkan mengidentifikasi berbagai tantangan sosial yang mungkin dihadapi oleh ibu baru, serta merumuskan strategi untuk mengatasinya melalui dukungan keluarga, pasangan, dan komunitas.

- Mahasiswa juga diwajibkan melakukan wawancara dengan minimal dua ibu baru untuk memperkaya data dan analisisnya.

### Pilihan Ganda

---

1. Seorang ibu multipara, 29 tahun, melahirkan secara spontan di klinik bidan 24 jam yang lalu. Saat pemeriksaan hari pertama nifas, tinggi fundus uteri ditemukan berada setinggi umbilicus.  
Apa yang dapat disimpulkan dari kondisi tersebut?  
A. Kondisi uterus mengalami subinvolusi  
B. Ibu mengalami retensi plasenta  
C. Kondisi involusi uterus berjalan normal  
D. Ada perdarahan postpartum berlebihan  
E. Uterus mengalami infeksi postpartum
2. Seorang ibu, 25 tahun, hari ke-4 pascapersalinan mengeluhkan keluarnya cairan dari vagina berwarna merah muda, tipis, dengan sedikit darah. Berdasarkan keluhan ibu, jenis lochia apakah yang sedang dialami?  
A. Lochia rubra  
B. Lochia alba  
C. Lochia purulenta  
D. Lochia infeksi  
E. Lochia serosa
3. Seorang ibu primipara, hari ke-10 postpartum mengeluhkan cairan vagina berbau tidak sedap, berwarna hijau kekuningan, dan demam 38,5°C. Kondisi ini mengindikasikan adanya:  
A. Proses involusi uterus yang normal  
B. Infeksi postpartum  
C. Lochia alba yang normal  
D. Retensi plasenta  
E. Postpartum blues
4. Seorang ibu postpartum hari ke-14 mengeluh sulit tidur, mudah tersinggung, dan sering menangis tanpa alasan jelas. Gejala ini terjadi sejak seminggu lalu. Namun ibu masih mampu merawat bayinya dengan baik. Diagnosis yang paling tepat adalah  
A. Depresi postpartum  
B. Psikosis postpartum  
C. Postpartum blues



- D. Kecemasan postpartum
  - E. Gangguan stres pascatrauma
5. Seorang ibu baru, 30 tahun, mengalami kesulitan dalam mengatur waktu antara merawat bayi, beristirahat, dan tugas rumah tangga. Sebagai bidan, langkah awal yang paling tepat untuk membantu ibu adalah
- A. Memberikan edukasi tentang tanda bahaya nifas
  - B. Memberikan konseling tentang depresi postpartum
  - C. Merujuk ibu ke tenaga profesional kesehatan mental
  - D. Mengajarkan teknik menyusui yang benar
  - E. Membantu ibu menyusun jadwal harian yang realistis

### Kunci Jawaban

---

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Pada hari pertama postpartum, fundus uteri secara normal berada sekitar setinggi umbilicus. Uterus kemudian akan turun sekitar 1 cm per hari. Kondisi tersebut menunjukkan involusi uterus yang normal, bukan subinvolusi ataupun komplikasi lainnya.

2. Kunci Jawaban: E

Pembahasan:

Lochia serosa muncul pada hari ke-4 hingga ke-10 postpartum, berwarna merah muda atau coklat muda, lebih tipis, mengandung sedikit darah, serum, leukosit, dan jaringan epitel. Kondisi ibu sesuai dengan gambaran lochia serosa.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Lochia yang tidak normal seperti berbau tidak sedap, hijau kekuningan, dan disertai demam menunjukkan tanda infeksi postpartum yang membutuhkan penanganan segera oleh tenaga kesehatan.

4. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Gejala ibu, seperti perubahan mood yang cepat, mudah menangis tanpa alasan jelas, dan mudah tersinggung namun tetap mampu menjalani aktivitas merawat bayi, merupakan ciri khas postpartum blues yang biasanya berlangsung hingga dua minggu postpartum.

5. Kunci Jawaban: E

Pembahasan:

Kesulitan manajemen waktu merupakan tantangan umum bagi ibu baru. Langkah awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah membantu ibu menyusun jadwal harian yang realistis dan fleksibel agar ibu mampu menjalani perannya dengan lebih efektif dan mengurangi risiko stres berlebihan.

## **F. Rangkuman**

Masa nifas merupakan periode penting bagi ibu setelah melahirkan yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Sistem reproduksi ibu mengalami perubahan dramatis, terutama pada uterus yang menjalani proses involusi atau pengecilan secara bertahap hingga kembali ke ukuran sebelum kehamilan. Tinggi fundus uterus yang pada hari pertama setinggi umbilicus akan turun sekitar satu sentimeter setiap hari, sehingga tidak lagi teraba di atas simfisis pubis pada minggu kedua. Proses involusi uterus ini sangat dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang dilepaskan saat menyusui, menyebabkan sensasi nyeri ringan (afterpain) terutama pada ibu multipara. Bersamaan dengan itu, lapisan endometrium uterus mengalami regenerasi bertahap dengan disertai keluarnya cairan vagina yang disebut lochia. Lochia mengalami perubahan mulai dari cairan merah terang hingga menjadi putih kekuningan dalam rentang waktu hingga enam minggu postpartum. Kondisi lochia yang abnormal seperti berbau busuk, berwarna hijau, atau disertai perdarahan berat merupakan tanda infeksi atau komplikasi yang harus segera ditangani.

Serviks juga mengalami perubahan signifikan, yang setelah persalinan secara perlahan menyempit kembali. Meski ukurannya kembali mengecil, tekstur serviks menjadi lebih lunak dan elastis dibanding sebelum kehamilan, dengan bentuk mulut serviks berubah menjadi seperti celah atau garis transversal. Perubahan ini membantu dalam proses regenerasi sekaligus berperan mencegah infeksi selama masa nifas.

Vagina yang mengalami peningkatan aliran darah selama kehamilan juga mulai menyempit kembali setelah persalinan, meskipun tidak sepenuhnya seperti kondisi sebelum hamil. Penurunan kadar estrogen selama masa nifas menyebabkan vagina menjadi lebih kering, terutama pada ibu menyusui, yang bisa mengakibatkan ketidaknyamanan saat hubungan seksual (dispareunia). Oleh karena itu, edukasi tentang perawatan vagina serta penggunaan pelumas yang aman sangat penting dalam asuhan kebidanan. Pemantauan oleh bidan terhadap involusi uterus, karakteristik lochia, serta kondisi serviks dan vagina sangat diperlukan untuk memastikan pemulihan berjalan lancar dan menghindari komplikasi.

Selain perubahan fisik, ibu juga mengalami perubahan signifikan pada sistem kardiovaskular, respirasi, metabolik, dan hormonal. Kondisi ini sering disertai perubahan emosional seperti postpartum blues, yang umumnya bersifat sementara dengan gejala berupa mood yang berubah cepat, cemas, lelah, dan mudah menangis. Namun, jika gejala tersebut berlangsung lebih lama dan semakin berat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, maka kondisi tersebut berkembang menjadi depresi postpartum. Depresi postpartum merupakan kondisi serius yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat pada aktivitas, gangguan tidur, nafsu makan menurun, hingga pikiran negatif tentang diri sendiri atau bayi. Kondisi ini memerlukan intervensi medis dan psikologis secara intensif. Faktor risiko depresi postpartum antara lain riwayat gangguan mental sebelumnya, kurangnya dukungan sosial, stres selama kehamilan atau persalinan, dan komplikasi medis. Pencegahan melalui edukasi prenatal, dukungan keluarga, serta pemantauan rutin kesehatan mental ibu selama masa nifas sangat penting. Tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter, berperan besar dalam mendeteksi dini serta memberikan dukungan melalui konseling dan intervensi farmakologis jika diperlukan.

Selama masa nifas, ibu juga dihadapkan pada tantangan adaptasi terhadap peran barunya sebagai orang tua. Proses adaptasi ini meliputi keterampilan perawatan bayi, manajemen waktu sehari-hari, serta perubahan peran sosial dalam keluarga dan masyarakat. Ibu perlu mendapatkan pembelajaran tentang perawatan bayi seperti teknik menyusui, perawatan kulit dan tali pusat bayi, serta manajemen kebersihan bayi secara keseluruhan untuk membangun kepercayaan diri. Manajemen waktu yang realistis dan fleksibel juga sangat diperlukan untuk menghindari kelelahan fisik dan mental. Dalam menghadapi perubahan sosial, komunikasi terbuka dengan pasangan dan keluarga serta menjaga interaksi sosial sangat penting untuk mengurangi perasaan isolasi. Dukungan keluarga dan tenaga kesehatan melalui pemberian bantuan praktis dan emosional serta edukasi komprehensif menjadi faktor kunci yang membantu ibu melewati masa transisi ini dengan sehat dan percaya diri.

## G. Glosarium

**Adaptasi:** Penyesuaian diri terhadap situasi atau peran baru, seperti peran sebagai ibu setelah melahirkan.

**Afterpain:** Nyeri ringan yang dirasakan ibu setelah melahirkan akibat kontraksi uterus selama masa nifas, lebih sering dialami oleh multipara dibanding primipara.

**Bonding:** Ikatan emosional yang terbentuk antara ibu dan bayi setelah kelahiran, yang sangat penting untuk perkembangan emosional bayi.

**Depresi Postpartum:** Gangguan mood klinis serius yang terjadi pada masa nifas, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, gangguan tidur, rasa bersalah berlebihan, dan pikiran negatif tentang diri sendiri atau bayi.

**Dilatasi:** Pembukaan serviks selama persalinan hingga mencapai ukuran sekitar 10 cm agar bayi bisa lahir melalui jalan lahir.

**Dispareunia:** Rasa nyeri atau tidak nyaman saat berhubungan seksual, yang bisa terjadi selama masa nifas akibat penurunan kadar estrogen.

**Endometrium:** Lapisan terdalam dari uterus yang mengalami proses regenerasi dan penyembuhan setelah persalinan.

**Fundus Uteri:** Bagian atas uterus yang diperiksa posisinya untuk mengevaluasi proses involusi setelah persalinan.

**Hiperemia:** Kondisi peningkatan aliran darah, yang menyebabkan vagina menjadi lebih lunak dan elastis selama kehamilan.

**Hormonal:** Berkaitan dengan hormon; dalam konteks ini, perubahan kadar hormon yang signifikan setelah melahirkan.

**Infeksi Postpartum:** Infeksi yang terjadi pada ibu setelah persalinan, ditandai oleh gejala seperti demam, bau tidak sedap dari vagina, dan cairan lochia abnormal.

**Involusi:** Proses pengecilan kembali uterus dan vagina secara bertahap setelah melahirkan hingga mencapai ukuran sebelum kehamilan.

**Lochia:** Cairan yang keluar dari vagina setelah persalinan, mengandung darah, mukus, jaringan plasenta, dan endometrium yang meluruh.

**Lochia Alba:** Tahap akhir dari lochia, berupa cairan putih atau kekuningan yang berlangsung sekitar hari ke-10 hingga minggu ke-6 postpartum.

**Lochia Rubra:** Cairan lochia berwarna merah terang yang keluar pada 1–3 hari pertama postpartum, mengandung darah segar.

**Lochia Serosa:** Tahap kedua lochia, berlangsung dari hari ke-4 hingga ke-10 postpartum, dengan cairan yang lebih tipis dan berwarna merah muda atau coklat muda.

**Multipara:** Wanita yang telah mengalami persalinan lebih dari satu kali.

**Nifas:** Periode sekitar enam minggu setelah persalinan, ketika tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum hamil.

**Oksitosin:** Hormon yang berperan penting dalam kontraksi uterus setelah persalinan dan selama menyusui, membantu proses involusi.

**Plasenta:** Organ yang melekat pada dinding rahim selama kehamilan, berfungsi menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin.

**Postpartum Blues (Baby Blues):** Kondisi emosional ringan dan sementara pada ibu setelah melahirkan, ditandai perubahan mood yang cepat, mudah menangis, dan kelelahan.

**Primipara:** Wanita yang baru pertama kali mengalami persalinan.

**Regenerasi:** Proses penyembuhan dan pembentukan kembali jaringan, seperti endometrium dan serviks setelah persalinan.

**Serviks:** Leher rahim yang mengalami dilatasi selama persalinan dan proses regenerasi setelah melahirkan.

**Simfisis Pubis:** Tulang panggul bagian depan yang digunakan sebagai titik ukur dalam memantau tinggi fundus uteri selama masa nifas.

**Vaskularisasi:** Proses pembentukan pembuluh darah baru yang menyebabkan perubahan warna dan elastisitas pada

## H. Daftar Pustaka

- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Cashion, M. C., Perry, S. E., Alden, K. R., & Olshansky, E. (2019). *Maternity and Women's Health Care* (12th ed.). Elsevier.
- Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P. A. (2019). *Olds' Maternal-Newborn Nursing & Women's Health Across the Lifespan* (11th ed.). Pearson Education.
- East, C. E., Biro, M. A., Fredericks, S., & Lau, R. (2019). Support during pregnancy for women at increased risk of low birthweight babies. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 4(4), CD000198. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000198.pub3>
- Gabbe, S. G., Niebyl, J. R., Simpson, J. L., Landon, M. B., Galan, H. L., & Jauniaux, E. R. (2020). *Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies* (8th ed.). Elsevier.
- Jones, E., & Shakespeare, J. (2020). Postnatal depression. *BMJ Clinical Evidence*, 2020, 1407. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1276>
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). *Myles Textbook for Midwives* (17th ed.). Elsevier.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K., & Ashwill, J. (2021). *Maternal-Child Nursing* (6th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). *Maternity and Pediatric Nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer.
- World Health Organization. (2022). *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience*. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045989>
- Yanti, A., & Saragih, I. D. (2020). Hubungan dukungan sosial dengan kejadian postpartum blues pada ibu postpartum. *Jurnal Kesehatan*, 11(3), 385–392. <https://doi.org/10.26630/jk.v11i3.2192>

# Bab 3

## Pemeriksaan dan Pengkajian Pada Masa Nifas

Masa nifas adalah periode penting dalam siklus reproduksi wanita yang berlangsung sekitar 6 minggu setelah persalinan. Pada masa ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang memerlukan perhatian khusus dari tenaga kebidanan. Pemeriksaan dan pengkajian yang teliti selama masa nifas bertujuan untuk memastikan proses pemulihan ibu berjalan optimal serta mendeteksi dini adanya komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan fisik yang meliputi evaluasi fundus uteri, perdarahan, dan luka jahitan sangat penting untuk menilai kondisi organ reproduksi setelah persalinan. Selain itu, penilaian tanda vital dan status umum memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan ibu secara keseluruhan. Pemeriksaan payudara dan proses menyusui juga menjadi fokus utama untuk memastikan kelancaran pemberian ASI dan kesehatan ibu. Tidak kalah penting, penilaian kesehatan mental dan pengkajian kebutuhan edukasi serta dukungan sosial membantu dalam mendukung kesejahteraan psikososial ibu nifas. Dengan pendekatan komprehensif ini, bidan dapat memberikan asuhan yang tepat, efektif, dan berpusat pada ibu, sehingga mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi serius.

### **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi proses pemeriksaan dan pengkajian pada masa nifas secara komprehensif, meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial guna memberikan asuhan kebidanan yang holistik dan berkualitas.

### **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**

Mahasiswa mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengkajian menyeluruh pada ibu nifas, termasuk pemeriksaan fisik, tanda vital, payudara dan menyusui, serta kesehatan mental, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan edukasi dan dukungan sosial yang diperlukan oleh ibu selama masa nifas.

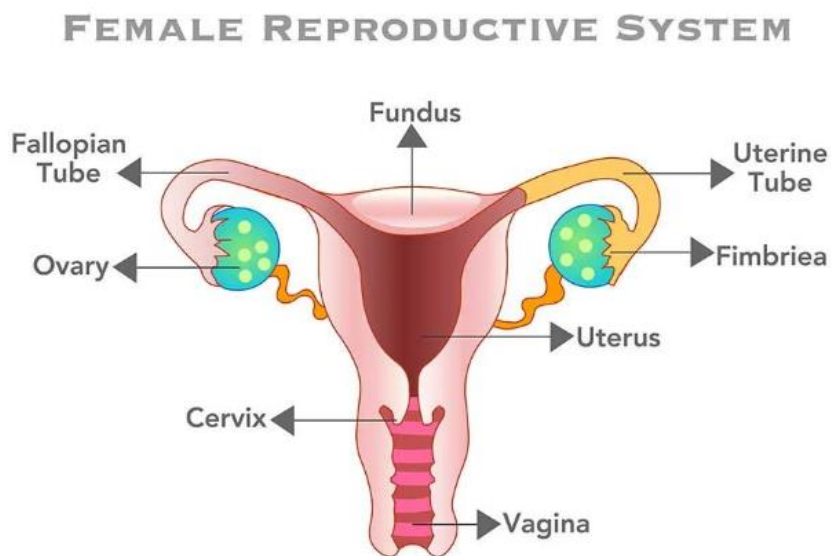
### **Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**

1. Menjelaskan prosedur pemeriksaan fundus uteri, perdarahan, dan luka jahitan pada ibu nifas.
2. Melaksanakan penilaian tanda vital dan status umum secara tepat dan akurat pada ibu nifas.
3. Mengkaji kondisi payudara dan proses menyusui, termasuk tanda-tanda kelainan yang mungkin terjadi.
4. Mengidentifikasi indikator kesehatan mental pada ibu nifas dan mengenali tanda-tanda gangguan psikologis.
5. Mengkaji kebutuhan edukasi dan dukungan sosial ibu nifas secara individual dan merancang intervensi kebidanan yang sesuai.



## A. Pemeriksaan Fisik Ibu Nifas

Masa nifas merupakan periode pascapersalinan di mana tubuh ibu mengalami proses pemulihan secara fisiologis, terutama pada organ reproduksi. Pemeriksaan fisik ibu nifas adalah komponen utama dalam asuhan kebidanan, bertujuan untuk memantau proses involusi rahim, mendeteksi perdarahan abnormal, serta memastikan penyembuhan luka persalinan berjalan baik. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara rutin dan sistematis agar komplikasi dapat dikenali sedini mungkin dan tindakan tepat dapat diberikan.



**Gambar 3.1 Sistem Reproduksi Perempuan**

Sumber: <https://www.magnoliabirthhouse.com/magnolia-blog/what-is-fundus-in-pregnancy>

### 1. Pemeriksaan Fundus Uteri

Fundus uteri adalah bagian tertinggi dari rahim yang letaknya berubah-ubah selama masa nifas karena proses involusi. Involusi rahim adalah proses di mana rahim kembali ke ukuran dan posisi semula setelah mengalami pembesaran selama kehamilan.

#### a. Teknik Pemeriksaan Fundus Uteri

Pemeriksaan dilakukan dengan palpasi perut ibu dalam posisi berbaring telentang dengan lutut ditekuk untuk mengendurkan otot perut. Langkah-langkah pemeriksaan adalah sebagai berikut:

##### 1) Persiapan Posisi

Pastikan ibu dalam posisi nyaman, berbaring telentang, lutut ditekuk dan kedua tangan rileks di samping tubuh.

##### 2) Palpasi Fundus

Bidan menggunakan kedua tangan untuk meraba perut ibu dimulai dari bagian atas (pusat) perut, tepatnya di daerah supraumbilikal, kemudian menurunkan tangan ke arah bawah menuju simfisis pubis.

- a) Fundus yang teraba keras dan berbentuk bulat menunjukkan rahim sedang berkontraksi dengan baik.
- b) Jika fundus terletak di sekitar umbilikus pada hari pertama nifas, dan kemudian turun kira-kira 1 cm per hari, itu menunjukkan involusi yang normal.
- c) Fundus yang lunak (atonia) menandakan rahim tidak berkontraksi dengan optimal, meningkatkan risiko perdarahan.

### **3) Penilaian Posisi dan Ukuran**

Posisi fundus yang tinggi atau tidak simetris dengan arah uterus dapat menunjukkan adanya distensi kandung kemih yang mengganggu involusi.

Ukuran fundus yang tidak mengecil sesuai hari pasca persalinan dapat mengindikasikan subinvolusi atau infeksi.

#### **a) Interpretasi Temuan**

- Fundus keras dan terletak tepat:  
Menunjukkan involusi rahim yang sehat.
- Fundus lunak dan membesar:  
Risiko atonia uteri, yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum.
- Fundus tidak menurun sesuai waktu:  
Indikasi adanya retensi plasenta, infeksi, atau hematoma.

#### **b) Tindakan Selanjutnya**

Jika ditemukan fundus yang tidak normal, bidan harus segera menginformasikan dokter dan melakukan tindakan sesuai protokol, seperti stimulasi kontraksi rahim, pengosongan kandung kemih, atau intervensi lain.

## **2. Pemeriksaan Perdarahan Nifas (Lochia)**

Perdarahan nifas atau lochia adalah darah yang keluar dari jalan lahir sebagai bagian dari proses peluruhan endometrium dan pemulihan uterus setelah persalinan.

### **a. Jenis-jenis Lochia**

Lochia mengalami perubahan warna dan karakteristik selama masa nifas, yang biasanya terbagi menjadi tiga fase:

#### **1) Lochia Rubra**

- a) Warna merah segar, mirip darah menstruasi.
- b) Terdiri dari darah, jaringan decidua, dan sisa-sisa plasenta.
- c) Terjadi pada 1–3 hari pertama setelah persalinan.

#### **2) Lochia Serosa**

- a) Berwarna coklat muda atau merah muda, lebih encer.

- b) Terdiri dari cairan serum, lendir, dan sedikit darah.
  - c) Biasanya muncul antara hari ke-4 hingga ke-10.
- 3) Lochia Alba
- a) Berwarna putih kekuningan atau krem.
  - b) Berisi leukosit, lendir, dan sel epitel.
  - c) Terjadi mulai hari ke-10 hingga minggu ke-6 setelah persalinan.

#### **b. Pemeriksaan dan Penilaian**

Pemeriksaan lochia meliputi:

- 1) Jumlah: Normalnya berkurang dari hari ke hari.
  - Pada 24 jam pertama, jumlahnya bisa mencapai 240-270 ml.
  - Jika jumlah lebih dari 500 ml, terutama jika terjadi secara tiba-tiba dan disertai gumpalan besar, perlu diwaspadai sebagai perdarahan postpartum.
- 2) Warna: Harus berubah sesuai tahapan. Warna yang kembali merah segar setelah periode serosa atau alba dapat mengindikasikan perdarahan baru.
- 3) Bau: Lochia normal tidak berbau busuk. Bau tidak sedap dapat menandakan infeksi.
- 4) Konsistensi: Normalnya cair, tidak menggumpal besar.

#### **c. Tanda-tanda Abnormal**

- 1) Perdarahan yang sangat banyak dan terus-menerus (perdarahan postpartum berat).
- 2) Bau amis atau busuk yang menandakan infeksi.
- 3) Perdarahan yang bercampur nanah atau berwarna hijau kekuningan.
- 4) Lochia yang tidak berubah warna sesuai waktu atau berhenti tiba-tiba (retensi sisa plasenta).

### **3. Tindakan**

Jika ditemukan tanda-tanda abnormal, bidan harus segera melakukan intervensi sesuai protokol, termasuk pemberian oksitosin, monitoring ketat, dan merujuk ke fasilitas yang lebih lengkap.

### **4. Pemeriksaan Luka Jahitan**

Luka jahitan pada ibu nifas biasanya terjadi pada perineum akibat robekan spontan atau episiotomi, atau pada daerah abdomen akibat operasi sesar. Pemeriksaan luka jahitan bertujuan memastikan proses penyembuhan optimal tanpa komplikasi.

#### **a. Tahapan Pemeriksaan**

##### **1) Inspeksi Luka**

- Perhatikan warna kulit di sekitar luka, ada tidaknya kemerahan (eritema).
- Periksa adanya edema (pembengkakan), keluarnya cairan atau nanah (exudate), perdarahan aktif, atau jaringan granulasi abnormal.
- Evaluasi apakah luka tertutup rapat atau ada dehiscence (terbuka sebagian).

## **2) Palpasi Luka**

- Periksa apakah ada nyeri tekan yang berlebihan, indikasi abses atau infeksi.
- Raba adanya benjolan keras yang mungkin menandakan hematoma.

## **3) Penilaian Fungsi**

Tanyakan kepada ibu mengenai nyeri, kesulitan buang air kecil, atau ketidaknyamanan saat duduk.

## **4) Tanda-tanda Komplikasi**

- Luka yang bengkak, merah, nyeri hebat, dan keluar nanah dapat menunjukkan infeksi.
- Perdarahan berlebihan atau pembukaan luka dapat mengindikasikan dehiscence atau hematoma.
- Luka yang tidak sembuh dalam waktu yang diharapkan bisa menjadi tanda infeksi kronis atau gangguan penyembuhan.

## **5) Edukasi dan Perawatan Luka**

Bidan harus memberikan edukasi kepada ibu tentang:

- Cara menjaga kebersihan luka, seperti membersihkan dengan air hangat dan sabun ringan.
- Menghindari menggaruk atau menggosok luka.
- Memperhatikan tanda-tanda infeksi seperti pembengkakan, kemerahan, atau keluarnya cairan.
- Pentingnya mengikuti kontrol rutin dan segera melapor jika ada keluhan.

# **B. Penilaian Tanda Vital dan Status Umum pada Ibu Nifas**

Masa nifas merupakan periode krusial bagi ibu setelah persalinan, di mana tubuhnya mengalami berbagai perubahan fisiologis dan psikologis. Pada masa ini, ibu rentan terhadap berbagai komplikasi seperti perdarahan postpartum, infeksi puerperal, hingga gangguan kardiovaskular yang dapat berujung pada kondisi gawat darurat. Oleh karena itu, pemantauan tanda vital dan status umum ibu secara rutin dan akurat sangat penting untuk mendeteksi secara dini perubahan kondisi yang mengancam keselamatan ibu.

Tanda vital merupakan parameter objektif yang dapat menunjukkan kondisi fisiologis tubuh ibu, sedangkan penilaian status umum memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan kesehatan ibu, termasuk aspek neurologis, sirkulasi, dan nutrisi. Dengan penilaian komprehensif ini, tenaga kebidanan dapat memberikan intervensi yang tepat dan melakukan rujukan bila diperlukan.

Tanda vital merupakan indikator utama fungsi tubuh yang harus dipantau secara berkala pada ibu nifas. Parameter yang perlu diperhatikan meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan.

## **1. Penilaian Tanda Vital**

### **a. Tekanan Darah (TD)**

Tekanan darah mencerminkan tekanan yang diberikan darah terhadap dinding arteri dan merupakan indikator penting kesehatan kardiovaskular.

1) Tujuan pengukuran:

Memantau tekanan darah dapat membantu mendeteksi hipertensi persisten (misalnya akibat preeklamsia) maupun hipotensi yang dapat disebabkan oleh perdarahan postpartum atau syok.

2) Nilai normal:

Tekanan darah normal pada ibu nifas berkisar antara 90/60 mmHg hingga 140/90 mmHg.

3) Metode pengukuran:

Pengukuran dilakukan dengan tensimeter manual atau digital. Posisi ibu saat pengukuran harus rileks, idealnya duduk dengan lengan berada sejajar dengan jantung. Catat nilai sistolik dan diastolik.

4) Interpretasi:

a) Tekanan darah tinggi ( $>140/90$  mmHg) perlu dievaluasi untuk risiko preeklamsia atau hipertensi kronis.

b) Tekanan darah rendah ( $<90/60$  mmHg) dapat menandakan perdarahan atau dehidrasi.

### **b. Denyut Nadi**

Denyut nadi menunjukkan jumlah denyut jantung per menit dan menggambarkan kondisi sirkulasi serta aktivitas jantung.

1) Tujuan pengukuran:

Memantau denyut nadi dapat mendeteksi takikardia akibat perdarahan atau infeksi, serta bradikardia yang mungkin disebabkan oleh gangguan sistemik.

2) Nilai normal:

Rentang normal 60–100 kali per menit pada orang dewasa.

3) Metode pengukuran:

Denyut nadi dapat diukur dengan palpasi arteri radialis selama 30 detik kemudian dikalikan dua untuk mendapatkan denyut per menit.

4) Interpretasi:

a) Denyut nadi cepat ( $>100$  bpm) dapat menunjukkan perdarahan, nyeri, demam, atau kecemasan.

b) Denyut lambat ( $<60$  bpm) perlu diperiksa lebih lanjut, terutama bila disertai gejala lain.

### **c. Suhu Tubuh**

Suhu tubuh adalah indikator keseimbangan panas tubuh dan penting untuk mendeteksi infeksi.

1) Tujuan pengukuran:

Pengukuran suhu tubuh secara rutin penting untuk mendeteksi demam yang dapat menjadi tanda infeksi puerperal seperti endometritis atau mastitis.

2) Nilai normal:

Suhu tubuh normal berkisar antara 36,5°C sampai 37,5°C.

3) Metode pengukuran:

Suhu dapat diukur secara oral, aksila, atau rektal menggunakan termometer digital atau merkuri.

4) Interpretasi:

a) Suhu  $>38^{\circ}\text{C}$  menunjukkan demam yang perlu dievaluasi untuk kemungkinan infeksi.

b) Suhu  $<36^{\circ}\text{C}$  jarang terjadi, tapi dapat menunjukkan hipotermia.

### **d. Frekuensi Pernapasan**

Frekuensi pernapasan merupakan jumlah napas per menit dan memberikan gambaran tentang fungsi pernapasan dan metabolisme.

1) Tujuan pengukuran:

Memantau perubahan pola pernapasan dapat mengindikasikan nyeri, infeksi, gangguan kardiopulmonal, atau kondisi psikologis seperti kecemasan.

2) Nilai normal:

Rentang normal adalah 12–20 napas per menit pada orang dewasa.

3) Metode pengukuran:

Amati gerakan dada selama 30 detik tanpa membuat ibu sadar agar pernapasan tidak berubah, kemudian kalikan dua.

4) Interpretasi:

a) Pernapasan cepat (takipnea) dapat menjadi tanda awal gangguan.

b) Pernapasan lambat (bradipnea) dapat terjadi akibat obat-obatan atau gangguan neurologis.

## **2. Penilaian Status Umum**

Penilaian status umum merupakan evaluasi menyeluruh kondisi fisik dan mental ibu yang meliputi:

a. Kesadaran

- Evaluasi tingkat kesadaran ibu dengan memeriksa respons terhadap rangsangan verbal dan lingkungan sekitar.
- Perubahan kesadaran seperti kebingungan, pingsan, atau somnolen bisa menandakan komplikasi serius.

b. Warna Kulit dan Mukosa

- Periksa warna kulit pada wajah, bibir, dan kuku.
- Kulit pucat dapat menandakan anemia atau perdarahan.
- Sianosis (warna kebiruan) menunjukkan gangguan oksigenasi.
- Ruam atau kemerahan yang meluas bisa tanda infeksi atau alergi.

c. Keadaan Hidrasi

- Periksa tanda-tanda dehidrasi seperti mulut kering, turgor kulit yang menurun, mata cekung, dan tekanan darah rendah.
- Dehidrasi harus segera diatasi agar tidak memperberat kondisi ibu.

d. Kondisi Nutrisi dan Energi

- Amati asupan makanan dan minuman ibu serta kemampuan aktivitas sehari-hari.
- Kekurangan nutrisi atau energi dapat memperlambat proses penyembuhan dan mengganggu produksi ASI.

### 3. Tindak Lanjut dan Dokumentasi

Setiap hasil penilaian harus didokumentasikan secara rinci untuk memudahkan pemantauan perkembangan kondisi ibu. Bila ditemukan tanda-tanda abnormal, tenaga kebidanan harus segera melakukan intervensi yang sesuai, baik secara mandiri maupun dengan rujukan ke tenaga medis lain.

## C. Pemeriksaan Payudara dan Proses Menyusui

Masa nifas adalah periode kritis dalam kehidupan ibu, di mana pemberian Air Susu Ibu (ASI) sangat menentukan kesehatan dan pertumbuhan bayi. Pemeriksaan payudara dan pengelolaan proses menyusui merupakan bagian esensial dari asuhan kebidanan yang bertujuan memastikan kelancaran produksi ASI, mencegah komplikasi, dan mendukung ibu agar dapat memberikan ASI eksklusif sesuai rekomendasi WHO selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Bidan memiliki peran penting dalam mengevaluasi kondisi payudara, mengidentifikasi gangguan, serta membimbing ibu dalam teknik menyusui yang benar.

### 1. Pemeriksaan Fisik Payudara

Pemeriksaan payudara dilakukan secara sistematis, meliputi observasi dan palpasi, untuk menilai kesehatan jaringan payudara dan mendeteksi potensi masalah yang dapat mengganggu proses menyusui.

#### a. Observasi

##### 1) Bentuk dan Ukuran

Payudara normal biasanya simetris, dengan variasi bentuk dari bulat, oval, hingga berbentuk kerucut. Ukuran payudara tidak selalu berhubungan dengan kemampuan menyusui, karena kapasitas kelenjar susu bervariasi.



## 2) Kulit Payudara

Periksa kulit payudara untuk tanda-tanda kemerahan, pembengkakan, atau ruam yang bisa mengindikasikan infeksi atau iritasi. Perhatikan juga adanya lekukan atau perubahan tekstur kulit (seperti kulit jeruk) yang bisa menandakan gangguan serius.

## 3) Puting Susu

Amati kondisi puting susu, apakah rata, menonjol, atau cekung (inverted nipple). Puting susu normal menonjol dan elastis, memudahkan bayi untuk melekat. Puting cekung dapat menyulitkan pelekatan dan membutuhkan teknik khusus.

### **b. Palpasi**

- 1) Lakukan palpasi dengan tangan lembut pada seluruh payudara, terutama area sekitar puting dan areola, untuk mendeteksi adanya benjolan, pembengkakan, atau nyeri tekan.
- 2) Payudara yang normal terasa lembut dengan kelenjar susu yang tidak membengkak secara berlebihan.
- 3) Adanya benjolan keras, nyeri berlebihan, atau panas dapat menandakan mastitis atau abses.

## **2. Evaluasi Proses Menyusui**

### **a. Teknik Menyusui**

Bidan harus mengamati dan mengevaluasi teknik menyusui ibu agar proses pemberian ASI berlangsung efektif dan nyaman, baik untuk ibu maupun bayi.

#### 1) Posisi Menyusui

Posisi ibu dan bayi harus nyaman dan mendukung kontak kulit-ke-kulit. Posisi populer meliputi cradle hold, cross cradle, football hold, dan side-lying. Posisi yang baik mencegah nyeri dan luka pada puting.

#### 2) Pelekatan Bayi (Latch On)

Pelekatan yang benar adalah saat mulut bayi terbuka lebar, bibir bawah terlipat keluar, dan sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi, bukan hanya puting. Pelekatan yang tepat memastikan bayi mendapat ASI cukup dan meminimalisasi trauma pada puting.

#### 3) Durasi dan Frekuensi Menyusui

Setiap sesi menyusui berlangsung 15-20 menit per payudara, dengan frekuensi 8-12 kali per hari pada minggu pertama pascapersalinan.

### **b. Pengkajian Hasil Menyusui**

- 1) Observasi tanda bayi kenyang dan puas setelah menyusui (misalnya melepas payudara dengan sendirinya, tidur nyenyak).

- 2) Periksa berat badan bayi secara rutin sebagai indikator asupan ASI yang adekuat.
- 3) Evaluasi produksi ASI ibu dengan memperhatikan tanda-tanda payudara lunak setelah menyusui.

### **3. Komplikasi pada Payudara dan Menyusui**

#### **a. Mastitis**

Mastitis adalah inflamasi jaringan payudara akibat infeksi bakteri, biasanya *Staphylococcus aureus*.

- 1) Gejala: Payudara kemerahan, bengkak, nyeri, demam, dan malaise.
- 2) Penanganan: Kompres hangat, pengosongan payudara rutin dengan menyusui atau pompa, antibiotik sesuai anjuran dokter, dan analgesik.
- 3) Pencegahan: Kebersihan tangan, teknik menyusui yang benar, dan pengosongan payudara secara lengkap.

#### **b. Puting Lecet atau Luka**

- 1) Penyebab: Pelekatan bayi yang buruk, posisi menyusui yang salah, atau infeksi jamur.
- 2) Tanda: Nyeri, luka terbuka, kemerahan pada puting.
- 3) Penanganan: Perbaiki teknik menyusui, penggunaan krim pelindung puting, dan perawatan luka.

#### **c. Produksi ASI Rendah (Hipogalaktia)**

- 1) Faktor: Stress, kelelahan, teknik menyusui yang salah, atau masalah hormonal.
- 2) Intervensi: Edukasi teknik menyusui, dukungan psikologis, stimulasi payudara, dan jika perlu konsultasi medis.

### **4. Peran Bidan dalam Mendukung Proses Menyusui**

- a. Memberikan edukasi dan demonstrasi teknik menyusui yang benar dan nyaman.
- b. Mengidentifikasi dan menangani masalah menyusui sedini mungkin.
- c. Memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada ibu untuk mempertahankan ASI eksklusif.
- d. Melakukan follow-up rutin untuk memantau perkembangan menyusui dan kesehatan payudara.

## D. Pemeriksaan Kesehatan Mental Ibu Nifas

Masa nifas adalah fase krusial yang tidak hanya melibatkan pemulihan fisik tetapi juga kesehatan mental ibu. Kondisi psikologis ibu selama periode ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan ibu sendiri, kelangsungan proses menyusui, serta perkembangan emosional dan kognitif bayi. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan mental ibu nifas menjadi bagian penting dari asuhan kebidanan untuk memastikan deteksi dini gangguan psikologis dan memberikan intervensi yang tepat.

Gangguan kesehatan mental yang umum ditemui pada masa nifas antara lain ***baby blues***, **depresi postpartum**, dan **gangguan kecemasan**. Kegagalan mengenali dan menangani masalah ini dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup ibu dan mengganggu ikatan emosional ibu-anak.

### 1. Pentingnya Pemeriksaan Kesehatan Mental pada Ibu Nifas

Kesehatan mental yang baik selama masa nifas mendukung kemampuan ibu dalam merawat diri dan bayinya, menyesuaikan diri dengan perubahan peran, serta menjaga stabilitas emosional. Sebaliknya, gangguan mental dapat menyebabkan masalah seperti penarikan diri sosial, kesulitan menyusui, dan risiko kekerasan terhadap diri sendiri atau bayi.

### 2. Metode Pemeriksaan dan Pengkajian Kesehatan Mental

#### a. Wawancara Klinis

Bidan melakukan wawancara secara empatik dan terbuka untuk mengenali gejala-gejala awal gangguan mental, meliputi:

- 1) Perubahan suasana hati yang signifikan, seperti perasaan sedih yang menetap atau mudah tersinggung.
- 2) Gejala kecemasan berlebihan, ketakutan, atau kegelisahan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
- 3) Gangguan tidur atau pola makan yang berubah drastis.
- 4) Rasa tidak berdaya, kehilangan minat, atau pikiran untuk menyakiti diri sendiri.
- 5) Kesulitan dalam merawat bayi atau merasa jauh dari bayi.

Wawancara ini harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif dan menjaga kerahasiaan ibu.

#### b. Penggunaan Alat Skrining

Beberapa instrumen standar dapat digunakan untuk membantu deteksi, seperti:

- 1) Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): Skala penilaian depresi postpartum yang terdiri dari 10 pertanyaan.
- 2) Patient Health Questionnaire (PHQ-9): Mengukur tingkat depresi.
- 3) Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7): Untuk menilai kecemasan.

Alat ini memudahkan bidan melakukan skrining awal dan menentukan apakah ibu memerlukan rujukan.

### 3. Faktor Risiko Gangguan Kesehatan Mental pada Ibu Nifas

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental antara lain:

- Dukungan sosial yang minim: Kurangnya bantuan dari pasangan, keluarga, atau komunitas meningkatkan stres.
- Riwayat gangguan mental: Ibu dengan riwayat depresi, kecemasan, atau gangguan psikologis lainnya memiliki risiko lebih tinggi.
- Komplikasi persalinan: Proses persalinan yang traumatis, operasi sesar, atau komplikasi bayi.
- Stressor kehidupan: Masalah keuangan, pekerjaan, atau hubungan keluarga.
- Kurangnya pengetahuan: Tentang proses nifas dan peran ibu dapat menyebabkan kecemasan dan ketakutan.

### 4. Tanda dan Gejala Umum Gangguan Kesehatan Mental pada Masa Nifas

| Gangguan            | Tanda dan Gejala Utama                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baby Blues          | Perubahan mood ringan, mudah menangis, cepat merasa lelah, biasanya hilang dalam 1-2 minggu           |
| Depresi Postpartum  | Perasaan sedih mendalam, putus asa, kehilangan minat, gangguan tidur dan nafsu makan, pikiran negatif |
| Gangguan Kecemasan  | Gelisah berlebihan, ketakutan, serangan panik, sulit berkonsentrasi                                   |
| Psikosis Postpartum | Halusinasi, delusi, kebingungan berat, membutuhkan penanganan darurat                                 |

### 5. Peran Bidan dalam Pemeriksaan dan Dukungan Kesehatan Mental

Bidan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam deteksi dan penanganan awal gangguan kesehatan mental ibu nifas. Tugas dan tanggung jawabnya mencakup:

- Melakukan pemeriksaan rutin: Integrasikan skrining kesehatan mental dalam kunjungan nifas.
- Memberikan dukungan emosional: Mendengarkan secara aktif, memberikan penguatan positif, dan mengurangi stigma terhadap gangguan mental.
- Edukasi: Memberikan informasi tentang tanda-tanda gangguan mental dan pentingnya meminta bantuan.
- Rujukan tepat waktu: Bila ditemukan tanda gangguan berat, segera merujuk ke psikolog, psikiater, atau tenaga kesehatan mental profesional.
- Koordinasi lintas sektor: Bekerjasama dengan keluarga dan komunitas untuk membangun dukungan sosial yang kuat.

## **E. Pengkajian Kebutuhan Edukasi dan Dukungan Sosial pada Ibu Nifas**

Masa nifas merupakan fase adaptasi penting bagi ibu yang baru melahirkan, di mana kebutuhan edukasi dan dukungan sosial sangat beragam dan krusial untuk keberhasilan pemulihan fisik, psikologis, serta keberlanjutan asuhan bayi, terutama pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pengkajian yang sistematis terhadap kebutuhan edukasi dan dukungan sosial menjadi kunci dalam perencanaan asuhan kebidanan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi unik setiap ibu.

Melalui pengkajian ini, bidan dapat mengidentifikasi area-area di mana ibu memerlukan informasi, pelatihan, dan bantuan dari lingkungan sosialnya sehingga dapat merancang intervensi yang efektif dan memberdayakan ibu dalam menjalani masa nifas dengan optimal.

### **1. Pengkajian Kebutuhan Edukasi**

#### **a. Perawatan Diri Pasca Persalinan**

- 1) Ibu perlu edukasi tentang perubahan fisiologis selama nifas, seperti involusi rahim, perdarahan nifas, dan perawatan luka jahitan.
- 2) Informasi tentang pentingnya istirahat yang cukup, pola makan bergizi, dan kebersihan diri.
- 3) Edukasi mengenai tanda-tanda bahaya yang harus segera diwaspadai seperti perdarahan berat, demam tinggi, nyeri hebat, atau keluarnya cairan berbau tidak sedap.

#### **b. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)**

- 1) Teknik menyusui yang benar dan manfaat ASI eksklusif selama 6 bulan pertama.
- 2) Cara mengatasi kesulitan menyusui seperti puting lecet, mastitis, dan produksi ASI rendah.
- 3) Pentingnya posisi dan pelekatan bayi untuk mendukung keberhasilan menyusui.

#### **c. Kontrasepsi Pascapersalinan**

- 1) Informasi berbagai metode kontrasepsi yang aman dan sesuai untuk ibu nifas.
- 2) Waktu ideal memulai kontrasepsi pascapersalinan untuk mencegah kehamilan dini.
- 3) Edukasi tentang efek samping dan manfaat masing-masing metode.

#### **d. Pemulihan Fisik dan Aktivitas**

- 1) Panduan aktivitas fisik yang aman selama masa nifas, termasuk senam ringan dan pergerakan.
- 2) Cara mengelola nyeri dan ketidaknyamanan tubuh.

- 3) Informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kondisi pra-kehamilan.

## **2. Pengkajian Dukungan Sosial**

### **a. Ketersediaan Dukungan Keluarga**

- 1) Identifikasi anggota keluarga inti yang dapat memberikan bantuan fisik dan emosional, seperti pasangan, orang tua, atau saudara.
- 2) Peran keluarga dalam membantu perawatan bayi dan ibu, pengelolaan rumah tangga, dan pemberian dukungan moral.

### **b. Dukungan dari Lingkungan Sosial**

- 1) Adanya tetangga, komunitas ibu menyusui, kelompok pendukung, atau tenaga kesehatan yang dapat diakses ibu.
- 2) Peran kelompok sosial dalam mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan motivasi ibu.

### **c. Hambatan Dukungan Sosial**

- 1) Faktor budaya atau tradisi yang dapat membatasi dukungan, seperti larangan tertentu selama nifas.
- 2) Kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi akses bantuan dan pelayanan kesehatan.
- 3) Stres dan konflik keluarga yang mungkin memperburuk kondisi ibu.

## **3. Strategi Perencanaan Asuhan Berdasarkan Pengkajian**

- a. Merancang edukasi yang bersifat personalisasi sesuai kebutuhan dan tingkat pemahaman ibu.
- b. Mengoptimalkan sumber daya sosial yang ada, mengajak keluarga dan komunitas untuk berperan aktif dalam mendukung ibu.
- c. Memberikan konseling dan motivasi agar ibu mampu menjalani masa nifas dengan percaya diri dan sehat.
- d. Memonitor perkembangan edukasi dan dukungan secara berkala dan menyesuaikan intervensi bila diperlukan.

## **F. Latihan Soal**

### **Tugas**

---

#### **Tugas 1**

Kasus:

Seorang ibu usia 26 tahun, hari ke-1 pascapersalinan spontan, tampak pucat dan mengeluh pusing saat berdiri. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110x/menit, dan perdarahan lochia rubra dalam jumlah banyak. Fundus uteri teraba lunak dan di atas pusat.

Pertanyaan:

Jelaskan langkah pemeriksaan dan pengkajian awal yang Anda lakukan, analisis kemungkinan penyebab, serta intervensi segera yang perlu diberikan untuk menurunkan risiko komplikasi serius.

## **Tugas 2**

Kasus:

Ibu usia 31 tahun, hari ke-4 nifas, datang ke klinik dengan keluhan nyeri saat menyusui dan payudara terasa keras di bagian luar kiri. Tidak ada demam, namun bayi menjadi rewel saat menyusui.

Pertanyaan:

Susunlah proses pengkajian kondisi payudara dan proses menyusui ibu tersebut. Buat analisis masalah, intervensi yang tepat, dan langkah edukasi untuk mencegah kondisi lebih lanjut seperti mastitis.

## **Tugas 3**

Kasus:

Seorang ibu nifas hari ke-7 mengaku sering menangis, merasa bersalah karena tidak bisa menyusui dengan baik, dan mulai merasa tidak mampu mengurus bayinya.

Pertanyaan:

Lakukan analisis terhadap kondisi kesehatan mental ibu. Jelaskan tahapan pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk mendeteksi gangguan psikologis, serta bentuk intervensi awal dan dukungan sosial yang harus diberikan oleh tenaga kebidanan.

## **Tugas 4**

Kasus:

Ibu nifas hari ke-3 datang untuk kontrol. Pemeriksaan menunjukkan suhu 38,2°C, denyut nadi 102x/menit, dan terdapat kemerahan serta nyeri tekan pada area luka jahitan episiotomi.

Pertanyaan:

Jelaskan prosedur pengkajian luka perineum yang sesuai standar, tanda-tanda infeksi lokal yang harus diwaspadai, serta rencana tindakan dan edukasi untuk menjaga kebersihan serta mempercepat penyembuhan luka.

## **Tugas 5**

Esai Terstruktur:

Jelaskan peran pemeriksaan tanda vital secara rutin pada ibu nifas, termasuk suhu, tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Berikan alasan klinis mengapa setiap parameter ini penting dalam mendeteksi komplikasi masa nifas, serta bagaimana cara menindaklanjuti bila ditemukan penyimpangan dari nilai normal.

## Pilihan Ganda

---

1. Seorang ibu nifas hari ke-3 mengeluhkan perdarahan yang masih berwarna merah segar dan banyak, serta terdapat gumpalan besar. Dari pemeriksaan didapati fundus uteri terasa lunak (atonia). Apakah tindakan awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan?
  - A. Memberikan antibiotik
  - B. Melakukan pengosongan kandung kemih dan memberikan stimulasi kontraksi rahim
  - C. Mengobservasi kondisi selama 24 jam
  - D. Memberikan analgesik
  - E. Merujuk ke psikolog
2. Seorang ibu nifas hari ke-7 datang ke bidan dengan keluhan luka jahitan yang nyeri, bengkak, merah, dan terdapat nanah. Apa kondisi yang paling mungkin dialami oleh ibu tersebut?
  - A. Dehiscence luka B
  - B. Hematoma
  - C. Infeksi luka jahitan
  - D. Subinvolusi uterus
  - E. Retensi plasenta
3. Seorang ibu nifas hari ke-2 memiliki suhu tubuh 38,5°C, frekuensi pernapasan 24 kali/menit, denyut nadi 110 kali/menit. Kondisi ini paling mungkin menunjukkan:
  - A. Dehidrasi ringan
  - B. Hipotermia
  - C. Infeksi puerperal
  - D. Hipogalaktia
  - E. Bradikardia
4. Seorang ibu nifas datang dengan keluhan nyeri pada payudara, kemerahan, demam, dan malaise. Dari hasil pemeriksaan payudara ditemukan benjolan keras dan nyeri tekan hebat. Diagnosis paling tepat adalah:
  - A. Hipogalaktia
  - B. Puting lecet
  - C. Abses payudara
  - D. Kanker payudara
  - E. Mastitis



5. Seorang ibu nifas tampak sedih, kehilangan minat terhadap bayi, mengalami gangguan tidur dan pola makan yang berubah drastis. Keadaan ini sudah berlangsung selama 3 minggu setelah persalinan. Kondisi ini paling sesuai dengan:
- A. Baby blues
  - B. Depresi postpartum
  - C. Gangguan kecemasan
  - D. Psikosis postpartum
  - E. Stres ringan

### Kunci Jawaban

---

1. Jawaban: B

Pembahasan:

Fundus uteri lunak menunjukkan atonia uteri, kondisi yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum berat. Tindakan pertama adalah melakukan pengosongan kandung kemih serta stimulasi kontraksi rahim untuk menghentikan perdarahan.

2. Jawaban: C

Pembahasan:

Gejala nyeri, bengkak, kemerahan, dan adanya nanah adalah indikasi klasik infeksi luka jahitan. Infeksi ini perlu segera ditangani untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

3. Jawaban: C

Pembahasan:

Suhu tubuh lebih dari 38°C, peningkatan frekuensi napas, serta takikardia menandakan adanya kemungkinan infeksi puerperal (misalnya endometritis atau mastitis), yang memerlukan evaluasi dan penanganan segera.

4. Jawaban: E

Pembahasan:

Mastitis ditandai dengan peradangan payudara akibat infeksi bakteri dengan gejala khas berupa payudara nyeri, kemerahan, panas, dan demam.

5. Jawaban: B

Pembahasan:

Depresi postpartum ditandai dengan suasana hati sedih yang berlangsung lebih dari dua minggu pascapersalinan, disertai kehilangan minat, gangguan tidur, dan perubahan pola makan signifikan. Kondisi ini membutuhkan intervensi medis dan psikologis segera.

## G. Rangkuman Materi

Masa nifas adalah periode pemulihan tubuh ibu setelah persalinan, khususnya organ reproduksi. Pemeriksaan fisik ibu nifas bertujuan memantau involusi rahim, mendeteksi perdarahan abnormal (lochia), dan memastikan penyembuhan luka jahitan. Pemeriksaan dilakukan secara rutin agar komplikasi terdeteksi dini.

### 1. Pemeriksaan Fundus Uteri:

- Fundus adalah bagian tertinggi rahim; posisinya berubah seiring involusi rahim.
- Pemeriksaan dilakukan dengan palpasi saat ibu berbaring dengan lutut ditekuk.
- Fundus normal keras, bulat, turun sekitar 1 cm per hari dari posisi umbilikus setelah persalinan.
- Fundus lunak (atonia uteri) menandakan risiko perdarahan; perlu stimulasi kontraksi rahim.
- Fundus yang tidak turun sesuai waktu mengindikasikan retensi plasenta atau infeksi.

### 2. Pemeriksaan Perdarahan Nifas (Lochia):

- Lochia adalah darah pascapersalinan yang berubah warna seiring waktu:
  - Lochia Rubra (1-3 hari): merah segar.
  - Lochia Serosa (4-10 hari): coklat muda atau merah muda.
  - Lochia Alba (10 hari - 6 minggu): putih kekuningan.
- Tanda abnormal: perdarahan berlebihan (>500 ml), bau busuk, perubahan warna tidak normal, adanya nanah. Perlu intervensi medis segera jika ditemukan tanda abnormal.

### 3. Pemeriksaan Luka Jahitan:

- Inspeksi untuk kemerahan, edema, nanah, perdarahan, atau dehiscence (luka terbuka).
- Palpasi untuk nyeri, abses, atau hematoma.
- Tanda komplikasi: infeksi (kemerahan, nyeri hebat, nanah), hematoma, luka tidak sembuh normal.
- Edukasi menjaga kebersihan luka, mengenali tanda infeksi, dan kontrol rutin.

### 4. Penilaian Tanda Vital dan Status Umum:

- Tekanan darah normal: 90/60 - 140/90 mmHg.
- Denyut nadi normal: 60-100 bpm; abnormal jika takikardia (>100 bpm) atau bradikardia (<60 bpm).
- Suhu tubuh normal: 36,5-37,5°C; demam (>38°C) bisa tanda infeksi.
- Frekuensi napas normal: 12-20 kali per menit; abnormal jika takipnea (>20) atau bradipnea (<12).

- e. Status umum mencakup kesadaran, warna kulit (pucat/sianosis), hidrasi, dan nutrisi.
- 5. Pemeriksaan Payudara dan Proses Menyusui:
  - a. Pemeriksaan meliputi observasi (bentuk, ukuran, kulit, puting) dan palpasi (benjolan, nyeri, mastitis).
  - b. Evaluasi teknik menyusui (posisi, pelekatan bayi, durasi).
  - c. Komplikasi: mastitis, puting lecet, produksi ASI rendah.
  - d. Bidan memberikan edukasi teknik menyusui, mengidentifikasi masalah dini, dan mendukung ASI eksklusif.
- 6. Pemeriksaan Kesehatan Mental:
  - a. Penting untuk mendeteksi gangguan mental (baby blues, depresi postpartum, kecemasan).
  - b. Metode: wawancara klinis sensitif dan skrining dengan EPDS, PHQ-9, GAD-7.
  - c. Faktor risiko: dukungan sosial rendah, riwayat gangguan mental, komplikasi persalinan, stres kehidupan, kurang pengetahuan.
  - d. Tanda utama: perubahan suasana hati, gangguan tidur, kecemasan, pikiran negatif atau menyakiti diri sendiri.
  - e. Bidan memberikan edukasi, dukungan emosional, dan rujukan jika diperlukan.
- 7. Pengkajian Kebutuhan Edukasi dan Dukungan Sosial:
  - a. Edukasi tentang perawatan diri, tanda bahaya nifas, menyusui, kontrasepsi, aktivitas fisik.
  - b. Evaluasi dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan.
  - c. Hambatan sosial budaya atau ekonomi harus diidentifikasi untuk intervensi tepat.
  - d. Perencanaan asuhan secara personalisasi, optimalisasi dukungan sosial, konseling, dan monitoring secara rutin.

## H. Glosarium

**Atonia Uteri:** Kondisi rahim yang tidak mampu berkontraksi dengan optimal setelah persalinan, menyebabkan perdarahan postpartum.

**Baby Blues:** Kondisi psikologis ringan yang umum terjadi pada ibu setelah persalinan, biasanya hilang sendiri dalam waktu 1-2 minggu.

**Bradikardia:** Kondisi denyut nadi yang rendah (<60 bpm), bisa disebabkan oleh gangguan sistemik atau obat-obatan.

**Bradipnea:** Frekuensi pernapasan yang lambat (<12 kali/menit), dapat disebabkan gangguan neurologis atau efek obat.

**Dehiscence:** Kondisi terbukanya kembali luka jahitan sebagian atau seluruhnya setelah proses penjahitan.

**Depresi Postpartum:** Kondisi depresi berat yang dialami ibu setelah persalinan, berlangsung lebih dari dua minggu dan membutuhkan penanganan medis.

**Edema:** Pembengkakan jaringan tubuh akibat penumpukan cairan di dalamnya.

**Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS):** Alat skrining standar untuk mendeteksi risiko depresi postpartum pada ibu.

**Episiotomi:** Sayatan bedah pada perineum untuk memperbesar jalan lahir saat persalinan.

**Fundus Uteri:** Bagian tertinggi rahim yang posisinya mengalami perubahan selama masa involusi pascapersalinan.

**Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7):** Alat skrining yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kecemasan umum pada seseorang.

**Granulasi:** Pertumbuhan jaringan baru sebagai bagian dari proses penyembuhan luka.

**Hematoma:** Kumpulan darah yang menggumpal di jaringan akibat perdarahan internal.

**Hipogalaktia:** Kondisi produksi Air Susu Ibu (ASI) yang rendah.

**Infeksi Puerperal:** Infeksi pada saluran reproduksi setelah persalinan, misalnya endometritis.

**Involusi Rahim:** Proses rahim kembali ke ukuran dan posisi normal setelah kehamilan dan persalinan.

**Lochia:** Perdarahan nifas yang keluar dari jalan lahir setelah persalinan, terdiri dari tiga tahap yaitu Lochia Rubra, Serosa, dan Alba.

**Lochia Alba:** Tahap akhir perdarahan nifas, berwarna putih kekuningan, mengandung leukosit dan lendir, terjadi dari hari ke-10 hingga minggu ke-6.

**Lochia Rubra:** Tahap pertama perdarahan nifas, berwarna merah segar, terdiri dari darah dan jaringan decidua, terjadi selama 1-3 hari pertama.

**Lochia Serosa:** Tahap kedua perdarahan nifas, berwarna coklat muda atau merah muda, terdiri dari serum, lendir, dan sedikit darah, berlangsung dari hari ke-4 hingga ke-10.

**Mastitis:** Inflamasi atau peradangan pada jaringan payudara akibat infeksi bakteri, umumnya disertai gejala nyeri, demam, dan kemerahan pada payudara.

**Palpasi:** Teknik pemeriksaan fisik dengan cara meraba bagian tubuh untuk menilai kondisi jaringan atau organ dalam tubuh.

**Patient Health Questionnaire (PHQ-9):** Instrumen untuk mengukur tingkat depresi yang dialami seseorang.

**Pelekatan Bayi (Latch On):** Cara bayi melekatkan mulut pada payudara ibu yang benar, memastikan pemberian ASI efektif dan nyaman.

**Psikosis Postpartum:** Gangguan mental serius pascapersalinan yang ditandai dengan halusinasi, delusi, atau kebingungan berat, memerlukan penanganan darurat.

**Retensi Plasenta:** Kondisi sisa plasenta yang tertinggal dalam rahim setelah persalinan.

**Sianosis:** Warna kebiruan pada kulit atau mukosa akibat kekurangan oksigen dalam darah.

**Subinvolusi:** Kondisi rahim yang gagal mengecil secara normal setelah persalinan, sering dikaitkan dengan infeksi atau retensi plasenta.

**Takikardia:** Kondisi denyut nadi yang meningkat ( $>100$  bpm), dapat disebabkan perdarahan, infeksi, atau kecemasan.

**Takipnea:** Frekuensi pernapasan yang cepat ( $>20$  kali/menit), dapat menjadi tanda gangguan fisiologis atau psikologis.

## I. Daftar Pustaka

- Abalos, E., & Chamillard, M. (2021). Postpartum haemorrhage management: Current evidence and guidelines. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 152(S1), 3-10. <https://doi.org/10.1002/ijgo.13451>
- ACOG Committee Opinion No. 757. (2018). Screening for perinatal depression. *Obstetrics & Gynecology*, 132(5), e208–e212. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002927>
- Ahmad, M. O., Sughra, U., Kalsoom, U., Imran, M., & Hadi, U. (2020). Early recognition and management of postpartum sepsis. *Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*, 33(8), 1375-1380. <https://doi.org/10.1080/14767058.2018.1517319>
- American Academy of Pediatrics. (2019). Breastfeeding and the use of human milk. *Pediatrics*, 144(2), e20191427. <https://doi.org/10.1542/peds.2019-1427>
- Chapman, D. J., & Pérez-Escamilla, R. (2020). Breastfeeding interventions and outcomes: A systematic review. *Maternal & Child Nutrition*, 16(3), e12992. <https://doi.org/10.1111/mcn.12992>

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). McGraw-Hill Education.
- Davidson, M. R., London, M. L., & Ladewig, P. W. (2020). *Olds' maternal-newborn nursing & women's health across the lifespan* (11th ed.). Pearson Education.
- Fahey, J. O., & Shenassa, E. (2019). Understanding and managing postpartum depression. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 64(2), 139-147. <https://doi.org/10.1111/jmwh.12962>
- Gilmartin, C. E., & Amir, L. H. (2021). Assessment and management of mastitis and breast abscess in breastfeeding women. *BMJ*, 372, n450. <https://doi.org/10.1136/bmj.n450>
- Grylka-Baeschlin, S., van Teijlingen, E., & Gross, M. M. (2021). Postpartum perineal wound care: Practices, outcomes, and research gaps. *Midwifery*, 96, 102942. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.102942>
- Hutabarat, R. L., & Setyowati. (2020). Manajemen asuhan kebidanan masa nifas dan menyusui. *Jurnal Kebidanan*, 9(1), 62-69. <https://doi.org/10.31983/jkb.v9i1.5848>
- Jones, E., Jomeen, J., & Hayter, M. (2021). Midwives' role in promoting positive maternal mental health postpartum. *Midwifery*, 94, 102904. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102904>
- Lawrence, R. A., & Lawrence, R. M. (2021). *Breastfeeding: A guide for the medical profession* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2020). *Maternity and women's health care* (12th ed.). Elsevier Health Sciences.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., & Nelson, K. A. (2018). *Maternal-child nursing* (5th ed.). Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization. (2021). Mental health in pregnancy and postnatal period. Retrieved from [https://www.who.int/mental\\_health/maternal-child/maternal\\_mental\\_health/en/](https://www.who.int/mental_health/maternal-child/maternal_mental_health/en/)
- World Health Organization. (2021). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240035164>
- Xu, H., Ding, Y., Ma, Y., Xin, X., Zhang, D., & Wu, Q. (2021). Breastfeeding support interventions and their effectiveness: A systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 77(5), 2154-2169. <https://doi.org/10.1111/jan.14700>
- Yonkers, K. A., Smith, M. V., Forray, A., Epperson, C. N., Costello, D., Lin, H., & Belanger, K. (2020). Management of postpartum depression and anxiety. *American Journal of Psychiatry*, 177(11), 1017-1029. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2020.20020296>
- Zheng, X., Zhang, L., Chen, Y., & Wang, X. (2020). Risk factors and preventive strategies for postpartum hemorrhage. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-2731-8>

# Bab 4

## Perawatan dan Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode yang sangat penting dalam proses pemulihan ibu setelah persalinan. Selama masa ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis dan psikologis yang memerlukan perhatian khusus agar proses penyembuhan berlangsung optimal dan risiko komplikasi dapat diminimalkan. Asuhan kebidanan yang komprehensif meliputi manajemen perdarahan nifas, perawatan luka bekas persalinan, dukungan menyusui, pemenuhan nutrisi, serta pencegahan dan penanganan komplikasi yang mungkin timbul. Bidan memiliki peran sentral dalam memberikan perawatan yang tepat, memberikan edukasi, serta mendukung ibu agar dapat menjalani masa nifas dengan nyaman dan sehat. Dengan pendekatan holistik, asuhan kebidanan masa nifas tidak hanya menjaga kesehatan fisik tetapi juga mental dan sosial ibu, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip dan praktik perawatan serta asuhan kebidanan pada masa nifas secara komprehensif, termasuk manajemen perdarahan, perawatan luka persalinan, dukungan menyusui, nutrisi, dan pencegahan komplikasi, guna meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan yang meliputi manajemen perdarahan nifas, perawatan luka persalinan, pemberian dukungan menyusui, pemantauan nutrisi, serta pencegahan dan penanganan komplikasi pada ibu nifas secara efektif dan profesional.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Menjelaskan mekanisme, pencegahan, dan penanganan perdarahan nifas normal dan abnormal.
2. Melaksanakan perawatan luka bekas persalinan pada perineum, episiotomi, dan operasi sesar dengan teknik aseptik dan komunikasi efektif.
3. Memberikan dukungan dan promosi menyusui melalui inisiasi menyusui dini, teknik menyusui yang benar, dan edukasi mengenai ASI eksklusif.
4. Mengidentifikasi kebutuhan nutrisi pada masa nifas dan merencanakan asuhan yang sesuai untuk pemenuhan gizi ibu.
5. Mendeteksi, mencegah, dan menangani komplikasi nifas seperti infeksi puerperal, trombosis, dan depresi postpartum dengan pendekatan multidisipliner.



## **A. Manajemen Perdarahan Nifas Normal dan Abnormal (Pencegahan dan Penanganan)**

Perdarahan nifas adalah proses fisiologis keluarnya darah dan sisa jaringan dari rahim setelah persalinan sebagai bagian dari proses involusi uterus. Namun, perdarahan yang berlebihan atau abnormal selama masa nifas dapat mengancam keselamatan ibu dan menjadi salah satu penyebab utama kematian maternal di dunia, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, manajemen perdarahan nifas yang tepat, mulai dari pencegahan hingga penanganan, merupakan bagian penting dalam asuhan kebidanan masa nifas.

### **1. Perdarahan Nifas Normal**

Perdarahan nifas normal terjadi akibat peluruhan endometrium dan regenerasi lapisan uterus setelah plasenta lahir. Ciri-ciri perdarahan nifas normal meliputi:

- a. Jumlah: Volume darah yang keluar biasanya berkurang secara bertahap selama 2 sampai 6 minggu pascapersalinan. Pada 24 jam pertama, perdarahan dapat mencapai 240–270 ml.
- b. Warna: Perdarahan diawali dengan warna merah segar (lochia rubra), kemudian berubah menjadi coklat kemerahan (lochia serosa), dan akhirnya menjadi kuning keputihan (lochia alba).
- c. Konsistensi: Darah biasanya encer, tanpa gumpalan besar.
- d. Bau: Tidak berbau busuk, karena merupakan proses alami.

Perdarahan ini tidak menimbulkan gejala syok atau gangguan kesehatan pada ibu.

### **2. Pencegahan Perdarahan Abnormal**

Perdarahan abnormal atau perdarahan postpartum adalah perdarahan yang melebihi batas normal sehingga mengancam kesehatan ibu. Pencegahan perdarahan abnormal meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemberian Oksitosin
  - 1) Oksitosin diberikan segera setelah plasenta lahir untuk merangsang kontraksi rahim sehingga mengurangi risiko atonia uteri, penyebab utama perdarahan postpartum.
  - 2) Oksitosin dapat diberikan secara intravena atau intramuskular sesuai protokol.
- b. Pemantauan Fundus Uteri dan Tanda Vital
  - 1) Pemeriksaan fundus uteri secara rutin penting untuk memastikan rahim berkontraksi dan posisi fundus menurun sesuai waktu.
  - 2) Pemantauan tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, suhu) secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda perdarahan atau syok.



- c. Pengosongan Kandung Kemih Secara Rutin
  - 1) Kandung kemih yang penuh dapat menekan rahim sehingga mengganggu kontraksi dan involusi uterus, meningkatkan risiko perdarahan.
  - 2) Oleh karena itu, bidan harus mendorong ibu untuk berkemih secara teratur atau membantu pengosongan jika diperlukan.
- d. Perawatan dan Penanganan Persalinan yang Baik

Menghindari trauma berlebihan pada jalan lahir dan penanganan persalinan dengan teknik yang tepat untuk meminimalkan risiko robekan dan perdarahan.

### **3. Penanganan Perdarahan Abnormal**

Apabila terjadi perdarahan abnormal, penanganan yang cepat dan tepat sangat menentukan hasil akhir. Langkah-langkah penanganan meliputi:

- a. Kompresi Fundus Uteri
- b. Kompresi manual fundus dilakukan untuk merangsang kontraksi uterus secara langsung dan memperkecil rongga rahim agar perdarahan berkurang.
- c. Kompresi dilakukan dengan tangan satu memegang fundus dari atas, tangan lain mendukung bawah abdomen.

### **4. Pemberian Obat Uterotonik**

- a. Selain oksitosin, obat uterotonik lain seperti ergometrin atau prostaglandin dapat diberikan sesuai indikasi dan protokol untuk meningkatkan kontraksi rahim dan menghentikan perdarahan.
- b. Pemilihan obat tergantung kondisi ibu, ketersediaan obat, dan kontraindikasi.

### **5. Penanganan Perdarahan Berat**

- a. Jika perdarahan tidak terkontrol dan menyebabkan anemia berat atau syok, transfusi darah harus segera dilakukan untuk menggantikan volume darah yang hilang dan memperbaiki perfusi jaringan.
- b. Stabilitas hemodinamik ibu harus dipantau ketat selama proses ini.

### **6. Intervensi Medis Lanjutan dan Rujukan**

- a. Bila perdarahan tidak bisa dikendalikan dengan tindakan konservatif, rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut harus dilakukan.
- b. Tindakan bedah seperti pengangkatan sisa plasenta, ligasi pembuluh darah, embolisasi arteri uterina, atau bahkan histerektomi dapat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa ibu.

## **B. Perawatan Luka Bekas Persalinan (Perineum, Episiotomi, Operasi Sesar)**

Luka bekas persalinan merupakan area tubuh yang paling rentan mengalami infeksi dan komplikasi selama masa nifas. Luka ini meliputi robekan perineum spontan, episiotomi (insisi yang dibuat untuk memperlebar jalan lahir), serta luka operasi sesar pada dinding abdomen. Perawatan yang tepat dan cermat pada luka bekas persalinan sangat penting untuk mempercepat proses penyembuhan, mencegah infeksi, mengurangi rasa nyeri, serta meningkatkan kenyamanan ibu selama masa pemulihan. Bidan sebagai tenaga kesehatan utama memiliki peran penting dalam melakukan perawatan luka dan memberikan edukasi yang memadai kepada ibu.

### **1. Perawatan Luka Perineum dan Episiotomi**

Luka di perineum dan bekas episiotomi membutuhkan perawatan khusus untuk memastikan proses penyembuhan optimal dan mencegah infeksi.

Langkah-langkah Perawatan:

#### **a. Pembersihan Luka**

Luka perineum dan episiotomi harus dibersihkan secara rutin dengan menggunakan air hangat dan sabun ringan yang tidak mengiritasi kulit. Pembersihan ini penting untuk menghilangkan kotoran dan mencegah bakteri berkembang biak.

- 1) Lakukan pembersihan setiap setelah buang air kecil dan buang air besar.
- 2) Gunakan handuk atau kain bersih untuk mengeringkan area secara lembut, jangan digosok.

#### **b. Kompres Dingin**

Pada 24 jam pertama pascapersalinan, pemberian kompres dingin pada area luka sangat dianjurkan untuk mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri.

- 1) Kompres dilakukan beberapa kali sehari selama 10-15 menit.
- 2) Pastikan kompres dibungkus kain bersih agar tidak langsung mengenai kulit.

#### **c. Posisi Duduk dan Buang Air Besar yang Nyaman**

Posisi duduk harus nyaman dan menghindari tekanan berlebih pada area luka.

- 1) Gunakan bantal berbentuk donat atau bantal empuk saat duduk untuk mengurangi tekanan pada perineum.
- 2) Anjurkan ibu untuk tidak menahan buang air besar dan mengonsumsi makanan berserat tinggi agar proses defekasi lancar tanpa mengejan keras, yang dapat merusak luka.

#### **d. Pemantauan Tanda-tanda Infeksi**

Bidan harus secara rutin memeriksa luka untuk tanda-tanda infeksi, yaitu:

- 1) Kemerahan yang meluas atau semakin intens.

- 2) Pembengkakan yang tidak berkurang.
  - 3) Nyeri yang meningkat tajam atau berdenyut hebat.
  - 4) Keluarnya nanah, cairan berbau busuk, atau darah yang tidak biasa.
  - 5) Demam atau tanda-tanda sistemik infeksi.
- e. Edukasi kepada Ibu
- Ibu perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan area luka, tanda bahaya infeksi yang harus diwaspadai, dan kapan harus segera mencari pertolongan medis.

## **2. Perawatan Luka Operasi Sesar**

Luka operasi sesar adalah luka sayatan di dinding perut yang memerlukan perawatan khusus agar penyembuhan optimal dan komplikasi minimal.

Langkah-langkah Perawatan:

a. Sterilisasi Area Luka

Setiap kali mengganti perban, area luka harus dibersihkan dengan antiseptik yang dianjurkan oleh tenaga medis.

- 1) Gunakan teknik aseptik untuk mencegah masuknya kuman.
- 2) Ganti perban secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan, biasanya setiap 24-48 jam.

b. Pemantauan Luka

Perhatikan tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, keluarnya cairan atau nanah, bau tidak sedap, serta nyeri yang berlebihan.

- 1) Catat perubahan warna atau pembesaran luka.
- 2) Periksa suhu tubuh ibu secara berkala sebagai indikator infeksi.

c. Istirahat yang Cukup dan Hindari Beban Berat

Ibu dianjurkan untuk banyak beristirahat dan menghindari aktivitas berat atau mengangkat beban untuk mengurangi tekanan pada luka operasi sehingga mempercepat proses penyembuhan. Mobilisasi ringan dianjurkan sesuai kemampuan untuk mencegah komplikasi lain seperti trombosis.

d. Edukasi Tanda Bahaya

Edukasi ibu untuk mengenali tanda-tanda komplikasi luka operasi sesar, seperti keluarnya darah segar berlebihan, rasa nyeri yang tidak berkurang, demam tinggi, dan keluarnya nanah. Instruksikan kapan harus segera ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

## C. Dukungan dan Promosi Menyusui (Inisiasi Menyusui Dini, Teknik Menyusui, ASI Eksklusif)

Menyusui adalah bagian penting dari asuhan kebidanan pada masa nifas karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan ibu dan bayi. Dukungan yang tepat dari tenaga kesehatan, khususnya bidan, sangat berperan dalam keberhasilan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, yang merupakan standar gizi terbaik untuk bayi hingga usia enam bulan. Aspek penting dalam mendukung menyusui meliputi Inisiasi Menyusui Dini (IMD), teknik menyusui yang benar, dan edukasi terkait ASI eksklusif untuk mengatasi mitos dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki ibu.

### 1. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

#### a. Pengertian IMD

Inisiasi Menyusui Dini adalah tindakan mendukung ibu dan bayi melakukan kontak kulit-ke-kulit segera setelah lahir dan menyusui dalam waktu satu jam pertama pasca persalinan. IMD sangat dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF karena terbukti dapat meningkatkan keberhasilan menyusui dan kesehatan bayi.

#### b. Manfaat IMD

- 1) Merangsang refleks menyusu pada bayi secara alami.
- 2) Meningkatkan produksi ASI dengan merangsang hormon oksitosin dan prolaktin pada ibu.
- 3) Memperkuat ikatan emosional (bonding) antara ibu dan bayi.
- 4) Mengurangi risiko kematian neonatal dan meningkatkan suhu tubuh bayi.

#### c. Praktik IMD

- 1) Setelah bayi lahir, bayi ditempatkan langsung di dada ibu untuk kontak kulit-ke-kulit tanpa penghalang.
- 2) Bayi dibiarkan mencari puting susu dan mulai menyusu secara spontan.
- 3) Jangan memisahkan bayi dan ibu kecuali ada indikasi medis mendesak.

### 2. Teknik Menyusui

#### a. Posisi Menyusui yang Benar

- 1) Cradle hold: Bayi dipeluk menghadap ibu dengan kepala di lekuk siku.
- 2) Cross cradle: Ibu menopang bayi dengan tangan berlawanan dari payudara yang menyusui.
- 3) Football hold: Bayi diposisikan di sisi ibu, di bawah lengan.
- 4) Side-lying position: Ibu dan bayi berbaring miring menghadap satu sama lain, cocok untuk ibu pasca operasi sesar.

#### b. Pelekatan Bayi (Latch On)

- 1) Mulut bayi harus terbuka lebar, bibir bawah terlipat keluar, dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi, bukan hanya puting.

- 2) Posisi pelekatan yang tepat mengurangi risiko puting lecet dan memastikan bayi mendapat ASI secara efektif.
- c. Penanganan Masalah Umum
  - 1) Puting Lecet: Penyebabnya pelekatan yang salah, posisi menyusui yang kurang tepat, atau infeksi jamur. Penanganan meliputi perbaikan teknik menyusui, penggunaan krim pelindung puting, dan perawatan luka.
  - 2) Engorgement (Pembengkakan Payudara): Terjadi akibat penumpukan ASI yang berlebihan. Penanganan meliputi menyusui lebih sering, pijat payudara, dan kompres hangat.
3. Edukasi ASI Eksklusif
  - a. Manfaat ASI Eksklusif
    - 1) Menyediakan nutrisi lengkap dan seimbang bagi bayi.
    - 2) Meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi dan melindungi dari infeksi.
    - 3) Meningkatkan perkembangan otak dan pertumbuhan optimal.
    - 4) Menurunkan risiko alergi dan penyakit kronis di masa depan.
    - 5) Membantu kontraksi rahim dan pemulihan ibu.
  - b. Mengatasi Mitos dan Kekhawatiran
    - 1) Edukasi bahwa ASI yang keluar pertama (kolostrum) sangat bergizi dan penting meski jumlahnya sedikit.
    - 2) Mengklarifikasi bahwa susu formula tidak sebaik ASI dan tidak dianjurkan sebelum usia 6 bulan.
    - 3) Memberikan solusi untuk masalah umum seperti produksi ASI rendah atau kesulitan menyusui.

## **D. Nutrisi pada Masa Nifas**

Masa nifas adalah periode penting bagi ibu untuk pemulihan fisik dan mental setelah persalinan serta memulai proses menyusui. Nutrisi yang adekuat selama masa ini sangat krusial karena mempengaruhi kemampuan tubuh ibu untuk menyembuhkan luka, mengembalikan kondisi fisik, dan memenuhi kebutuhan nutrisi bayi melalui Air Susu Ibu (ASI). Kekurangan gizi pada masa nifas dapat memperlambat penyembuhan, menurunkan kualitas ASI, dan berisiko menimbulkan komplikasi kesehatan bagi ibu dan bayi.

### **1. Prinsip Nutrisi Seimbang pada Masa Nifas**

- a. Konsumsi Makanan Bergizi Seimbang
  - 1) Karbohidrat sebagai sumber energi utama harus cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu yang sedang dalam masa pemulihan dan menyusui. Sumber yang baik adalah nasi, roti, kentang, dan umbi-umbian.

- 2) Protein sangat penting untuk regenerasi jaringan dan produksi ASI. Protein berkualitas tinggi dapat diperoleh dari daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan tahu/tempe.
  - 3) Lemak sehat diperlukan untuk asupan energi dan pembentukan hormon. Lemak tak jenuh dari ikan, minyak zaitun, dan kacang-kacangan dianjurkan.
  - 4) Vitamin dan mineral penting untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk vitamin A, C, D, zat besi, kalsium, dan zinc. Buah-buahan, sayuran hijau, dan produk susu adalah sumber utama.
  - 5) Hindari makanan tinggi gula dan lemak jenuh yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu.
- b. Asupan Cairan yang Cukup
- 1) Cairan diperlukan untuk menjaga hidrasi dan produksi ASI.
  - 2) Dianjurkan mengonsumsi minimal 8-10 gelas air putih per hari, termasuk dari susu, jus buah, dan sup.
  - 3) Hindari minuman berkafein atau beralkohol yang dapat mengganggu produksi ASI dan kesehatan ibu.

## **2. Kebutuhan Kalori Tambahan Selama Menyusui**

- a. Ibu menyusui memerlukan kalori tambahan sekitar 500 kkal per hari dibandingkan kebutuhan normal untuk mendukung produksi ASI dan pemulihan tubuh.
- b. Asupan kalori yang cukup membantu menjaga energi ibu dan kualitas ASI agar memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.
- c. Perlu diingat bahwa kalori tambahan ini harus berasal dari sumber makanan bergizi dan bukan dari makanan cepat saji atau tidak sehat.

## **3. Rekomendasi Pola Makan**

- a. Konsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering (5-6 kali sehari) untuk menjaga energi dan metabolisme.
- b. Prioritaskan makanan yang mudah dicerna dan kaya serat untuk mencegah konstipasi, yang umum terjadi pada masa nifas.
- c. Perhatikan asupan zat besi untuk mencegah anemia, terutama bagi ibu dengan perdarahan pascapersalinan.
- d. Konsumsi kalsium dan vitamin D untuk mendukung kesehatan tulang ibu dan bayi.

## **4. Peran Bidan dalam Konseling Nutrisi**

- a. Memberikan edukasi tentang pentingnya nutrisi seimbang dan hidrasi selama masa nifas.
- b. Membantu ibu merencanakan menu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.
- c. Mengidentifikasi masalah gizi dan merujuk ke ahli gizi jika diperlukan.

- d. Memotivasi ibu untuk mempertahankan pola makan sehat demi kesehatan ibu dan bayi.

## **E. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Nifas (Infeksi, Trombosis, Depresi Postpartum)**

Masa nifas adalah periode yang rawan komplikasi kesehatan yang dapat membahayakan ibu jika tidak dicegah dan ditangani dengan baik. Tiga komplikasi utama yang sering terjadi adalah infeksi puerperal, trombosis, dan depresi postpartum. Ketiga kondisi ini membutuhkan perhatian khusus oleh tenaga kebidanan karena dapat berdampak serius pada kesehatan fisik dan mental ibu serta kualitas asuhan bayi. Oleh sebab itu, pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang tepat sangat penting dalam asuhan kebidanan masa nifas.

### **1. Infeksi Puerperal**

#### **a. Definisi dan Penyebab**

Infeksi puerperal adalah infeksi yang terjadi selama masa nifas akibat masuknya mikroorganisme ke dalam organ reproduksi ibu, terutama uterus, saluran kemih, luka jahitan, atau payudara.

#### **b. Pencegahan**

##### **1) Teknik Aseptik**

Pelaksanaan prosedur medis dan perawatan luka dengan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi bakteri.

##### **2) Kebersihan Diri Ibu**

Edukasi ibu tentang pentingnya menjaga kebersihan genital dan area luka persalinan.

##### **3) Perawatan Luka**

Perawatan luka perineum, episiotomi, dan luka operasi sesar secara benar untuk mengurangi risiko infeksi.

##### **4) Pemantauan Ketat**

Memantau tanda-tanda awal infeksi seperti demam, nyeri, kemerahan, dan keluarnya cairan abnormal.

#### **c. Penanganan**

##### **1) Antibiotik Sesuai Indikasi**

Pemberian antibiotik spektrum luas atau sesuai hasil kultur bila tersedia, terutama pada kasus endometritis, mastitis, atau infeksi luka.

##### **2) Perawatan Supportif**

Istirahat cukup, hidrasi, dan kontrol nyeri.

##### **3) Rujukan**

Bila infeksi berat atau tidak membaik, segera rujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

## 2. Trombosis

### a. Definisi dan Risiko

Trombosis vena dalam adalah pembentukan bekuan darah di vena dalam ekstremitas bawah yang dapat terjadi pada ibu nifas karena keadaan hiperkoagulabilitas, imobilisasi, dan trauma saat persalinan.

### b. Pencegahan

#### 1) Mobilisasi Dini

Mendorong ibu melakukan aktivitas ringan dan berjalan sesegera mungkin setelah persalinan untuk meningkatkan sirkulasi darah.

#### 2) Penggunaan Stoking Kompresi

Pada ibu dengan risiko tinggi, penggunaan stoking elastis dapat membantu mencegah pembentukan trombus.

#### 3) Hidrasi Adekuat

Memastikan asupan cairan yang cukup untuk mengurangi kekentalan darah.

### c. Deteksi Dini

1) Periksa pembengkakan, kemerahan, nyeri tekan, dan peningkatan suhu pada ekstremitas bawah.

2) Waspada tanda-tanda trombosis vena dalam, seperti nyeri betis saat dorsifleksi kaki (tanda Homans).

### d. Penanganan

#### 1) Rujukan Cepat

Segera rujuk ke dokter spesialis apabila dicurigai trombosis.

#### 2) Terapi Antikoagulan

3) Pemberian obat pengencer darah sesuai anjuran medis untuk mencegah pembesaran bekuan darah dan emboli paru.

## 3. Depresi Postpartum

### a. Definisi dan Dampak

Depresi postpartum adalah gangguan mood yang terjadi pada ibu setelah melahirkan, ditandai oleh perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, dan gangguan fungsi sosial. Kondisi ini dapat mengganggu ikatan ibu-bayi dan peran ibu.

### b. Pencegahan dan Skrining

#### 1) Skrining Rutin

Menggunakan alat skrining seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) untuk mendeteksi dini depresi.

#### 2) Dukungan Psikososial

Memberikan dukungan emosional, konseling, dan melibatkan keluarga dalam proses pemulihan.



c. Penanganan

1) Rujukan ke Layanan Kesehatan Mental

Ibu yang didiagnosis depresi postpartum harus dirujuk ke psikolog atau psikiater untuk terapi lanjutan.

2) Terapi Psikologis dan Medis

Meliputi konseling, terapi perilaku kognitif, dan bila perlu pemberian obat antidepresan sesuai pengawasan medis.

## F. Latihan Soal

### Tugas

#### Tugas 1

**Kasus:**

Seorang ibu 30 tahun, hari ke-1 pascapersalinan normal, mengeluh darah nifas keluar deras dan disertai pusing. Hasil palpasi fundus menunjukkan uterus lunak dan tinggi di atas pusat.

Pertanyaan:

Analisis kondisi ini dan jelaskan langkah-langkah manajemen kebidanan yang harus segera dilakukan untuk menangani perdarahan nifas dini. Sertakan upaya edukasi yang harus diberikan kepada ibu dan keluarga.

#### Tugas 2

**Kasus:**

Ibu hari ke-4 pasca operasi sesar datang ke klinik dengan keluhan luka terasa nyeri, tampak merah, dan keluar cairan kekuningan.

Pertanyaan:

Uraikan langkah-langkah perawatan luka operasi sesar yang sesuai standar asuhan kebidanan. Apa saja tanda-tanda infeksi luka yang harus dimonitor? Jelaskan juga komunikasi efektif yang perlu digunakan dalam memberikan edukasi pada ibu tentang perawatan luka di rumah.

#### Tugas 3

**Kasus:**

Seorang ibu menyusui mengeluh bayinya sering menangis saat menyusui dan putingnya terasa nyeri. Ibu tampak cemas dan mulai ragu memberikan ASI.

Pertanyaan:

Jelaskan teknik menyusui yang benar yang perlu diajarkan kepada ibu. Bagaimana cara bidan memberikan dukungan menyusui secara psikososial untuk mencegah ibu berhenti menyusui?

## **Tugas 4**

### **Kasus:**

Ibu usia 35 tahun hari ke-5 nifas tampak lemas dan mengeluh tidak nafsu makan. Dari hasil pengkajian, berat badan turun drastis dan Hb 9 g/dL.

Pertanyaan:

Analisis kebutuhan nutrisi ibu nifas dalam kondisi ini. Buatlah rencana intervensi asuhan kebidanan yang meliputi pemenuhan gizi dan pemantauan lanjutan.

## **Tugas 5**

### **Esai:**

Jelaskan secara menyeluruh tiga komplikasi yang umum terjadi pada masa nifas (infeksi puerperal, trombosis vena dalam, dan depresi postpartum). Sertakan deteksi dini, pencegahan, serta strategi penanganan yang dapat dilakukan oleh bidan melalui kolaborasi multidisipliner.

## **Pilihan Ganda**

---

1. Seorang ibu baru melahirkan bayi pervaginam sekitar 3 jam lalu. Saat observasi, bidan mendapati ibu mengalami perdarahan sebanyak dua pembalut penuh dalam waktu kurang dari satu jam terakhir. Fundus uteri teraba lembek dan tinggi di atas pusat. Apa tindakan pertama yang paling tepat?
  - A. Memberikan antibiotik profilaksis
  - B. Melakukan kompresi manual fundus uteri
  - C. Mengajarkan ibu teknik pernapasan dalam
  - D. Memberikan asupan cairan oral
  - E. Meminta ibu untuk segera mobilisasi dini
2. Ibu nifas hari ke-4 mengeluhkan nyeri hebat pada luka episiotomi. Saat pemeriksaan, didapatkan area jahitan kemerahan, bengkak, dan terdapat cairan kekuningan. Suhu tubuh ibu 38,5°C. Apa langkah penanganan yang paling tepat?
  - A. Memberikan kompres dingin
  - B. Menyarankan ibu lebih sering mandi air hangat
  - C. Melakukan pembersihan luka dengan air sabun
  - D. Segera memberikan antibiotik spektrum luas
  - E. Menyarankan ibu istirahat total tanpa mobilisasi
3. Ibu baru melahirkan pervaginam sekitar 30 menit yang lalu. Plasenta sudah lahir lengkap. Apa langkah terbaik untuk mencegah perdarahan postpartum?
  - A. Menyusui bayi segera setelah plasenta lahir
  - B. Mengosongkan kandung kemih ibu segera

- C. Memberikan oksitosin intramuskular segera setelah plasenta lahir
  - D. Meminta ibu untuk istirahat total selama dua jam
  - E. Melakukan mobilisasi dini segera setelah persalinan
4. Seorang ibu nifas hari kedua mengeluhkan payudara terasa keras, bengkak, dan nyeri saat disentuh. Ia kesulitan menyusui karena nyeri tersebut. Apa tindakan yang paling tepat untuk membantu ibu?
- A. Menghentikan sementara pemberian ASI
  - B. Memberikan kompres hangat sebelum menyusui
  - C. Memberikan kompres dingin setiap jam
  - D. Memberikan antibiotik segera
  - E. Melakukan mobilisasi aktif ibu
5. Seorang ibu nifas minggu kedua mengalami perasaan sedih terus-menerus, kehilangan minat untuk merawat bayi, sulit tidur, dan merasa sangat lelah. Apa langkah awal terbaik yang harus dilakukan bidan?
- A. Merujuk segera ke psikolog atau psikiater
  - B. Menyarankan ibu untuk lebih sering istirahat
  - C. Mengajarkan teknik relaksasi sederhana
  - D. Melakukan skrining menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
  - E. Memberikan terapi antidepresan segera

### Kunci Jawaban

---

1. Jawaban: B

Pembahasan: Perdarahan berlebihan dengan fundus uteri lembek adalah tanda atonia uteri, penyebab utama perdarahan postpartum. Tindakan pertama dan utama adalah melakukan kompresi manual fundus uteri untuk merangsang kontraksi rahim dan mengurangi perdarahan.

2. Jawaban: D

Pembahasan: Gejala infeksi jelas terlihat dari kemerahan, bengkak, cairan abnormal, dan demam tinggi. Langkah utama adalah segera memberikan antibiotik spektrum luas untuk mengendalikan infeksi serta pembersihan luka secara aseptik.

3. Jawaban: C

Pembahasan: Langkah pencegahan terbaik perdarahan postpartum adalah pemberian oksitosin segera setelah plasenta lahir untuk merangsang kontraksi uterus dan mencegah atonia uteri.

4. Jawaban: B

Pembahasan: Kondisi ini merupakan tanda pembengkakan payudara (engorgement). Penanganan terbaik adalah memberikan kompres hangat sebelum menyusui untuk membantu pelepasan ASI dan mengurangi rasa nyeri serta bengkak.

5. Jawaban: D

Pembahasan: Langkah awal terbaik adalah melakukan skrining dengan EPDS untuk mengetahui tingkat keparahan depresi postpartum ibu sebelum menentukan penanganan lanjutan seperti konseling atau rujukan ke profesional kesehatan mental.

## **G. Rangkuman Materi**

### **1. Manajemen Perdarahan Nifas Normal dan Abnormal**

- a. Perdarahan nifas merupakan proses alami keluarnya darah dan jaringan dari rahim setelah melahirkan, sebagai bagian dari involusi uterus. Normalnya perdarahan berlangsung selama 2-6 minggu pascapersalinan dengan volume awal 240-270 ml pada 24 jam pertama, berwarna merah segar (lochia rubra), lalu berubah menjadi coklat kemerahan (lochia serosa), dan akhirnya kekuningan putih (lochia alba), tanpa bau busuk dan gumpalan besar.
- b. Perdarahan abnormal atau postpartum melebihi batas normal dan dapat membahayakan ibu. Pencegahannya meliputi pemberian oksitosin setelah plasenta lahir untuk mencegah atonia uteri, pemantauan fundus uteri dan tanda vital, pengosongan kandung kemih secara rutin, serta penanganan persalinan dengan hati-hati untuk menghindari trauma berlebihan.
- c. Penanganan perdarahan abnormal mencakup kompresi manual fundus uteri, pemberian uterotonik (oksitosin, ergometrin, prostaglandin), transfusi darah jika terjadi perdarahan berat, serta rujukan ke fasilitas kesehatan lanjut untuk intervensi bedah jika perdarahan tidak terkendali.

### **2. Perawatan Luka Bekas Persalinan**

- a. Perawatan luka pascapersalinan (perineum, episiotomi, operasi sesar) penting untuk mencegah infeksi, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi nyeri. Luka perineum dan episiotomi dibersihkan secara rutin dengan air hangat dan sabun ringan, diberi kompres dingin pada 24 jam pertama, dan ibu dianjurkan duduk menggunakan bantal khusus serta konsumsi serat tinggi agar tidak mengejan saat buang air besar. Tanda infeksi (kemerahan, nyeri hebat, nanah, demam) harus dipantau dan ibu segera diedukasi tanda bahaya.
- b. Luka operasi sesar perlu sterilisasi dengan antiseptik dan perban diganti setiap 24-48 jam, istirahat cukup, mobilisasi ringan, serta pemantauan ketat terhadap tanda infeksi. Edukasi penting diberikan kepada ibu mengenai tanda komplikasi agar segera mencari bantuan medis.

### **3. Dukungan dan Promosi Menyusui**

- a. Menyusui merupakan aspek penting dalam masa nifas, dimulai dengan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), kontak kulit ke kulit dalam 1 jam pertama kelahiran, untuk merangsang refleks menyusu alami bayi, meningkatkan produksi ASI, mempererat ikatan ibu dan bayi, serta mengurangi risiko kematian neonatal.
- b. Teknik menyusui yang benar meliputi cradle hold, cross cradle, football hold, dan side-lying. Pelekatan mulut bayi harus optimal untuk mencegah puting lecet. Masalah umum seperti puting lecet dan pembengkakan payudara (engorgement) diatasi dengan memperbaiki teknik menyusui dan kompres hangat.
- c. ASI eksklusif selama 6 bulan penting karena memberikan nutrisi optimal, meningkatkan kekebalan tubuh bayi, dan membantu pemulihan ibu. Edukasi tentang ASI sangat diperlukan untuk mengatasi mitos dan meningkatkan kesadaran manfaat ASI eksklusif.

### **4. Nutrisi pada Masa Nifas**

- a. Nutrisi yang cukup pada masa nifas mendukung penyembuhan luka, pemulihan tubuh, dan produksi ASI berkualitas. Prinsipnya adalah konsumsi makanan bergizi seimbang dengan karbohidrat kompleks, protein tinggi (daging, ikan, telur, kacang-kacangan), lemak sehat (ikan, minyak zaitun), serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah. Asupan cairan minimal 8-10 gelas sehari sangat dianjurkan.
- b. Ibu menyusui memerlukan tambahan kalori sekitar 500 kkal/hari. Makan porsi kecil tapi sering, tinggi serat, kaya zat besi, kalsium, dan vitamin D direkomendasikan. Bidan berperan penting dalam edukasi nutrisi, merencanakan menu sehat, serta merujuk ke ahli gizi jika dibutuhkan.

### **5. Pencegahan dan Penanganan Komplikasi Nifas**

- a. Masa nifas rawan komplikasi seperti infeksi puerperal, trombosis vena dalam, dan depresi postpartum. Pencegahan infeksi meliputi teknik aseptik, kebersihan diri, perawatan luka benar, dan pemantauan ketat tanda infeksi. Penanganannya melibatkan antibiotik spektrum luas, istirahat cukup, dan rujukan jika kondisi memburuk.
- b. Trombosis dicegah melalui mobilisasi dini, penggunaan stoking kompresi pada ibu risiko tinggi, hidrasi baik, serta deteksi dini dengan pemeriksaan ekstremitas bawah. Terapi antikoagulan dan rujukan medis cepat sangat penting jika trombosis dicurigai.
- c. Depresi postpartum membutuhkan skrining rutin (Edinburgh Postnatal Depression Scale), dukungan psikososial keluarga dan tenaga kesehatan, serta rujukan ke layanan kesehatan mental untuk konseling atau terapi medis jika diperlukan.

## H. Glosarium

**Anemia:** Kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dalam darah yang menyebabkan kelelahan dan lemas, sering terjadi akibat perdarahan pascapersalinan.

**Antibiotik:** Obat untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri, digunakan dalam penanganan infeksi puerperal.

**Atonia uteri:** Kondisi ketika rahim tidak berkontraksi dengan baik setelah persalinan, menjadi penyebab utama perdarahan postpartum.

**ASI Eksklusif:** Pemberian hanya air susu ibu tanpa tambahan makanan atau minuman lain kepada bayi selama 6 bulan pertama kehidupan.

**Bonding:** Ikatan emosional antara ibu dan bayi yang terbentuk melalui kontak fisik dan interaksi, terutama saat menyusui.

**Cradle hold:** Salah satu posisi menyusui di mana bayi dipeluk menghadap ibu dengan kepala berada di lekukan siku ibu.

**Depresi postpartum:** Gangguan suasana hati yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kesedihan, kelelahan, dan gangguan ikatan dengan bayi.

**Episiotomi:** Sayatan yang dibuat di perineum untuk memperlebar jalan lahir selama persalinan, memerlukan perawatan luka pascapersalinan.

**Ergometrin:** Obat uterotonik yang digunakan untuk merangsang kontraksi rahim dan menghentikan perdarahan.

**Fundus uteri:** Bagian atas rahim yang dipalpasi untuk menilai involusi uterus pascapersalinan.

**Hiserektomi:** Tindakan operasi pengangkatan rahim, dilakukan bila perdarahan postpartum tidak dapat dikendalikan.

**IMD (Inisiasi Menyusui Dini):** Proses menyusui dalam satu jam pertama setelah lahir, mendorong kontak kulit-ke-kulit antara ibu dan bayi.

**Infeksi puerperal:** Infeksi yang terjadi pada alat reproduksi atau luka bekas persalinan selama masa nifas.

**Involusi uterus:** Proses kembalinya ukuran rahim ke keadaan sebelum hamil setelah persalinan.

**Kolostrum:** ASI pertama yang keluar setelah melahirkan, berwarna kekuningan dan kaya akan antibodi.

**Komplikasi nifas:** Gangguan kesehatan yang dapat terjadi selama masa nifas, seperti infeksi, perdarahan, trombosis, dan depresi.

**Konstipasi:** Kesulitan buang air besar, umum terjadi pada ibu nifas dan dapat dicegah dengan pola makan tinggi serat.

**Latch on:** Proses pelekatan mulut bayi ke payudara dengan benar saat menyusui agar efektif dan mencegah puting lecet.

**Lochia:** Cairan yang keluar dari vagina setelah persalinan, terdiri atas darah, lendir, dan jaringan uterus. Dibagi menjadi lochia rubra, serosa, dan alba.

**Mobilisasi:** Aktivitas gerak atau berjalan setelah persalinan untuk mencegah komplikasi seperti trombosis.

**Oksitosin:** Hormon atau obat yang diberikan untuk merangsang kontraksi rahim, terutama dalam pencegahan dan penanganan perdarahan postpartum.

**Pelekatan:** Proses ketika bayi menempel dengan benar ke payudara saat menyusui.

**Perdarahan nifas:** Keluaran darah dari rahim setelah persalinan; dapat bersifat normal atau abnormal.

**Perineum:** Area antara vagina dan anus, sering mengalami robekan atau dilakukan episiotomi saat persalinan.

**Prolaktin:** Hormon yang merangsang produksi ASI di kelenjar payudara.

**Prostaglandin:** Obat yang digunakan untuk merangsang kontraksi rahim dalam penanganan perdarahan postpartum.

**Rujukan:** Proses mengirim pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut jika penanganan di tempat pertama tidak memadai.

**Side-lying position:** Posisi menyusui sambil berbaring miring, cocok untuk ibu pascaoperasi sesar.

**Sterilisasi luka:** Proses membersihkan luka dengan antiseptik untuk mencegah infeksi.

**Syok:** Kondisi kritis akibat kehilangan darah berlebihan yang menyebabkan perfusi jaringan tidak adekuat dan bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani.

**Teknik aseptik:** Prosedur yang dilakukan dengan prinsip steril untuk mencegah infeksi, terutama pada perawatan luka.

**Tekanan darah:** Salah satu tanda vital yang dipantau selama masa nifas untuk mendeteksi perdarahan atau komplikasi lainnya.

**Trombosis:** Pembentukan bekuan darah di pembuluh darah, dapat terjadi pada masa nifas dan berisiko fatal bila tidak tertangani.

**Uterotonik:** Obat-obatan yang merangsang kontraksi otot rahim untuk menghentikan perdarahan.

## I. Daftar Pustaka

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams Obstetrics* (25th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Panduan Praktik Klinis Bagi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Kemenkes RI.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2019). *Maternity and Women's Health Care* (12th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & Ashwill, J. W. (2017). *Maternal-Child Nursing* (5th ed.). St. Louis, Missouri: Elsevier Saunders.
- NICE. (2017). *Intrapartum Care for Healthy Women and Babies: Clinical Guideline [CG190]*. National Institute for Health and Care Excellence. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/cg190>
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). *Maternity and Pediatric Nursing* (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- WHO. (2017). *WHO Recommendations on Maternal Health: Guidelines for Managing Complications in Pregnancy and Childbirth*. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2018). *WHO Recommendations: Uterotonics for the Prevention of Postpartum Haemorrhage*. Geneva: World Health Organization. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277276/9789241550420-eng.pdf>
- WHO. (2021). *WHO Recommendations on Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience*. Geneva: World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240035164>
- Zauderer, C., & Davis, W. (2019). Treating postpartum depression and anxiety. *American Journal of Nursing*, 119(5), 40-50. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000557910.94819.f5>
- Zhang, S., & Guo, Y. (2019). Prevention and management of postpartum hemorrhage. *American Family Physician*, 99(8), 485-491. Retrieved from <https://www.aafp.org/afp/2019/0415/p485.html>
- Zubor, P., Kajo, K., & Dokus, K. (2020). Surgical interventions for postpartum hemorrhage: A review. *International Journal of Women's Health*, 12, 237-248. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S234027>



# Bab 5

## Edukasi dan Konseling Pada Masa Nifas

Masa nifas adalah periode penting bagi ibu untuk beradaptasi secara fisik dan psikologis setelah persalinan, sekaligus mengawali peran sebagai ibu baru. Edukasi dan konseling yang efektif selama masa ini menjadi kunci utama dalam mendukung ibu agar dapat menjalani masa nifas dengan sehat dan optimal. Bidan sebagai tenaga kesehatan utama memiliki tanggung jawab memberikan informasi, membimbing, dan memotivasi ibu agar mampu mengelola perawatan diri, mengenali tanda bahaya, merencanakan keluarga, menjaga kesehatan mental, serta merawat bayi baru lahir dengan baik. Melalui edukasi yang tepat, risiko komplikasi dapat diminimalkan dan kualitas hidup ibu dan bayi dapat ditingkatkan.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memberikan edukasi dan konseling yang komprehensif pada ibu nifas, mencakup perawatan diri, deteksi dini tanda bahaya, perencanaan keluarga, dukungan psikososial, serta perawatan bayi baru lahir untuk mendukung pemulihan dan kesehatan optimal ibu dan bayi.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu melaksanakan edukasi dan konseling pada ibu nifas terkait perawatan diri, pengenalan tanda bahaya, kontrasepsi postpartum, dukungan psikososial, dan perawatan bayi baru lahir dengan pendekatan yang komunikatif dan berbasis bukti.

### Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

1. Menjelaskan pentingnya edukasi perawatan diri dan kebersihan personal pada masa nifas.
2. Mengidentifikasi tanda-tanda bahaya pada ibu nifas dan mengajarkan tindakan yang harus dilakukan.
3. Melakukan konseling perencanaan keluarga dan kontrasepsi postpartum secara efektif.
4. Memberikan dukungan psikososial dan strategi pencegahan depresi postpartum pada ibu nifas.
5. Mengedukasi ibu mengenai perawatan bayi baru lahir dan jadwal imunisasi dasar.

## A. Edukasi tentang Perawatan Diri dan Kebersihan Personal pada Ibu Nifas

Masa nifas adalah masa kritis bagi ibu setelah melahirkan yang memerlukan perhatian khusus, terutama terkait perawatan diri dan kebersihan personal. Kebersihan yang baik sangat penting untuk mencegah infeksi, mendukung proses penyembuhan luka, serta menjaga kesehatan ibu dan bayi. Edukasi yang diberikan secara jelas dan praktis akan memberdayakan ibu untuk melakukan perawatan diri dengan benar sehingga mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko komplikasi.

### 1. Kebersihan Genital dan Luka Jahitan

Setelah persalinan, area genital dan luka jahitan menjadi lokasi yang rentan terhadap infeksi jika tidak dirawat dengan benar. Oleh karena itu, ibu perlu diajarkan cara membersihkan area genital dengan teknik yang aman dan efektif.

- Gunakan air hangat dan sabun ringan untuk membersihkan area genital setiap kali selesai buang air kecil atau buang air besar.
- Hindari menggosok luka atau area sekitar luka jahitan karena dapat menyebabkan iritasi dan memperlambat penyembuhan. Sebaiknya, tepuk-tepuk lembut hingga kering dengan kain bersih.
- Selalu gunakan tisu atau kain bersih dari arah depan ke belakang untuk mencegah perpindahan bakteri dari anus ke vagina.
- Ganti pembalut secara rutin agar area tetap kering dan bersih.

### 2. Kebersihan Tangan

Tangan merupakan media utama penularan kuman, sehingga kebersihan tangan sangat penting untuk mencegah infeksi, baik pada ibu maupun bayi.

- Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah menyentuh area genital, luka jahitan, atau bayi.
- Jika tidak tersedia air dan sabun, dapat menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol minimal 60%.
- Ajarkan keluarga dan orang yang merawat ibu untuk juga mempraktikkan kebersihan tangan agar risiko penularan menurun.

### 3. Perawatan Payudara

Payudara dan puting adalah area yang perlu perawatan khusus terutama selama menyusui untuk mencegah infeksi dan komplikasi.

- Bersihkan payudara dan puting dengan air hangat tanpa sabun setiap hari, terutama sebelum menyusui.
- Hindari penggunaan sabun, lotion, atau produk yang dapat menyebabkan iritasi pada puting.
- Setelah menyusui, biarkan puting kering secara alami sebelum menutup dengan pakaian.

- d. Perhatikan tanda-tanda mastitis atau infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, atau nyeri yang berat dan segera konsultasikan ke tenaga kesehatan bila muncul gejala tersebut.

#### **4. Istirahat dan Nutrisi**

Pemulihan ibu nifas sangat dipengaruhi oleh kualitas istirahat dan asupan nutrisi yang memadai.

- a. Anjurkan ibu untuk mendapatkan istirahat yang cukup, karena proses penyembuhan dan produksi ASI membutuhkan energi dan waktu pemulihan.
- b. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang mengandung protein, vitamin, mineral, serta cukup kalori sesuai kebutuhan.
- c. Hidrasi yang cukup juga sangat penting untuk menjaga produksi ASI dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.
- d. Hindari stres berlebih dan berikan dukungan emosional agar ibu dapat beristirahat dengan baik.

## **B. Tanda-tanda Bahaya yang Harus Diwaspadai pada Ibu Nifas**

Masa nifas merupakan periode rentan di mana ibu mengalami proses pemulihan setelah persalinan. Meski proses ini biasanya berjalan lancar, terdapat risiko munculnya komplikasi serius yang dapat membahayakan ibu dan bayi jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu dan keluarga untuk mengenali tanda-tanda bahaya yang memerlukan penanganan medis segera. Edukasi tentang tanda-tanda tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan dan mempercepat akses pelayanan kesehatan.

### **1. Perdarahan Berlebih**

#### **a. Definisi**

Perdarahan berlebih pada masa nifas adalah keluarnya darah dalam jumlah banyak yang melebihi kapasitas tubuh untuk mengontrolnya, berpotensi menyebabkan anemia hingga syok.

#### **b. Tanda-tanda Perdarahan Berlebih**

- 1) Keluarnya darah dengan volume besar, seperti mengganti lebih dari satu pembalut per jam selama dua jam berturut-turut.
- 2) Terasa darah deras atau mengalir terus menerus dari vagina.
- 3) Muncul gumpalan darah besar yang tidak seperti darah menstruasi biasa.
- 4) Perdarahan yang tidak berhenti atau bertambah banyak setelah awalnya berkurang.

#### **c. Tindakan yang Harus Dilakukan**

- 1) Segera laporkan kepada tenaga kesehatan jika tanda-tanda ini muncul.

- 2) Jangan menunda untuk mendapatkan pertolongan medis guna mencegah komplikasi lebih lanjut.

## **2. Demam**

### **a. Definisi**

Demam adalah peningkatan suhu tubuh di atas batas normal, yang pada ibu nifas dapat menjadi tanda infeksi serius.

### **b. Tanda-tanda Demam**

- 1) Suhu tubuh mencapai 38°C atau lebih.
- 2) Demam berlangsung selama lebih dari dua hari atau disertai gejala lain seperti menggigil, berkeringat, dan lemah.

### **c. Penyebab Umum Demam pada Masa Nifas**

- 1) Infeksi pada luka persalinan, rahim (endometritis), saluran kemih, atau payudara (mastitis).
- 2) Infeksi sistemik yang memerlukan evaluasi dan terapi cepat.

### **d. Tindakan yang Harus Dilakukan**

- 1) Segera konsultasikan ke tenaga kesehatan jika demam menetap atau meningkat.
- 2) Minum cairan cukup dan istirahat sambil menunggu penanganan medis.

## **3. Nyeri Hebat**

### **a. Definisi**

Nyeri hebat yang tidak kunjung reda atau semakin parah pada masa nifas merupakan tanda bahaya yang harus diwaspadai.

### **b. Lokasi dan Karakteristik Nyeri**

- 1) Nyeri pada area luka jahitan atau perineum yang bertambah intens.
- 2) Nyeri perut bagian bawah yang tajam atau terus menerus.
- 3) Nyeri pada payudara yang disertai pembengkakan dan kemerahan, bisa mengindikasikan mastitis.

### **c. Tindakan yang Harus Dilakukan**

- 1) Jika nyeri tidak membaik dengan perawatan biasa, segera hubungi tenaga kesehatan.
- 2) Jangan mengabaikan nyeri yang berhubungan dengan tanda-tanda lain seperti demam atau perdarahan.

## **C. Perencanaan Keluarga dan Konseling Kontrasepsi Postpartum**

Perencanaan keluarga setelah melahirkan adalah aspek krusial dalam asuhan kesehatan ibu dan anak. Penundaan kehamilan berikutnya selama minimal dua tahun sangat dianjurkan untuk memberikan waktu optimal bagi ibu memulihkan kesehatan fisik dan mental serta mendukung tumbuh kembang anak yang baru lahir. Konseling kontrasepsi

postpartum yang efektif membantu ibu dan pasangan memilih metode kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi kesehatan, dan preferensi mereka. Melalui pendekatan yang komunikatif dan berbasis bukti, bidan dapat memberdayakan keluarga dalam mengambil keputusan terbaik terkait kesehatan reproduksi mereka.

### 1. Pentingnya Perencanaan Keluarga

#### a. Manfaat kesehatan:

Menunda kehamilan berikutnya minimal dua tahun setelah persalinan mengurangi risiko komplikasi seperti preeklamsia, persalinan prematur, dan kematian neonatal.

#### b. Pemulihan ibu:

Memberi waktu bagi ibu untuk pulih sepenuhnya secara fisik dan mental sebelum kehamilan berikutnya.

#### c. Perhatian terhadap anak:

Jarak kelahiran yang cukup memungkinkan perhatian, nutrisi, dan stimulasi yang optimal bagi anak.

#### d. Kesejahteraan keluarga:

Perencanaan keluarga yang baik meningkatkan stabilitas ekonomi dan psikososial keluarga.

### 2. Metode Kontrasepsi yang Tersedia Postpartum

#### a. Pilihan metode kontrasepsi yang aman dan efektif pada masa postpartum meliputi:

##### 1) Pil KB Kombinasi dan Pil Progestin

Pil progestin sering dianjurkan bagi ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI.

##### 2) Intrauterine Device (IUD)

Bisa dipasang segera setelah persalinan (IUD postpartum), efektif dan tahan lama.

##### 3) Suntik KB

Suntik progesteron adalah metode yang aman dan praktis untuk ibu menyusui.

##### 4) Metode Alami

Seperti metode amenorea laktasi (MAL) yang efektif jika memenuhi kriteria tertentu, serta metode kalender.

##### 5) Implan Kontrasepsi

Alat kontrasepsi hormonal yang ditanamkan di bawah kulit, memberikan perlindungan jangka panjang.

##### 6) Sterilisasi

Pilihan permanen untuk pasangan yang telah memenuhi keinginan memiliki anak.

### 3. Konseling yang Komunikatif dan Berpusat pada Pasien

#### a. Pendekatan personal:

Diskusikan secara terbuka harapan, kebutuhan, dan kekhawatiran ibu serta pasangannya terkait kontrasepsi.

#### b. Informasi lengkap:

- Jelaskan kelebihan, kekurangan, efek samping, dan cara penggunaan setiap metode.
- c. Dukungan pengambilan keputusan:  
Berikan ruang bagi ibu dan pasangan untuk bertanya dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat.
  - d. Tindak lanjut:  
Rencanakan kunjungan kontrol untuk evaluasi metode kontrasepsi dan dukungan lanjutan.

## **D. Dukungan Psikososial dan Pencegahan Depresi Postpartum**

Masa nifas tidak hanya menuntut pemulihan fisik, tetapi juga menimbulkan tantangan psikososial yang signifikan bagi ibu. Stres berlebihan dan depresi postpartum adalah gangguan kesehatan mental yang sering terjadi dan dapat mengganggu fungsi ibu dalam merawat diri dan bayi. Dukungan psikososial yang memadai dari keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sangat penting untuk mencegah dan mengatasi depresi postpartum. Edukasi kepada ibu dan keluarga tentang tanda-tanda stres dan depresi, pemberian dukungan emosional, serta akses ke sumber daya profesional merupakan pilar utama dalam asuhan kebidanan yang holistik.

### **1. Mengenali Gejala Stres dan Depresi Postpartum**

- a. Perubahan mood: Ibu mengalami perasaan sedih, cemas, mudah marah, atau frustrasi yang berkepanjangan.
- b. Kehilangan minat: Berkurangnya minat atau kesenangan pada aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan.
- c. Gangguan tidur: Sulit tidur atau tidur berlebihan tanpa alasan medis.
- d. Perasaan lelah dan tidak berdaya: Energi rendah yang mengganggu aktivitas rutin.
- e. Kesulitan konsentrasi dan pengambilan keputusan: Ibu merasa bingung atau lamban dalam berpikir.
- f. Perasaan bersalah atau tidak berharga: Merasa gagal sebagai ibu atau kehilangan harga diri.
- g. Pemikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi: Ini adalah tanda serius yang memerlukan intervensi segera.

### **2. Memberikan Dukungan Emosional**

- a. Motivasi untuk berbagi perasaan: Dorong ibu untuk bercerita tentang perasaannya dan tidak menyimpan stres sendirian.
- b. Membangun komunikasi terbuka: Fasilitasi dialog yang jujur antara ibu dan anggota keluarga atau tenaga kesehatan.
- c. Keterlibatan keluarga: Ajak keluarga untuk memberikan dukungan penuh, baik secara fisik maupun emosional.

- d. Mendorong relaksasi dan aktivitas positif: Berikan rekomendasi teknik relaksasi, olahraga ringan, atau kegiatan sosial yang membantu mengurangi stres.

### 3. **Menghubungkan dengan Sumber Daya Profesional**

- a. Rujukan ke konselor atau psikolog: Bila gejala depresi postpartum berat atau tidak membaik dengan dukungan dasar, rujuk ke tenaga kesehatan mental profesional untuk terapi lanjutan.
- b. Pemantauan lanjutan: Tenaga kesehatan harus melakukan follow-up secara rutin untuk memantau perkembangan kondisi ibu.
- c. Kelompok dukungan: Ajak ibu bergabung dengan kelompok dukungan ibu nifas untuk berbagi pengalaman dan memperluas jejaring sosial.

## **E. Edukasi tentang Perawatan Bayi Baru Lahir dan Imunisasi**

Perawatan bayi baru lahir merupakan tahap awal yang sangat penting dalam kehidupan anak. Asuhan yang tepat tidak hanya menjaga kesehatan bayi tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Air Susu Ibu (ASI) sebagai makanan terbaik harus diberikan secara optimal. Selain itu, imunisasi dasar menjadi salah satu langkah pencegahan utama terhadap penyakit menular yang dapat mengancam jiwa bayi. Edukasi yang jelas dan tepat sasaran kepada orang tua, terutama ibu, sangat diperlukan agar mereka mampu menjalankan perawatan dan menjaga kesehatan bayi secara mandiri.

### 1. **Perawatan Bayi Baru Lahir**

- a. Cara Memandikan Bayi
  - 1) Gunakan air hangat dengan suhu sekitar 37°C agar bayi merasa nyaman.
  - 2) Basahi seluruh tubuh bayi dengan lembut menggunakan kain lembut, mulai dari wajah hingga kaki.
  - 3) Bersihkan area lipatan tubuh dan alat kelamin dengan perlahan dan hati-hati.
  - 4) Gunakan sabun bayi yang lembut dan tidak mengiritasi kulit.
  - 5) Keringkan tubuh bayi dengan handuk lembut secara menyeluruh, terutama di lipatan kulit.
  - 6) Hindari memandikan bayi terlalu sering; cukup 2-3 kali dalam seminggu kecuali jika kotor.
- b. Cara Menggendong Bayi
  - 1) Dukung kepala dan leher bayi dengan tangan saat menggendong untuk mencegah cedera.
  - 2) Gendong bayi dengan posisi nyaman dan aman, baik dengan posisi tegak atau rebah sesuai kebutuhan.
  - 3) Gunakan kain gendong atau alat bantu sesuai kenyamanan ibu dan bayi.
  - 4) Pastikan bayi merasa hangat dan aman saat digendong.

- c. Menjaga Kebersihan Bayi
  - 1) Ganti popok secara rutin untuk mencegah ruam dan infeksi.
  - 2) Bersihkan area genital bayi dengan air hangat dan kain lembut setiap kali mengganti popok.
  - 3) Jaga kebersihan tali pusar hingga lepas dan sembuh sempurna dengan tetap kering dan bersih.
  - 4) Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah penularan kuman.

## 2. Pentingnya ASI

- a. ASI mengandung nutrisi lengkap dan antibodi penting yang melindungi bayi dari infeksi.
- b. Memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat dianjurkan oleh WHO untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi.
- c. Teknik menyusui yang benar, seperti posisi dan pelekatan yang tepat, membantu mencegah puting lecet dan memastikan bayi mendapatkan ASI yang cukup.
- d. Dukungan ibu dan keluarga sangat berperan dalam keberhasilan menyusui.

## 3. Imunisasi Dasar

- a. Jadwal Imunisasi Lengkap Sesuai Program Nasional
  - 1) Hepatitis B: dosis pertama diberikan dalam 24 jam setelah lahir, dilanjutkan dosis berikutnya sesuai jadwal.
  - 2) BCG (Bacillus Calmette-Guérin): untuk pencegahan tuberkulosis, biasanya diberikan pada bayi usia 0–2 bulan.
  - 3) DPT (Difteri, Pertusis, Tetanus): vaksinasi lengkap diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan.
  - 4) Polio: diberikan bersamaan dengan vaksin DPT dan booster pada usia berikutnya.
- b. Pentingnya Imunisasi
  - 1) Melindungi bayi dari penyakit menular serius yang berpotensi mengancam jiwa.
  - 2) Mencegah penyebaran penyakit di masyarakat.
  - 3) Meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga perkembangan dan tumbuh kembang berjalan optimal.
- c. Edukasi Orang Tua
  - 1) Berikan informasi tentang jadwal imunisasi yang harus dipatuhi.
  - 2) Jelaskan manfaat dan keamanan vaksinasi.
  - 3) Tanggapi kekhawatiran atau mitos yang sering muncul seputar imunisasi.
  - 4) Dorong orang tua untuk mencatat dan mengikuti jadwal imunisasi secara tepat waktu.



## F. Latihan Soal

### Tugas

---

#### Tugas 1

##### Kasus:

Ibu usia 27 tahun, hari ke-3 masa nifas, tampak bingung dan belum tahu cara merawat luka perineumnya. Ia mengaku hanya membersihkannya dengan tisu basah dan tidak rutin mengganti pembalut.

Pertanyaan:

Jelaskan isi edukasi yang tepat tentang perawatan diri dan kebersihan personal pada ibu nifas. Apa risiko yang dapat terjadi bila perawatan tidak dilakukan dengan benar?

#### Tugas 2

##### Kasus:

Seorang ibu hari ke-4 postpartum datang ke klinik dengan keluhan demam, menggigil, dan keluarnya darah berbau dari jalan lahir. Ia belum tahu bahwa kondisi tersebut berbahaya dan menunggu sampai kondisinya memburuk.

Pertanyaan:

Identifikasi tanda bahaya pada masa nifas yang dialami ibu. Susunlah rencana edukasi kepada ibu dan keluarganya tentang pentingnya deteksi dini dan kapan harus segera ke fasilitas kesehatan.

#### Tugas 3

##### Kasus:

Ibu usia 33 tahun mengungkapkan ketakutan untuk kembali hamil dalam waktu dekat. Namun, ia belum mengetahui pilihan kontrasepsi yang bisa digunakan saat menyusui.

Pertanyaan:

Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan konseling kontrasepsi postpartum yang efektif pada ibu menyusui. Sertakan penjelasan pilihan kontrasepsi yang aman dan cara menyampaikan informasi dengan pendekatan komunikatif.

#### Tugas 4

##### Kasus:

Seorang ibu hari ke-7 nifas tampak menangis saat pemeriksaan, mengaku merasa sedih, mudah marah, dan tidak percaya diri dalam merawat bayinya.

Pertanyaan:

Analisis kondisi psikologis ibu tersebut. Jelaskan dukungan psikososial yang dapat diberikan oleh bidan dan bagaimana strategi edukatif untuk mencegah depresi postpartum.

## Tugas 5

### Esai:

Jelaskan secara komprehensif langkah-langkah edukasi yang harus diberikan kepada ibu nifas mengenai perawatan bayi baru lahir di rumah, termasuk tanda bahaya neonatal dan jadwal imunisasi dasar. Bagaimana peran keluarga dalam mendukung keberhasilan asuhan ini?

### Pilihan Ganda

---

1. Ibu Ani (29 tahun) baru saja melahirkan anak pertama secara spontan dengan luka jahitan di area perineum. Bidan memberikan edukasi perawatan diri kepada Ibu Ani. Manakah di bawah ini teknik pembersihan area genital yang paling tepat?
  - A. Tepuk-tepuk lembut area luka hingga kering dengan kain bersih.
  - B. Gunakan air dingin dan sabun antiseptik yang kuat.
  - C. Gosok luka secara intens agar cepat kering.
  - D. Bersihkan dari arah belakang ke depan agar lebih mudah.
  - E. Ganti pembalut hanya saat penuh.
2. Ibu Lia (25 tahun) datang ke klinik nifas dengan keluhan suhu tubuh 38,5°C sejak 2 hari lalu, disertai menggigil dan lemas. Bidan mencurigai adanya infeksi nifas. Apakah kemungkinan infeksi yang dialami oleh Ibu Lia?
  - A. Infeksi saluran cerna
  - B. Mastitis
  - C. Diabetes gestasional
  - D. Infeksi saluran kemih
  - E. Endometritis
3. Pasangan muda, Rani (24 tahun) dan Andi (27 tahun), sedang berkonsultasi tentang pilihan kontrasepsi pasca kelahiran bayi pertama mereka. Rani menyusui secara eksklusif dan mencari metode yang tidak mengganggu produksi ASI. Pilihan kontrasepsi yang paling tepat adalah:
  - A. Pil kombinasi
  - B. Implan hormonal
  - C. Suntik kombinasi
  - D. Pil progestin
  - E. Metode kalender

4. Ibu Sari (31 tahun), tiga minggu setelah melahirkan, tampak murung, mudah marah, kehilangan minat beraktivitas, serta merasa bersalah tidak dapat merawat bayinya dengan baik. Tindakan awal yang tepat dilakukan bidan dalam memberikan dukungan psikososial adalah:
- A. Langsung memberikan rujukan ke psikiater tanpa diskusi lanjutan
  - B. Menyarankan istirahat total tanpa interaksi dengan keluarga
  - C. Memotivasi ibu berbicara terbuka tentang perasaannya
  - D. Mengabaikan gejala tersebut karena dianggap normal
  - E. Menganjurkan aktivitas fisik berat untuk mengalihkan pikiran
5. Ibu Dina (28 tahun), baru melahirkan bayi pertamanya. Ia bertanya tentang imunisasi dasar bagi bayinya yang baru lahir. Imunisasi apa yang harus diberikan kepada bayinya dalam waktu 24 jam pertama setelah lahir?
- A. Imunisasi Polio
  - B. Imunisasi DPT
  - C. Imunisasi Hepatitis B
  - D. Imunisasi Campak
  - E. Imunisasi BCG

### Kunci Jawaban

---

1. Jawaban: A  
Pembahasan: Teknik tepat untuk membersihkan area genital setelah persalinan adalah menggunakan air hangat dan sabun ringan, membersihkan dari arah depan ke belakang, serta menepuk-nepuk lembut hingga kering menggunakan kain bersih untuk menghindari iritasi.
2. Jawaban: E  
Pembahasan: Demam tinggi dan menggigil pada masa nifas seringkali menandakan infeksi, salah satunya endometritis, yaitu infeksi pada rahim yang kerap terjadi pada masa nifas dan memerlukan penanganan segera.
3. Jawaban: D  
Pembahasan: Pil progestin adalah metode kontrasepsi hormonal yang aman untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI dibandingkan pil kombinasi yang mengandung estrogen.
4. Jawaban: C  
Pembahasan: Pendekatan pertama dalam dukungan psikososial postpartum adalah dengan memberi kesempatan kepada ibu untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan dan masalah yang dihadapi sebelum intervensi lebih lanjut.

5. Jawaban: C

Pembahasan: Imunisasi Hepatitis B adalah imunisasi pertama yang wajib diberikan dalam waktu 24 jam setelah kelahiran untuk memberikan perlindungan dini terhadap virus Hepatitis B.

## G. Rangkuman Materi

### 1. Edukasi Perawatan Diri dan Kebersihan Personal pada Ibu Nifas

Masa nifas memerlukan perhatian khusus terutama dalam menjaga kebersihan untuk mencegah infeksi dan mempercepat pemulihan ibu. Edukasi kebersihan genital mencakup penggunaan air hangat dan sabun ringan, mengeringkan area luka secara lembut, membersihkan dari depan ke belakang, serta rutin mengganti pembalut. Kebersihan tangan sangat penting untuk mencegah penularan infeksi pada ibu dan bayi, dengan mencuci tangan sebelum dan setelah kontak dengan area genital atau bayi. Payudara perlu dirawat tanpa sabun atau lotion untuk mencegah iritasi, dikeringkan secara alami setelah menyusui, dan selalu memantau tanda-tanda infeksi seperti mastitis. Istirahat cukup dan nutrisi bergizi seimbang sangat vital bagi pemulihan ibu nifas serta produksi ASI.

### 2. Tanda-tanda Bahaya pada Masa Nifas

Perdarahan berlebih yang tidak normal pada masa nifas harus segera dilaporkan ke tenaga kesehatan. Gejalanya antara lain ganti pembalut lebih dari satu kali per jam selama dua jam berturut-turut, darah mengalir deras terus-menerus, atau muncul gumpalan darah besar. Demam tinggi di atas 38°C selama lebih dari dua hari, disertai menggigil, juga merupakan tanda infeksi serius, seperti endometritis atau mastitis. Nyeri hebat yang terus memburuk atau tidak reda, terutama di area luka jahitan, perut bawah, atau payudara, merupakan indikasi komplikasi dan harus segera mendapat perhatian medis.

### 3. Perencanaan Keluarga dan Konseling Kontrasepsi Postpartum

Perencanaan keluarga sangat dianjurkan pascapersalinan untuk memberikan waktu pemulihan optimal bagi ibu serta mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Metode kontrasepsi postpartum yang aman mencakup pil progestin untuk ibu menyusui, IUD postpartum, suntik progesteron, metode amenorea laktasi, implan hormonal, dan sterilisasi bagi pasangan yang memutuskan cukup memiliki anak. Konseling kontrasepsi harus bersifat komunikatif dan informatif, mempertimbangkan kebutuhan, kondisi kesehatan, dan preferensi pasien serta pasangan.

### 4. Dukungan Psikososial dan Pencegahan Depresi Postpartum

Dukungan psikososial selama masa nifas penting untuk mencegah depresi postpartum. Gejala yang perlu dikenali meliputi perubahan mood drastis, kehilangan minat pada aktivitas harian, gangguan tidur, kelelahan berlebihan, kesulitan konsentrasi, perasaan

bersalah, serta pemikiran untuk menyakiti diri atau bayi. Dukungan emosional dapat diberikan melalui komunikasi terbuka, keterlibatan keluarga, kegiatan positif, serta teknik relaksasi. Jika kondisi memburuk atau tidak membaik, rujukan ke profesional kesehatan mental serta kelompok dukungan dianjurkan.

#### 5. **Edukasi Perawatan Bayi Baru Lahir dan Imunisasi**

Perawatan bayi baru lahir melibatkan teknik mandi dengan air hangat, membersihkan tubuh secara lembut, mengganti popok rutin, menjaga kebersihan tali pusar, dan memastikan kebersihan tangan sebelum memegang bayi. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan kekebalan tubuh bayi. Imunisasi dasar seperti Hepatitis B (diberikan dalam 24 jam pertama), BCG, DPT, dan Polio penting dilakukan sesuai jadwal nasional untuk melindungi bayi dari penyakit berbahaya dan meningkatkan kekebalan tubuh secara optimal. Edukasi kepada orang tua terkait manfaat dan pentingnya imunisasi harus diberikan dengan jelas untuk menghindari mitos dan kesalahpahaman.

## **H. Glosarium**

**ASI Eksklusif:** Pemberian Air Susu Ibu (ASI) saja, tanpa tambahan cairan atau makanan lain selama enam bulan pertama kehidupan bayi.

**Bayi Baru Lahir:** Bayi dalam periode usia 0-28 hari setelah kelahiran, memerlukan perhatian khusus terkait kebersihan, nutrisi, dan imunisasi.

**BCG (Bacillus Calmette-Guérin):** Vaksin untuk melindungi bayi dari penyakit tuberkulosis (TB), biasanya diberikan segera setelah kelahiran atau dalam rentang usia 0–2 bulan.

**Depresi Postpartum:** Kondisi psikologis berupa perasaan sedih, cemas, kelelahan ekstrim, serta kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari yang berlangsung setelah melahirkan dan memerlukan intervensi medis atau psikologis.

**Difteri, Pertusis, Tetanus (DPT):** Kombinasi vaksin yang diberikan pada bayi untuk mencegah penyakit Difteri, Pertusis (batuk rejan), dan Tetanus, diberikan dalam beberapa dosis sesuai jadwal nasional.

**Endometritis:** Infeksi yang terjadi pada lapisan rahim, biasanya ditandai dengan demam tinggi, nyeri perut, dan keluarnya cairan abnormal, sering terjadi selama masa nifas.

**Hand Sanitizer:** Cairan antiseptik berbahan dasar alkohol (minimal 60%) yang digunakan untuk membersihkan tangan dari kuman saat tidak tersedia sabun dan air.

**IUD (Intrauterine Device):** Alat kontrasepsi berbentuk kecil yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan, efektif digunakan segera setelah persalinan (postpartum).

**Kontrasepsi Postpartum:** Metode pencegahan kehamilan yang digunakan setelah melahirkan, meliputi pil progestin, suntik KB, IUD, implan, metode alami (amenorea laktasi), dan sterilisasi.

**Masa Nifas:** Masa pemulihan ibu setelah melahirkan yang berlangsung hingga 6 minggu atau 42 hari pasca persalinan, ditandai dengan proses penyembuhan luka persalinan dan perubahan fisiologis lainnya.

**Mastitis:** Infeksi pada payudara yang umumnya terjadi selama masa menyusui, ditandai dengan payudara merah, bengkak, panas, dan nyeri, serta dapat disertai demam.

**Metode Amenorea Laktasi (MAL):** Metode kontrasepsi alami yang mengandalkan menyusui secara eksklusif untuk menunda ovulasi dan kehamilan berikutnya.

**Nutrisi Seimbang:** Konsumsi makanan dengan kandungan protein, vitamin, mineral, karbohidrat, dan lemak dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan tubuh ibu nifas, penting untuk pemulihan dan produksi ASI.

**Perdarahan Berlebih (Postpartum Hemorrhage):** Kehilangan darah dalam jumlah besar setelah melahirkan yang bisa menyebabkan anemia atau syok, ditandai dengan penggunaan pembalut lebih dari satu per jam selama dua jam berturut-turut.

**Perineum:** Area antara vagina dan anus, seringkali mengalami luka atau robekan saat persalinan dan memerlukan perawatan kebersihan khusus untuk mencegah infeksi.

**Pil Progestin:** Kontrasepsi oral yang hanya mengandung hormon progestin, direkomendasikan untuk ibu menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI.

**Popok:** Bahan yang digunakan untuk menampung kotoran bayi, yang harus rutin diganti untuk menjaga kebersihan dan mencegah iritasi kulit.

**Sterilisasi:** Metode kontrasepsi permanen berupa prosedur bedah untuk menghentikan kemampuan reproduksi, baik pada pria maupun wanita, yang dipilih jika pasangan sudah memutuskan tidak akan memiliki anak lagi.

**Syok:** Kondisi medis serius akibat kehilangan darah atau cairan tubuh secara ekstrem, menyebabkan tekanan darah turun drastis dan membutuhkan penanganan medis segera.

**Vaksinasi (Imunisasi):** Proses pemberian vaksin kepada bayi dan anak-anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi, seperti Hepatitis B, DPT, Polio, dan BCG.

## I. Daftar Pustaka

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2018). *Williams obstetrics* (25th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Panduan praktik klinis bagi bidan di fasilitas pelayanan kesehatan primer*. Jakarta: Kemenkes RI.

- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., Nelson, K. A., & Ashwill, J. W. (2017). *Maternal-child nursing* (5th ed.). Missouri: Elsevier Saunders.
- NICE (National Institute for Health and Care Excellence). (2017). *Intrapartum care for healthy women and babies: Clinical guideline [CG190]*. London: NICE. Diakses dari <https://www.nice.org.uk/guidance/cg190>
- obak, I. M., Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2021). *Keperawatan maternitas dan kebidanan* (Edisi 6). Jakarta: Elsevier.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). *Maternity and pediatric nursing* (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
- World Health Organization (WHO). (2017). *WHO recommendations on maternal health: Guidelines for managing complications in pregnancy and childbirth*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2018). *WHO recommendations: Uterotonics for the prevention of postpartum haemorrhage*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization (WHO). (2021). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO Press.
- Zauderer, C., & Davis, W. (2019). Treating postpartum depression and anxiety. *American Journal of Nursing*, 119(5), 40-50. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000557910.94819.f5>
- Zhang, S., & Guo, Y. (2019). Prevention and management of postpartum hemorrhage. *American Family Physician*, 99(8), 485-491. Diakses dari <https://www.aafp.org/afp/2019/0415/p485.html>
- Zubor, P., Kajo, K., & Dokus, K. (2020). Surgical interventions for postpartum hemorrhage: A review. *International Journal of Women's Health*, 12, 237-248. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S234027>

# Bab 6

## Komplikasi Masa Nifas dan Manajemen Keperawatan

Masa nifas merupakan periode transisi yang sangat penting setelah proses persalinan, dimulai sejak kelahiran plasenta dan berlangsung hingga enam minggu berikutnya. Pada masa ini, tubuh ibu mengalami berbagai perubahan fisiologis dan psikologis untuk kembali ke kondisi sebelum kehamilan. Masa nifas sering disebut sebagai masa pemulihan, di mana kesehatan ibu sangat rentan terhadap berbagai komplikasi serius yang dapat mengancam keselamatan hidup dan kesejahteraan ibu dan bayi. Komplikasi yang umum terjadi meliputi perdarahan postpartum (hemoragi postpartum), infeksi postpartum yang meliputi endometritis, mastitis, dan infeksi luka operasi, serta gangguan mental seperti depresi postpartum. Penanganan yang tepat, cepat, dan komprehensif terhadap komplikasi ini menjadi tanggung jawab utama bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang karakteristik komplikasi, tanda dan gejala, serta manajemen keperawatan yang efektif sangat diperlukan dalam praktik kebidanan masa kini guna meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup ibu serta bayi.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan materi ini, lulusan diharapkan memiliki kompetensi untuk menerapkan asuhan kebidanan pada masa nifas secara aman, efektif, dan berbasis bukti dengan memperhatikan aspek komplikasi yang mungkin timbul. Lulusan mampu mengidentifikasi risiko dan komplikasi masa nifas serta memberikan manajemen keperawatan sesuai standar profesi. Selain itu, lulusan harus mampu bersikap profesional dan empatik dalam mendukung kesehatan fisik dan mental ibu, serta memberikan edukasi dan dukungan yang komprehensif bagi ibu dan keluarga selama masa pemulihan postpartum.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan secara komprehensif mengenai komplikasi yang umum terjadi pada masa nifas, termasuk hemoragi postpartum, infeksi postpartum, dan gangguan mental postpartum. Selanjutnya, mahasiswa mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi intervensi keperawatan yang tepat untuk mencegah dan mengelola komplikasi tersebut. Mahasiswa juga harus dapat melakukan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga untuk meningkatkan pencegahan komplikasi dan mendukung proses pemulihan secara holistik.



**Sub-CPMK**

1. Mahasiswa dapat menjelaskan patofisiologi dan etiologi hemoragi postpartum serta mengidentifikasi tanda dan gejala klinis yang muncul.
2. Mahasiswa mampu menguraikan tindakan emergensi dan manajemen keperawatan yang tepat pada kasus hemoragi postpartum.
3. Mahasiswa dapat mengenali jenis-jenis infeksi postpartum, termasuk endometritis, mastitis, dan infeksi luka operasi serta melakukan asuhan keperawatan sesuai kebutuhan.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor risiko, tanda-tanda, dan intervensi keperawatan untuk gangguan mental postpartum, khususnya depresi postpartum.
5. Mahasiswa dapat melakukan edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pencegahan komplikasi masa nifas serta memberikan dukungan psikososial yang sesuai.

## A. Hemoragi Postpartum (PPH) dan Tindakan Emergensi

Hemoragi postpartum (PPH) adalah kondisi medis yang ditandai dengan perdarahan berlebihan setelah persalinan, dan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di masa nifas secara global, terutama dalam 24 jam pertama setelah persalinan (PPH primer). PPH sangat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Definisi PPH menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah kehilangan darah  $\geq 500$  ml setelah persalinan pervaginam normal dan  $\geq 1000$  ml setelah persalinan melalui operasi sesar. Namun dalam praktik klinis, perdarahan lebih dari 1000 ml dianggap kritis dan memerlukan intervensi segera. PPH terjadi karena kegagalan mekanisme fisiologis tubuh untuk menghentikan perdarahan pascapersalinan, sehingga darah terus keluar secara masif dari tempat dimana plasenta melekat pada rahim.

### 1. Etiologi dan Penyebab Hemoragi Postpartum

Penyebab utama PPH dikenal dengan konsep 4T yang menjelaskan empat faktor utama yang dapat menyebabkan perdarahan berlebihan:

#### a. Tone (Atonia Uteri)

Ini adalah penyebab paling umum PPH. Atonia uteri adalah kondisi ketika otot rahim gagal berkontraksi dengan baik setelah plasenta lahir, sehingga pembuluh darah yang terbuka di tempat plasenta melekat tidak dapat tertutup dan perdarahan terus terjadi. Faktor risiko meliputi persalinan yang lama, kehamilan kembar, penggunaan obat penghambat kontraksi selama persalinan, dan riwayat PPH sebelumnya.

#### b. Tissue (Retensi Plasenta atau Jaringan)

Sisa jaringan plasenta atau membran yang tertinggal di dalam rahim menyebabkan rahim tidak bisa berkontraksi sempurna, sehingga perdarahan terjadi. Retensi ini juga dapat menyebabkan infeksi jika tidak segera diatasi.

#### c. Trauma (Luka Jalan Lahir)

Trauma berupa robekan jalan lahir, episiotomi yang meluas, luka vagina, cervix, atau ruptur uterus dapat menjadi sumber perdarahan yang signifikan.

#### d. Thrombin (Gangguan Koagulasi)

Gangguan pembekuan darah, baik karena kondisi sebelumnya atau akibat perdarahan masif itu sendiri, dapat menyebabkan perdarahan berlanjut yang sulit dihentikan.

### 2. Tanda dan Gejala Hemoragi Postpartum

**a. Perdarahan pervaginam yang berlebihan:** Volume darah yang keluar melebihi normal dan tidak berkurang dalam waktu yang wajar setelah plasenta lahir.

**b. Fundus uteri lunak dan tidak berkontraksi:** Palpasi abdomen menunjukkan rahim tidak mengencang atau mengeras, menandakan atonia uteri.

- c. **Syok hipovolemik:** Tanda-tanda akibat kehilangan darah besar, seperti kulit pucat, lemas, pusing, takikardia (denyut jantung cepat), tekanan darah menurun, pernapasan cepat, dan dalam kasus berat penurunan kesadaran bahkan kolaps.

### **3. Tindakan Emergensi pada Hemoragi Postpartum**

Penanganan hemoragi postpartum harus segera dilakukan secara sistematis dan bertahap dengan fokus menghentikan perdarahan dan mencegah komplikasi fatal.

#### **a. Kompresi Bimanual Uterus**

Segera lakukan kompresi manual dengan tangan di perut dan tangan lain masuk ke dalam vagina untuk memijat rahim agar berkontraksi dan menghentikan perdarahan akibat atonia.

#### **b. Pemberian Uterotonika**

Obat yang merangsang kontraksi rahim seperti oksitosin (infus atau injeksi), misoprostol (oral atau rektal), dan ergometrin (injeksi) harus diberikan secepatnya untuk memperkuat kontraksi rahim.

#### **c. Infus Cairan Kristaloid Cepat**

Pemberian cairan intravena bertujuan mengganti volume darah yang hilang dan mempertahankan sirkulasi darah. Garam fisiologis (NaCl 0,9%) atau Ringer Lactate biasa digunakan.

#### **d. Persiapan Transfusi Darah**

Bila perdarahan sangat banyak atau tanda syok memburuk, transfusi darah harus dipersiapkan segera untuk mengganti kehilangan darah.

#### **e. Evakuasi Sisa Plasenta**

Bila terdapat retensi jaringan, tindakan pembersihan rongga uterus (kuretase) dilakukan oleh tenaga medis sesuai protokol.

#### **f. Rujukan Cepat**

Jika tindakan awal gagal menghentikan perdarahan, rujuk segera ke fasilitas kesehatan dengan fasilitas lengkap untuk tindakan lanjutan seperti operasi.

### **4. Manajemen Keperawatan pada Hemoragi Postpartum**

#### **a. Pemantauan Tanda Vital**

Lakukan pengukuran tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas, dan saturasi oksigen setiap 15 menit atau sesuai kebutuhan agar perubahan kondisi segera terdeteksi.

#### **b. Pengukuran dan Dokumentasi Perdarahan**

Catat jumlah darah yang keluar secara akurat menggunakan alat ukur atau estimasi standar untuk evaluasi kondisi.

#### **c. Persiapan Peralatan Resusitasi**

Pastikan alat bantu pernapasan, oksigen, dan obat-obatan emergensi selalu siap pakai.

#### **d. Dukungan Psikologis**

Berikan penjelasan dan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga untuk mengurangi kecemasan dan memberikan rasa aman selama tindakan emergensi.

#### **e. Komunikasi Efektif**

Informasikan kondisi ibu dan langkah-langkah yang diambil secara jelas dan tenang kepada keluarga untuk menjaga kepercayaan dan kerja sama.

#### **f. Dokumentasi Lengkap**

Catat semua tindakan keperawatan dan respons ibu secara detail untuk memudahkan evaluasi dan tindak lanjut medis.

## **B. Infeksi Postpartum (Endometritis, Mastitis, Luka Operasi)**

Infeksi postpartum adalah kondisi infeksi yang terjadi pada ibu selama masa nifas, yaitu periode sekitar enam minggu setelah persalinan. Infeksi ini umumnya disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam tubuh melalui jalan lahir atau luka pascapersalinan. Infeksi postpartum dapat berperan besar dalam meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu jika tidak ditangani secara tepat dan cepat.

Infeksi postpartum dapat berbentuk berbagai manifestasi klinis, antara lain endometritis, mastitis, dan infeksi pada luka operasi (episiotomi atau sayatan operasi sesar). Ketiga jenis infeksi ini memiliki karakteristik klinis dan penanganan yang berbeda, namun memerlukan perhatian khusus oleh tenaga kesehatan.

### **1. Endometritis**

#### **a. Definisi**

Endometritis adalah infeksi pada lapisan dalam rahim (endometrium) yang biasanya terjadi antara hari ke-2 hingga ke-10 pascapersalinan. Infeksi ini biasanya terjadi akibat bakteri aerob dan anaerob yang masuk ke rahim selama atau setelah persalinan.

#### **b. Etiologi**

Bakteri penyebab utama termasuk *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, dan anaerob seperti *Bacteroides* spp.

#### **c. Faktor Risiko**

- Persalinan lama atau macet
- Persalinan dengan operasi sesar
- Retensi plasenta atau jaringan
- Pemasangan kateter urin
- Perawatan luka yang kurang steril

#### **d. Gejala Klinis**

- Demam tinggi ( $>38^{\circ}\text{C}$ ) yang menetap atau naik turun

- Nyeri perut bagian bawah atau rahim saat ditekan
- Lokia (cairan nifas) berbau tidak sedap dan abnormal warna
- Takikardia (denyut jantung cepat) sebagai respon sistemik
- Nyeri punggung bawah atau suprapubik

#### **e. Patofisiologi**

Infeksi menyebabkan inflamasi pada endometrium yang dapat menyebar ke jaringan sekitarnya jika tidak ditangani, berpotensi menyebabkan abses atau sepsis.

### **2. Mastitis**

#### **a. Definisi**

Mastitis adalah peradangan jaringan payudara yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, terutama *Staphylococcus aureus*. Kondisi ini umum dialami ibu menyusui dalam 6 minggu pertama setelah melahirkan.

#### **b. Etiologi**

Infeksi terjadi melalui pecahnya puting susu, memungkinkan bakteri masuk ke saluran susu.

#### **c. Faktor Risiko**

- Penyumbatan saluran susu (mastitis obstruktif)
- Kebersihan payudara kurang baik
- Teknik menyusui yang salah
- Stres dan kelelahan

#### **d. Gejala Klinis**

- Nyeri dan kemerahan pada area payudara
- Pembengkakan dan rasa panas di payudara
- Demam, menggigil, dan malaise
- Payudara terasa keras dan penuh

#### **e. Dampak**

Mastitis yang tidak diobati dapat berkembang menjadi abses payudara yang memerlukan tindakan bedah.

### **3. Infeksi Luka Operasi**

#### **a. Definisi:**

Infeksi luka operasi mencakup infeksi pada luka episiotomi atau luka sayatan operasi sesar. Infeksi ini terjadi akibat masuknya mikroorganisme ke jaringan luka akibat perawatan luka yang tidak steril atau kebersihan yang kurang.

#### **b. Faktor Risiko:**

- Teknik jahitan yang tidak aseptik
- Kebersihan luka yang kurang
- Komorbiditas ibu (diabetes, anemia)
- Lama waktu persalinan dan durasi ruptur ketuban

### **c. Tanda dan Gejala:**

- Kemerahan dan pembengkakan di sekitar luka
- Nyeri tekan berlebihan pada area luka
- Keluar cairan nanah atau berbau busuk dari luka
- Demam dan gejala sistemik infeksi

### **d. Manajemen Keperawatan**

Manajemen keperawatan pada infeksi postpartum harus dilaksanakan secara komprehensif, meliputi aspek fisiologis dan psikososial.

#### **• Pemberian Antibiotik**

Sesuai anjuran dan resep dokter, antibiotik harus diberikan secara tepat waktu untuk melawan infeksi bakteri penyebab. Pemilihan antibiotik harus berdasarkan sensitivitas dan protokol lokal.

#### **• Perawatan Kebersihan Luka dan Area Genital**

Luka episiotomi atau operasi harus dijaga tetap kering dan bersih. Kebersihan area genital harus diperhatikan dengan menggunakan teknik membersihkan dari depan ke belakang untuk mencegah kontaminasi ulang.

#### **• Edukasi Tanda-tanda Infeksi**

Ibu dan keluarga harus diedukasi mengenai tanda-tanda infeksi yang perlu diwaspadai, seperti demam tinggi, nyeri yang tidak berkurang, keluarnya cairan abnormal, kemerahan, atau pembengkakan.

#### **• Dukungan untuk Menyusui**

Pada mastitis, bidan harus mendukung ibu agar tetap menyusui atau memompa ASI untuk mencegah stagnasi dan mempercepat penyembuhan. Edukasi teknik menyusui yang benar juga sangat penting.

#### **• Pemantauan dan Evaluasi**

Tenaga kesehatan harus secara rutin memantau tanda-tanda vital, kondisi luka, serta respons ibu terhadap terapi. Bila ada tanda perburukan, rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap harus segera dilakukan.

#### **• Pendekatan Psikososial**

Berikan dukungan emosional agar ibu merasa nyaman dan tidak stres, karena stres dapat memperlambat proses penyembuhan.

## **C. Depresi dan Gangguan Mental Postpartum**

Depresi postpartum adalah gangguan mood yang muncul pada ibu setelah melahirkan, biasanya dalam 4 minggu hingga 6 bulan pascapersalinan, meskipun bisa muncul lebih lambat. Kondisi ini lebih serius dan bertahan lebih lama dibandingkan baby blues, dan berdampak signifikan pada kesejahteraan psikologis ibu, kemampuan mengasuh bayi, serta hubungan keluarga. Depresi postpartum ditandai dengan perasaan sedih yang

mendalam, kelelahan ekstrem, kehilangan minat atau kesenangan pada aktivitas sehari-hari, gangguan tidur (baik insomnia atau hipersomnia), rasa bersalah berlebihan, konsentrasi menurun, dan pikiran putus asa. Dalam kasus yang parah, ibu dapat mengalami pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayinya, sehingga kondisi ini termasuk keadaan gawat darurat mental.

Selain depresi, pada periode pascapersalinan ibu juga bisa mengalami baby blues, yaitu perubahan mood ringan yang bersifat sementara dan biasanya hilang dalam 2 minggu tanpa pengobatan khusus. Sedangkan psikosis postpartum adalah gangguan mental yang sangat berat dengan gejala seperti halusinasi, delusi, kebingungan akut, dan berisiko tinggi membahayakan ibu dan bayi.

### 1. Faktor Risiko Terjadinya Depresi Postpartum

Beberapa faktor dapat meningkatkan kemungkinan seorang ibu mengalami depresi postpartum, yaitu:

- **Riwayat gangguan mental sebelumnya**, seperti depresi, gangguan kecemasan, atau bipolar, yang dapat membuat ibu lebih rentan mengalami depresi setelah melahirkan.
- **Dukungan sosial yang kurang**, termasuk kurangnya dukungan dari pasangan, keluarga, atau komunitas yang dapat memperburuk kondisi psikologis ibu.
- **Pengalaman kelahiran yang traumatis**, seperti persalinan dengan komplikasi, rasa sakit berlebihan, atau ketakutan saat melahirkan, yang meninggalkan dampak psikologis negatif.
- **Kesulitan dalam menyusui atau merawat bayi**, seperti masalah menyusui, bayi yang rewel, atau kurangnya keterampilan pengasuhan, yang dapat meningkatkan stres dan kelelahan emosional.

### 2. Manajemen Keperawatan Depresi Postpartum

Penanganan depresi postpartum harus dilakukan secara sistemik dengan pendekatan holistik yang melibatkan deteksi dini, intervensi psikososial, dan rujukan profesional jika diperlukan.

- **Skrining Depresi Postpartum**

Gunakan alat skrining standar seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) untuk menilai tingkat depresi. Skrining ini dapat dilakukan rutin pada masa nifas awal untuk mendeteksi gejala yang mungkin belum tampak secara klinis.

- **Konseling Dasar dan Dukungan Emosional**

Berikan dukungan psikologis melalui pendekatan empatik dan komunikasi terbuka. Konseling dasar meliputi mendengarkan keluhan ibu secara aktif, meneguhkan perasaan, serta memberikan informasi tentang depresi postpartum dan strategi mengelola stres.

- **Libatkan Keluarga dalam Pengasuhan**

Edukasi keluarga, terutama pasangan, untuk memahami kondisi ibu dan memberikan dukungan emosional serta praktis. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam membantu ibu menjalani peran baru dan mengurangi beban psikologis.

- **Rujukan ke Profesional Kesehatan Jiwa**

Bila ditemukan gejala berat seperti pikiran untuk bunuh diri, halusinasi, atau depresi berat yang mengganggu fungsi, segera lakukan rujukan ke psikolog, psikiater, atau layanan kesehatan mental profesional untuk evaluasi dan terapi lebih lanjut.

- **Pemantauan dan Keamanan Ibu**

Pastikan ibu tidak dibiarkan sendiri dalam kondisi yang mencurigakan atau berisiko membahayakan diri dan bayi. Pantau secara ketat dan koordinasikan dengan tim kesehatan multidisiplin untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi.

## **D. Pembekuan Darah dan Tromboemboli**

Pembekuan darah dan tromboemboli adalah komplikasi serius yang dapat terjadi pada ibu selama masa nifas, yaitu periode 6 minggu pertama setelah persalinan. Kondisi ini berkaitan dengan terbentuknya bekuan darah (trombus) yang dapat menyumbat pembuluh darah, menghambat aliran darah, dan berpotensi mengancam nyawa jika tidak ditangani dengan cepat.

Masa nifas memiliki risiko tinggi terhadap kejadian trombosis karena berbagai perubahan fisiologis dan faktor predisposisi. Secara fisiologis, masa nifas ditandai oleh keadaan hiperkoagulabilitas sebagai mekanisme tubuh untuk mencegah perdarahan berlebihan pascapersalinan. Selain itu, aktivitas fisik ibu yang berkurang akibat kelelahan, nyeri, atau komplikasi lain juga meningkatkan risiko penggumpalan darah. Trauma jaringan selama persalinan, seperti robekan jalan lahir atau operasi sesar, juga berkontribusi terhadap proses ini.

### **1. Jenis-Jenis Tromboemboli**

Pada masa nifas, dua bentuk tromboemboli yang paling sering ditemui adalah:

#### **a. Trombosis Vena Dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT)**

Merupakan pembekuan darah yang terjadi di vena dalam, umumnya di ekstremitas bawah seperti tungkai. DVT dapat menyebabkan pembengkakan, rasa nyeri, kemerahan, dan rasa hangat pada area yang terkena.

#### **b. Emboli Paru (Pulmonary Embolism/PE)**

Terjadi apabila trombus yang terbentuk terlepas dari lokasi asalnya dan mengalir



ke pembuluh darah paru-paru, menyumbat aliran darah. PE dapat mengakibatkan gangguan pernapasan akut dan kematian jika tidak segera ditangani.

## **2. Tanda dan Gejala Klinis**

Gejala trombosis dan emboli paru dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan beratnya penyumbatan:

### **a. Pada Trombosis Vena Dalam:**

Ibu akan mengeluhkan nyeri pada tungkai, pembengkakan yang tidak simetris antara kedua tungkai, kemerahan pada kulit di sekitar area yang terdampak, dan rasa hangat saat disentuh.

### **b. Pada Emboli Paru:**

Gejala muncul secara mendadak dan dapat berupa sesak napas akut, nyeri dada yang tajam dan memberat saat bernapas dalam, palpitasi atau jantung berdebar, serta terkadang batuk berdarah. Dalam kasus emboli paru berat, ibu dapat mengalami penurunan kesadaran, syok, dan bahkan kematian mendadak.

## **3. Faktor Risiko**

Faktor-faktor yang meningkatkan risiko tromboemboli pada masa nifas antara lain:

- Perubahan fisiologis hiperkoagulabilitas selama kehamilan dan nifas
- Imobilisasi atau bed rest yang berkepanjangan
- Trauma jaringan dan operasi sesar
- Riwayat trombosis sebelumnya
- Obesitas, usia lanjut, dan riwayat penyakit kronis
- Penggunaan kontrasepsi hormonal sebelumnya

## **4. Manajemen Keperawatan**

Manajemen keperawatan pada pembekuan darah dan tromboemboli bertujuan mencegah terjadinya komplikasi dan mendeteksi dini tanda-tanda klinis yang mengarah ke kondisi ini.

### **• Mobilisasi Dini:**

Anjurkan ibu untuk bergerak aktif sesegera mungkin setelah persalinan, sesuai kemampuan. Mobilisasi dini terbukti efektif mencegah pembentukan trombus dengan meningkatkan aliran darah vena.

### **• Edukasi Mengenai Gerak Aktif:**

Berikan penjelasan kepada ibu dan keluarga mengenai pentingnya aktivitas fisik untuk mencegah pembekuan darah. Ajarkan cara melakukan latihan kaki sederhana saat berbaring untuk memperlancar sirkulasi.

### **• Penggunaan Stocking Kompresi Elastis:**

Jika ibu berisiko tinggi atau memiliki riwayat DVT, gunakan stocking kompresi elastis sesuai indikasi medis untuk membantu mencegah penggumpalan darah.

### **• Monitoring Tanda Vital dan Tanda-Tanda Klinis:**

Pantau tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, dan saturasi oksigen secara rutin.

Perhatikan juga adanya nyeri, pembengkakan, kemerahan pada tungkai, serta keluhan sesak napas atau nyeri dada.

- **Pelaporan Cepat pada Gejala Mencurigakan:**

Segera laporkan dan tindak lanjuti jika ditemukan gejala tromboemboli untuk mendapatkan penanganan medis cepat dan tepat.

- **Dukungan Emosional dan Edukasi:**

Berikan dukungan psikologis agar ibu tidak cemas berlebihan serta berikan edukasi tentang risiko dan langkah-langkah pencegahan yang harus dijalani.

## **E. Komplikasi Lain yang Mungkin Terjadi**

Selain komplikasi utama seperti hemoragi postpartum dan infeksi postpartum, masa nifas juga berisiko mengalami komplikasi lain yang perlu diwaspadai oleh tenaga kesehatan agar penanganan bisa dilakukan secara tepat dan cepat. Komplikasi-komplikasi ini tidak kalah pentingnya karena dapat memengaruhi pemulihan ibu dan kelangsungan fungsi reproduksi serta kualitas hidupnya.

### **1. Hipertensi Postpartum**

Hipertensi postpartum adalah kondisi dimana tekanan darah ibu meningkat setelah persalinan. Meskipun banyak ibu yang tekanan darahnya menurun setelah melahirkan, sebagian mengalami peningkatan tekanan darah yang dapat berkembang menjadi preeklampsia postpartum, kondisi serius yang ditandai dengan hipertensi berat dan risiko komplikasi organ, seperti kerusakan ginjal, edema paru, hingga kejang (eklampsia). Pentingnya monitoring tekanan darah secara berkala selama masa nifas tidak bisa diabaikan untuk mendeteksi gejala awal hipertensi dan mencegah komplikasi. Tanda-tanda peringatan seperti sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati, dan pembengkakan ekstremitas harus diwaspadai.

### **2. Gangguan Saluran Kemih**

Infeksi saluran kemih (ISK) sering terjadi akibat prosedur medis seperti kateterisasi selama persalinan atau kebersihan yang kurang optimal. ISK menyebabkan ketidaknyamanan dan berpotensi menimbulkan komplikasi lebih lanjut seperti pielonefritis. Gejala khas ISK meliputi nyeri saat berkemih, sering berkemih dengan volume sedikit, demam, serta nyeri pinggang atau perut bagian bawah. Deteksi dini dan penanganan ISK sangat penting untuk menghindari kerusakan ginjal dan mempercepat pemulihan ibu. Edukasi terkait kebersihan pribadi dan teknik berkemih yang benar juga harus diberikan.

### **3. Retensi Urine**

Retensi urine adalah kondisi dimana ibu mengalami kesulitan mengosongkan kandung kemih secara penuh setelah persalinan. Retensi ini dapat terjadi akibat

trauma pada saraf pelvis selama persalinan, obat-obatan analgesik, atau pembengkakan jaringan sekitar uretra. Jika tidak segera ditangani, retensi urine dapat menyebabkan distensi kandung kemih, infeksi saluran kemih, dan ketidaknyamanan yang signifikan. Pemantauan pola berkemih, pengukuran sisa urine post-micturition, serta penggunaan kateterisasi intermiten jika diperlukan merupakan bagian penting dalam manajemen retensi urine.

#### **4. Masalah Produksi ASI**

Masa nifas adalah waktu penting untuk memulai dan mempertahankan produksi ASI. Namun, beberapa ibu mengalami masalah seperti produksi ASI yang tidak adekuat, mastitis (infeksi dan peradangan payudara), dan masalah mekanis dalam menyusui. Mastitis dapat menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, dan demam, serta mengganggu proses menyusui jika tidak ditangani dengan baik. Manajemen meliputi pemberian antibiotik, edukasi teknik menyusui yang benar, pengosongan payudara secara efektif, dan dukungan psikologis agar ibu tetap termotivasi untuk menyusui.

#### **5. Gangguan Psikologis Lain**

Selain depresi postpartum, ibu pada masa nifas juga dapat mengalami gangguan psikologis lain seperti kecemasan berlebihan, stres, dan psikosis postpartum. Psikosis postpartum adalah kondisi mental serius yang dapat menyebabkan halusinasi, delusi, dan perilaku berbahaya bagi ibu maupun bayi. Deteksi dini melalui skrining psikologis, konseling, dan rujukan ke layanan kesehatan mental sangat penting. Pendekatan holistik dengan melibatkan keluarga dan memberikan dukungan sosial menjadi faktor kunci keberhasilan penanganan gangguan ini.

#### **6. Manajemen Keperawatan Komprehensif**

Penanganan komplikasi lain pada masa nifas harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan keperawatan yang sistematis:

- **Pemeriksaan dan Pemantauan Komprehensif**

Melakukan pengkajian rutin meliputi pemeriksaan tekanan darah, evaluasi tanda dan gejala infeksi saluran kemih, pola berkemih, pemeriksaan payudara, serta status psikologis ibu. Pemantauan ini penting untuk mendeteksi tanda awal komplikasi.

- **Edukasi dan Dukungan Sesuai Kondisi**

Memberikan edukasi yang sesuai dengan kebutuhan ibu, seperti cara menjaga kebersihan saluran kemih, teknik menyusui, pengelolaan stres, dan pentingnya mematuhi pengobatan. Memberikan dukungan emosional agar ibu merasa didengar dan termotivasi.

- **Rujukan Tepat Waktu**

Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan medis lebih lanjut, seperti hipertensi berat, infeksi saluran kemih yang berat, gangguan produksi ASI berat, atau gangguan mental serius, lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang sesuai.

- **Keterlibatan Keluarga**

Melibatkan keluarga sebagai bagian dari sistem dukungan sosial dan emosional sangat penting untuk keberhasilan perawatan. Keluarga dapat membantu memantau kondisi ibu, memberikan bantuan praktis, dan mendukung aspek psikologis.

## F. Latihan Soal

### Tugas

#### Tugas 1

**Kasus:** Seorang ibu 28 tahun, hari ke-2 pascapersalinan normal, mengeluh perdarahan yang terus menerus dan terasa lemas. Palpasi fundus uteri menunjukkan rahim lunak. Jelaskan langkah-langkah manajemen keperawatan yang harus Anda lakukan mulai dari identifikasi masalah, tindakan emergensi hingga edukasi yang diberikan kepada ibu dan keluarga.

#### Tugas 2

**Kasus:** Ibu berumur 32 tahun, hari ke-5 nifas, datang dengan demam 38,8°C, nyeri perut bawah, dan keluarnya cairan berbau tidak sedap dari jalan lahir. Buatlah analisis keperawatan dan rencana asuhan yang lengkap untuk kasus infeksi postpartum (endometritis) ini.

#### Tugas 3

**Kasus:** Seorang ibu menyusui mengalami kemerahan dan nyeri pada payudara kiri serta demam. Uraikan bagaimana Anda akan melakukan asuhan keperawatan, termasuk intervensi fisik dan psikososial, serta edukasi yang diperlukan untuk mendukung ibu agar tetap menyusui.

#### Tugas 4

**Kasus:** Seorang ibu nifas mengeluh nyeri dan pembengkakan pada tungkai kanan setelah operasi sesar. Jelaskan tanda-tanda klinis trombosis vena dalam, risiko yang mungkin timbul, dan langkah-langkah manajemen keperawatan yang harus dilakukan.

#### Tugas 5

**Esai:** Jelaskan secara komprehensif gangguan psikologis yang dapat dialami ibu masa nifas, terutama depresi postpartum. Bahas faktor risiko, tanda-tanda klinis, serta peran bidan dalam deteksi dini, penanganan, dan edukasi keluarga.

## Pilihan Ganda

---

1. Seorang ibu pascapersalinan melahirkan secara normal 3 jam yang lalu. Saat pemeriksaan, ditemukan perdarahan pervaginam berlebih sekitar 800 ml, fundus uteri terasa lunak dan tidak kontraksi, serta ibu tampak pucat dan lemas. Apa kemungkinan penyebab perdarahan ini?
  - A. Retensi plasenta
  - B. Trauma jalan lahir
  - C. Atonia uteri
  - D. Gangguan koagulasi
  - E. Infeksi uterus
2. Seorang ibu 4 hari pascapersalinan mengalami demam 38,5°C, nyeri perut bagian bawah, lokia berbau tidak sedap, dan denyut nadi meningkat. Diagnosis kemungkinan yang tepat adalah
  - A. Mastitis
  - B. Endometritis
  - C. Infeksi luka operasi
  - D. Infeksi saluran kemih
  - E. Depresi postpartum
3. Seorang ibu menyusui 2 minggu setelah melahirkan mengalami payudara kemerahan, nyeri hebat, demam, dan pembengkakan. Manajemen keperawatan awal yang paling tepat adalah
  - A. Memberikan analgesik dan menghentikan menyusui
  - B. Mengajarkan teknik menyusui yang benar dan memberi antibiotik
  - C. Menganjurkan ibu untuk tidak menyentuh payudara
  - D. Melakukan kuretase payudara
  - E. Melakukan pemasangan kateter urin
4. Ibu nifas mengalami gejala nyeri, bengkak, kemerahan pada tungkai kiri, dan rasa hangat saat disentuh. Tanda vital menunjukkan denyut jantung cepat. Apa komplikasi yang paling mungkin dialami ibu tersebut?
  - A. Hipertensi postpartum
  - B. Trombosis vena dalam
  - C. Emboli paru
  - D. Infeksi luka operasi
  - E. Retensi urine

5. Seorang ibu baru melahirkan menunjukkan gejala kesedihan mendalam, sulit tidur, merasa tidak berharga, dan menghindari interaksi dengan bayi. Manajemen keperawatan yang paling tepat adalah
- A. Memberikan dukungan psikologis, melakukan skrining depresi postpartum, dan melibatkan keluarga
  - B. Mengabaikan karena gejala wajar pada ibu baru
  - C. Memberikan obat tidur tanpa evaluasi lanjutan
  - D. Memarahi ibu agar lebih kuat
  - E. Menyuruh ibu beristirahat total dan tidak berinteraksi dengan bayi

### Kunci Jawaban

---

1. Kunci Jawaban: C  
Pembahasan: Atonia uteri adalah penyebab paling umum perdarahan postpartum primer dan terjadi akibat kegagalan rahim berkontraksi dengan baik sehingga pembuluh darah terbuka terus-menerus.
2. Kunci Jawaban: B  
Pembahasan: Gejala demam, nyeri uterus, lochia berbau adalah karakteristik khas endometritis, yaitu infeksi pada lapisan dalam rahim.
3. Kunci Jawaban: B  
Pembahasan: Mastitis dapat diatasi dengan teknik menyusui yang tepat dan pemberian antibiotik. Menyusui tetap dianjurkan untuk mencegah stagnasi ASI.
4. Kunci Jawaban: B  
Pembahasan: Nyeri, bengkak, kemerahan, dan rasa hangat pada tungkai merupakan tanda khas trombosis vena dalam (DVT).
5. Kunci Jawaban: A  
Pembahasan: Gejala tersebut merupakan tanda depresi postpartum. Penanganan meliputi dukungan emosional, skrining menggunakan alat standar seperti EPDS, dan keterlibatan keluarga sangat penting.

## G. Rangkuman Materi

Masa nifas adalah periode penting setelah kelahiran, di mana tubuh ibu mengalami proses pemulihan dari berbagai perubahan fisiologis selama kehamilan dan persalinan. Walaupun banyak ibu mengalami adaptasi yang normal selama masa ini, terdapat sejumlah komplikasi serius yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa serta kesejahteraan fisik dan mental ibu. Tiga komplikasi utama yang sering terjadi adalah hemoragi postpartum (PPH), infeksi postpartum, dan gangguan mental seperti depresi postpartum. Deteksi dini dan penanganan yang tepat terhadap komplikasi-komplikasi

tersebut merupakan bagian penting dari asuhan keperawatan kebidanan yang profesional.

Hemoragi postpartum adalah kondisi perdarahan berlebihan setelah persalinan, yang menjadi penyebab utama kematian ibu terutama dalam 24 jam pertama pascapersalinan. Definisi WHO menyebutkan bahwa PPH adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml setelah persalinan pervaginam dan lebih dari 1000 ml setelah operasi sesar. Perdarahan terjadi karena kegagalan mekanisme fisiologis tubuh dalam menghentikan perdarahan dari tempat plasenta melekat pada rahim. Penyebab PPH dikenal dengan istilah 4T, yaitu atonia uteri yang paling sering terjadi, retensi jaringan plasenta atau membran yang menghambat kontraksi rahim, trauma jalan lahir seperti robekan atau ruptur, serta gangguan koagulasi yang memperberat perdarahan. Tanda-tanda PPH meliputi perdarahan berlebihan, fundus uteri yang lunak dan tidak berkontraksi, serta gejala syok hipovolemik seperti pucat, lemas, takikardia, dan penurunan kesadaran.

Penanganan emergensi PPH harus dilakukan segera dan bertahap dengan tujuan menghentikan perdarahan dan mencegah komplikasi fatal. Kompresi bimanual uterus merupakan tindakan pertama untuk merangsang kontraksi rahim. Selanjutnya pemberian uterotonika seperti oksitosin, misoprostol, dan ergometrin harus dilakukan secepatnya. Cairan kristaloid infus diberikan cepat untuk mengganti volume darah yang hilang, disusul persiapan transfusi darah jika perdarahan berat. Jika terdapat sisa plasenta, pembersihan rongga uterus (kuretase) harus dilakukan oleh tenaga medis. Jika langkah-langkah tersebut tidak berhasil, rujukan ke fasilitas kesehatan dengan fasilitas lengkap harus segera dilakukan. Manajemen keperawatan pada PPH mencakup pemantauan tanda vital secara ketat, dokumentasi jumlah perdarahan, persiapan peralatan resusitasi, dukungan psikologis bagi ibu dan keluarga, komunikasi efektif, serta pencatatan tindakan dan respons secara rinci.

Infeksi postpartum adalah infeksi yang terjadi pada ibu dalam masa nifas akibat bakteri yang masuk melalui jalan lahir atau luka. Bentuk infeksi postpartum meliputi endometritis, mastitis, dan infeksi luka operasi. Endometritis adalah infeksi pada lapisan dalam rahim yang biasanya terjadi antara hari ke-2 hingga ke-10 pascapersalinan, dengan gejala demam tinggi, nyeri perut bawah, lochia berbau tidak sedap, dan takikardia. Mastitis adalah peradangan jaringan payudara akibat infeksi bakteri, terutama pada ibu menyusui, ditandai dengan nyeri, kemerahan, demam, dan pembengkakan payudara. Infeksi luka operasi seperti luka episiotomi atau sayatan operasi sesar dapat terjadi jika perawatan luka tidak steril, dengan tanda kemerahan, pembengkakan, nyeri tekan, nanah, dan demam. Manajemen keperawatan infeksi

postpartum meliputi pemberian antibiotik sesuai resep, perawatan kebersihan luka dan area genital, edukasi tanda-tanda infeksi, dukungan menyusui pada mastitis, pemantauan tanda vital, evaluasi respons terapi, dan pendekatan psikososial untuk mengurangi stres ibu.

Depresi postpartum adalah gangguan mood yang muncul pada ibu setelah melahirkan yang lebih berat dan tahan lama dibanding baby blues. Gejala depresi postpartum mencakup kesedihan mendalam, kelelahan ekstrem, gangguan tidur, rasa bersalah berlebihan, kehilangan minat, serta pikiran untuk menyakiti diri atau bayi. Faktor risiko antara lain riwayat gangguan mental, dukungan sosial kurang, pengalaman kelahiran traumatis, dan kesulitan menyusui. Manajemen keperawatan meliputi skrining menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale, konseling dasar, dukungan emosional, edukasi keluarga, rujukan ke profesional kesehatan jiwa bila diperlukan, dan pengawasan ketat untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi.

Pembekuan darah dan tromboemboli merupakan komplikasi serius pada masa nifas yang berkaitan dengan pembentukan bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah. Masa nifas ditandai oleh kondisi hiperkoagulabilitas, penurunan mobilitas akibat kelelahan atau nyeri, dan trauma jaringan selama persalinan yang meningkatkan risiko trombosis. Dua jenis utama adalah trombosis vena dalam (DVT) yang biasanya terjadi di ekstremitas bawah dan emboli paru (PE) yang merupakan bekuan darah yang berpindah ke paru-paru. Gejalanya termasuk nyeri, bengkak, kemerahan pada tungkai, serta sesak napas akut, nyeri dada, dan palpitasi pada emboli paru. Faktor risiko meliputi imobilisasi, riwayat trombosis, obesitas, operasi sesar, dan penggunaan kontrasepsi hormonal. Manajemen keperawatan fokus pada mobilisasi dini, edukasi gerak aktif, penggunaan stocking kompresi, monitoring tanda vital, pelaporan cepat gejala, serta dukungan emosional dan edukasi pada ibu.

Selain komplikasi utama tersebut, masa nifas juga dapat diwarnai komplikasi lain seperti hipertensi postpartum yang dapat berkembang menjadi preeklamsia berat, gangguan saluran kemih yang sering dipicu oleh kateterisasi, retensi urine akibat trauma saraf atau efek obat, masalah produksi ASI, serta gangguan psikologis lain seperti kecemasan dan psikosis postpartum. Deteksi dini, edukasi, penanganan medis yang tepat, dan dukungan keluarga menjadi kunci keberhasilan manajemen komplikasi ini. Pendekatan keperawatan harus holistik dan sistematis dengan pengkajian rutin, edukasi personal, rujukan tepat waktu, serta melibatkan keluarga sebagai bagian dari sistem dukungan sosial dan emosional ibu pascapersalinan.



## H. Glosarium

**Atonia Uteri:** Kondisi di mana otot rahim tidak berkontraksi dengan baik setelah persalinan, menyebabkan perdarahan karena pembuluh darah yang terbuka tidak tertutup.

**Depresi Postpartum:** Gangguan mood berat yang muncul pada ibu setelah melahirkan, ditandai dengan kesedihan mendalam, kelelahan, gangguan tidur, dan pikiran untuk menyakiti diri atau bayi.

**Darah Nifas (Lokia):** Cairan yang keluar dari rahim setelah persalinan, terdiri dari darah, lendir, dan jaringan rahim yang mengalami pelepasan.

**Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS):** Alat skrining standar yang digunakan untuk mendeteksi gejala depresi postpartum pada ibu.

**Emboli Paru (Pulmonary Embolism/PE):** Kondisi penyumbatan arteri paru oleh bekuan darah yang berasal dari bagian lain tubuh, sering kali mengancam jiwa.

**Endometritis:** Infeksi pada lapisan dalam rahim (endometrium) yang terjadi pada masa nifas, biasanya disebabkan oleh bakteri.

**Hemoragi Postpartum (PPH):** Perdarahan berlebihan setelah persalinan, yang dapat membahayakan jiwa ibu jika tidak ditangani segera.

**Hipertensi Postpartum:** Kondisi peningkatan tekanan darah setelah melahirkan yang dapat menyebabkan komplikasi serius seperti preeklamsia.

**Infeksi Luka Operasi:** Infeksi yang terjadi pada luka jahitan persalinan, seperti luka episiotomi atau luka operasi sesar, akibat masuknya mikroorganisme patogen.

**Mastitis:** Peradangan payudara yang disebabkan oleh infeksi bakteri, biasanya terjadi pada ibu menyusui.

**Mobilisasi Dini:** Upaya mendorong ibu untuk bergerak atau berjalan segera setelah persalinan guna mencegah komplikasi seperti trombosis.

**Preeklamsia Postpartum:** Suatu kondisi hipertensi yang muncul atau berlanjut setelah persalinan, dengan risiko komplikasi pada organ vital.

**Retensi Urine:** Kesulitan mengosongkan kandung kemih secara penuh, yang dapat menyebabkan infeksi dan ketidaknyamanan.

**Skrining:** Proses pemeriksaan dini untuk mendeteksi kemungkinan adanya gangguan kesehatan atau komplikasi.

**Syok Hipovolemik:** Kondisi kegawatan akibat kehilangan darah yang masif, menyebabkan penurunan aliran darah dan oksigenasi jaringan.

**Trombosis Vena Dalam (Deep Vein Thrombosis/DVT):** Pembentukan bekuan darah pada vena dalam, biasanya di tungkai, yang dapat menyebabkan pembengkakan dan nyeri.

**Uterotonika:** Obat-obatan yang merangsang kontraksi otot rahim untuk menghentikan perdarahan pascapersalinan.

## I. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Practice Bulletin No. 183: Postpartum Hemorrhage. *Obstetrics & Gynecology*, 130(4), e168–e186. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002238>
- Bauer, A., Parsonage, M., Knapp, M., Lemmi, V., & Adelaja, B. (2014). *Costs of perinatal mental health problems*. Centre for Mental Health and London School of Economics and Political Science.
- Dewey, K. G., & Nommsen-Rivers, L. A. (2017). Preventing and managing mastitis. *International Breastfeeding Journal*, 12, 7. <https://doi.org/10.1186/s13006-017-0107-3>
- Goldenberg, R. L., & McClure, E. M. (2015). Infection-related stillbirths. *The Lancet*, 375(9724), 1482–1483. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60608-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60608-8)
- International Confederation of Midwives & World Health Organization. (2019). *Essential competencies for midwifery practice 2019*. Geneva: WHO.
- Knight, M., Bunch, K., Tuffnell, D., Jayakody, H., Shakespeare, J., Kotnis, R., Kenyon, S., & Kurinczuk, J. J. (Eds.). (2019). *Saving Lives, Improving Mothers' Care – Lessons learned to inform maternity care from the UK and Ireland Confidential Enquiries into Maternal Deaths and Morbidity 2015-17*. Oxford: National Perinatal Epidemiology Unit, University of Oxford.
- Kuhn, P., Swart, P., & Goodman, L. (2019). Postpartum depression and psychosocial risk factors among women in South Africa: A systematic review. *African Journal of Psychiatry*, 22(3), 124–132. <https://doi.org/10.1002/ajp.24367>
- Mousa, H. A., Blum, J., Abou El Senoun, G., Shabaan, A., & Patel, A. (2014). Treatment for primary postpartum haemorrhage. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (2), CD003249. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003249.pub3>
- World Health Organization. (2012). *WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage*. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2018). *Maternal mental health and child health and development in low and middle income countries: Report of the WHO expert consultation*. Geneva: WHO.
- Zeray, N., Kebede, A., & Mekonen, N. (2017). Prevalence and associated factors of postpartum depression in Ethiopia: A systematic review and meta-analysis. *Depression Research and Treatment*, 2017, 5937171. <https://doi.org/10.1155/2017/5937171>

# Bab 7

## Peran Bidan Dalam Tim Kesehatan Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode penting dalam siklus reproduksi seorang perempuan, di mana pemulihan fisik dan psikologis pascapersalinan menjadi fokus utama. Pada masa ini, ibu membutuhkan asuhan yang komprehensif dan holistik agar dapat menjalani proses pemulihan dengan baik sekaligus mencegah komplikasi. Peran bidan dalam masa nifas tidak hanya terbatas pada pemberian asuhan langsung, melainkan juga melibatkan kolaborasi yang erat dengan berbagai tenaga kesehatan lain seperti dokter, konselor laktasi, dan psikolog. Selain itu, pendokumentasian asuhan nifas yang akurat dan sistematis sangat penting untuk menjamin kesinambungan pelayanan dan kualitas asuhan. Bidan juga berperan dalam proses rujukan dan tindak lanjut pasien yang memiliki risiko tinggi, serta turut aktif dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan maternal di tingkat pelayanan maupun komunitas. Peran multifaset bidan dalam tim kesehatan menjadikan mereka sebagai garda terdepan dalam keberhasilan asuhan nifas dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan dan menerapkan peran bidan sebagai anggota aktif dalam tim kesehatan maternal masa nifas, menunjukkan kemampuan kolaborasi profesional yang efektif, melakukan pendokumentasian asuhan secara sistematis, serta mengelola rujukan dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kesehatan maternal. Lulusan juga mampu menunjukkan sikap profesionalisme, etika, dan kepedulian sosial dalam memberikan asuhan yang berpusat pada ibu dan keluarga.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan peran bidan dalam konteks tim kesehatan selama masa nifas, meliputi kolaborasi lintas profesi, pendokumentasian asuhan, mekanisme rujukan dan tindak lanjut pasien risiko tinggi, serta pengembangan kebijakan dan program kesehatan maternal yang mendukung pelayanan berkualitas dan berkelanjutan.

**Sub-CPMK**

1. Menguraikan prinsip-prinsip dan teknik kolaborasi bidan dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, konselor laktasi, dan psikolog dalam asuhan masa nifas.
2. Menerapkan tata cara pendokumentasian asuhan nifas sesuai standar yang berlaku guna memastikan kontinuitas dan kualitas layanan.
3. Menjelaskan prosedur rujukan dan tindak lanjut pasien dengan risiko tinggi secara efektif dan tepat waktu.
4. Menganalisis peran bidan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan maternal di tingkat pelayanan dan komunitas.

## **A. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lain**

Kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah aspek fundamental dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas, khususnya pada masa nifas. Masa nifas adalah periode transisi yang kompleks, di mana ibu membutuhkan perhatian medis, psikologis, dan sosial yang terpadu. Bidan sebagai pemberi asuhan utama masa nifas harus berperan sebagai koordinator utama yang mampu menjalin kerja sama efektif dengan berbagai profesi kesehatan lain. Sinergi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ibu secara holistik, meningkatkan hasil kesehatan, dan mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi.

### **1. Kolaborasi dengan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan**

Dalam kasus komplikasi serius masa nifas, seperti hemoragi postpartum yang tidak terkontrol, infeksi berat, atau gangguan psikologis yang memerlukan intervensi medis, kolaborasi antara bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan menjadi sangat penting. Komunikasi efektif harus terjalin melalui konsultasi yang mendalam, pelaporan kondisi pasien secara detail dan akurat, serta pelaksanaan rekomendasi dokter secara tepat waktu dan sesuai standar klinis. Bidan bertugas melakukan monitoring kondisi pasien secara ketat dan melaporkan perubahan yang signifikan untuk memastikan penanganan medis yang optimal.

Selain itu, kolaborasi ini juga mencakup koordinasi dalam pengelolaan rujukan, penanganan darurat, serta perencanaan asuhan lanjutan bagi pasien dengan risiko tinggi. Kerjasama yang baik antara bidan dan dokter spesialis membantu memastikan keputusan klinis yang cepat, tepat, dan berbasis bukti untuk keselamatan ibu dan bayi.

### **2. Kerjasama dengan Konselor Laktasi**

Masa nifas adalah waktu kritis untuk keberhasilan menyusui yang berdampak pada kesehatan bayi dan ibu. Konselor laktasi memegang peranan vital dalam mendukung ibu agar dapat menyusui dengan teknik yang benar dan mengatasi berbagai masalah menyusui, seperti pelekatan yang buruk, mastitis, atau produksi ASI yang rendah. Bidan harus mengenali tanda-tanda kesulitan menyusui dan secara proaktif merujuk ibu ke konselor laktasi untuk mendapatkan bantuan khusus. Melalui edukasi terpadu, bidan dan konselor laktasi bersama-sama membangun dukungan yang holistik bagi ibu, mempromosikan pemberian ASI eksklusif, serta meningkatkan tingkat keberhasilan menyusui. Pendekatan bersama ini juga mengurangi risiko komplikasi seperti mastitis dan meningkatkan kesejahteraan ibu secara keseluruhan.

### **3. Sinergi dengan Psikolog dan Tenaga Kesehatan Mental**

Ibu pada masa nifas rentan terhadap gangguan psikologis seperti depresi postpartum, kecemasan, dan stres. Bidan perlu memiliki kemampuan untuk

mengidentifikasi gejala awal gangguan mental dan bertindak sebagai pen jembatan antara ibu dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental lainnya.

Sinergi ini melibatkan rujukan tepat waktu, koordinasi perawatan psikologis, serta tindak lanjut yang berkelanjutan. Bidan juga harus aktif memberikan dukungan psikososial, konseling dasar, dan edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental pascapersalinan. Pendekatan multidisipliner ini sangat penting untuk mencegah dampak negatif gangguan mental pada ibu dan perkembangan bayi.

#### **4. Kolaborasi dengan Tenaga Kesehatan Lainnya: Farmasis, Nutrisionis, dan Tenaga Sosial**

Selain tenaga kesehatan medis dan psikososial, bidan juga berkolaborasi dengan berbagai tenaga lain yang mendukung keberhasilan asuhan nifas. Farmasis berperan penting dalam memastikan pemberian obat yang tepat, manajemen efek samping, dan edukasi penggunaan obat. Nutrisionis membantu dalam penyusunan program gizi yang mendukung pemulihan ibu dan optimalisasi produksi ASI. Tenaga sosial memberikan dukungan sosial yang esensial, termasuk menghubungkan ibu dengan sumber daya komunitas, membantu keluarga memahami dinamika perawatan ibu, serta mengatasi hambatan sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi proses pemulihan. Kolaborasi lintas profesi ini menjadikan asuhan nifas lebih komprehensif, memastikan bahwa aspek medis, nutrisi, psikologis, dan sosial terpenuhi secara simultan, sehingga mendukung kesehatan dan kesejahteraan ibu secara menyeluruh.

## **B. Pendokumentasian Asuhan Nifas**

Pendokumentasian asuhan adalah bagian esensial dalam praktik kebidanan dan pelayanan kesehatan secara umum. Dokumentasi yang akurat, lengkap, dan sistematis tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, tetapi juga merupakan bukti tertulis yang menjamin mutu asuhan, legalitas tindakan, dan keberlangsungan pelayanan pasien. Dalam konteks pelayanan masa nifas, pendokumentasian menjadi semakin penting karena kompleksitas perubahan fisik dan psikologis yang dialami ibu, serta kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut secara tepat waktu.

### **1. Pentingnya Pendokumentasian Lengkap**

Setiap aspek asuhan kebidanan yang meliputi hasil pemeriksaan fisik, pengukuran tanda vital, intervensi keperawatan yang diberikan, edukasi dan konseling kepada ibu dan keluarga, serta respons dan perubahan kondisi ibu harus dicatat secara lengkap. Pendokumentasian yang menyeluruh memudahkan tenaga kesehatan lain dalam memahami kondisi pasien sehingga dapat memberikan asuhan lanjutan yang konsisten dan terintegrasi. Selain itu, dokumentasi berperan dalam audit

mutu, akreditasi institusi kesehatan, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien. Dokumentasi lengkap juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien, karena informasi yang terekam dengan baik mengurangi risiko kesalahan dalam pemberian tindakan atau obat. Informasi terdokumentasi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan klinis, memudahkan evaluasi hasil asuhan, dan membantu identifikasi dini komplikasi atau kebutuhan perubahan rencana asuhan.

## **2. Standar Dokumentasi**

Pendokumentasian harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh institusi atau lembaga regulasi kesehatan. Format yang sering digunakan adalah model SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan), yang mengorganisir data secara sistematis dari informasi yang diperoleh (subjektif dan objektif), analisis kondisi, hingga rencana tindak lanjut. Selain SOAP, institusi dapat menggunakan format lain seperti PIE (Problem, Intervention, Evaluation) atau DAR (Data, Action, Response) sesuai kebutuhan. Bahasa yang digunakan dalam dokumentasi harus jelas, singkat, objektif, dan mudah dipahami oleh seluruh tim kesehatan. Hindari istilah yang ambigu atau tidak baku, serta catat waktu dan tanda tangan petugas yang melakukan pencatatan untuk menjaga akuntabilitas.

## **3. Dokumentasi Digital dan Manual**

Pendokumentasian secara manual dengan catatan tertulis masih banyak digunakan terutama di fasilitas pelayanan primer dan daerah terpencil. Namun, sistem Rekam Medis Elektronik (RME) semakin berkembang dan digunakan luas di berbagai institusi kesehatan modern. Sistem digital ini memudahkan pencatatan data, penyimpanan yang lebih aman, pencarian data yang cepat, serta integrasi data antar unit pelayanan. Keuntungan lain dari dokumentasi digital termasuk mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan data, meminimalkan kesalahan penulisan, dan mendukung telemedisin serta rujukan antar fasilitas secara efisien. Namun, penggunaan RME harus diimbangi dengan pelatihan yang memadai untuk tenaga kesehatan serta pemenuhan aspek keamanan data.

## **4. Etika dan Privasi Data**

Dalam melakukan pendokumentasian, bidan harus selalu menjaga kerahasiaan data pasien sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia maupun internasional (misalnya GDPR jika berlaku). Informasi pasien hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang dan digunakan sesuai tujuan pelayanan kesehatan. Setiap pelanggaran privasi dapat berakibat pada hilangnya kepercayaan pasien, sanksi hukum, serta dampak negatif pada institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, protokol keamanan data harus dipatuhi, baik pada dokumentasi manual maupun elektronik, dengan penggunaan password, enkripsi data, serta pengaturan hak akses yang ketat.



## C. Rujukan dan Tindak Lanjut Pasien dengan Risiko Tinggi

Rujukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan masa nifas, terutama bagi pasien yang mengalami komplikasi serius atau termasuk kelompok risiko tinggi. Masa nifas adalah periode transisi yang penuh dinamika, di mana beberapa kondisi dapat memburuk secara cepat dan memerlukan penanganan spesialis atau fasilitas kesehatan dengan sumber daya lebih lengkap. Dalam praktik kebidanan, kemampuan bidan untuk mengenali kondisi yang memerlukan rujukan, melaksanakan proses rujukan yang efektif, dan melakukan tindak lanjut setelah rujukan menjadi kunci untuk menjamin keselamatan dan kesembuhan ibu.

### 1. Kriteria Rujukan

Bidan harus mampu melakukan penilaian menyeluruh untuk mengenali tanda bahaya dan kondisi yang termasuk risiko tinggi. Beberapa kondisi utama yang wajib menjadi indikator rujukan meliputi:

- **Perdarahan hebat (Hemoragi Postpartum)**

Bila perdarahan tidak dapat dikendalikan dengan tindakan awal, atau jumlah darah yang hilang melebihi batas kritis, segera rujuk ke fasilitas yang dapat memberikan penanganan intensif seperti transfusi darah atau operasi.

- **Infeksi berat**

Infeksi postpartum yang menunjukkan tanda-tanda sistemik, seperti demam tinggi yang menetap, tanda sepsis, atau abses yang memerlukan intervensi bedah, harus segera dirujuk.

- **Tanda-tanda tromboemboli**

Gejala seperti pembengkakan tungkai dengan nyeri hebat, sesak napas akut, atau nyeri dada mendadak adalah kondisi emergensi yang memerlukan rujukan cepat.

- **Gangguan psikologis berat**

Depresi postpartum berat dengan pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bayi, psikosis postpartum, atau gangguan mental lain yang mengganggu fungsi sehari-hari harus mendapatkan evaluasi dan penanganan oleh tenaga kesehatan jiwa.

- **Penyakit kronis yang memburuk**

Kondisi seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung yang tidak terkontrol memerlukan pengawasan dan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan dengan fasilitas lengkap.

Penilaian risiko yang akurat meliputi pengumpulan data anamnesis, pemeriksaan fisik, serta penggunaan alat bantu screening sesuai protokol untuk memastikan keputusan rujukan tepat waktu dan tepat sasaran.



## 2. Prosedur Rujukan

Proses rujukan harus dijalankan secara jelas, sistematis, dan profesional agar memastikan kelancaran perpindahan pasien dan kesinambungan asuhan:

- **Komunikasi efektif dengan fasilitas rujukan**

Bidan harus menghubungi fasilitas kesehatan tujuan sebelum merujuk untuk menginformasikan kondisi pasien, menanyakan kesiapan fasilitas, dan mendapatkan persetujuan atau arahan lebih lanjut. Komunikasi ini harus mencakup data medis penting, diagnosa sementara, serta alasan rujukan.

- **Penyampaian data medis dan kondisi terkini ibu**

Dokumen rujukan harus lengkap, mencakup hasil pemeriksaan, terapi yang telah diberikan, riwayat kesehatan, dan catatan khusus yang penting untuk penanganan di fasilitas rujukan.

- **Koordinasi transportasi dan pendampingan**

Pengaturan transportasi yang aman dan cepat sangat penting untuk ibu dengan risiko tinggi. Pendampingan oleh tenaga kesehatan atau keluarga yang mengerti kondisi pasien juga diperlukan untuk mendukung keselamatan selama perjalanan.

- **Persiapan mental dan edukasi**

Berikan penjelasan kepada ibu dan keluarga mengenai alasan rujukan, proses yang akan dijalani, serta pentingnya tindakan tersebut untuk keselamatan ibu dan bayi. Hal ini membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepatuhan.

## 3. Tindak Lanjut Pasien Rujukan

Setelah rujukan dilakukan, peran bidan tidak berhenti begitu saja, melainkan berlanjut dalam memberikan pemantauan dan dukungan di tingkat komunitas atau fasilitas primer:

- **Pemantauan kondisi ibu di komunitas**

Bidan melakukan kunjungan lanjutan untuk memastikan kondisi ibu membaik, memonitor tanda-tanda vital, serta mendukung pemulihan secara menyeluruh.

- **Edukasi berkelanjutan**

Berikan edukasi terkait perawatan diri, pengobatan lanjutan, dan pencegahan komplikasi untuk mendukung proses kesembuhan dan mencegah kambuhnya masalah.

- **Koordinasi dengan fasilitas rujukan**

Bidan perlu menjalin komunikasi dua arah dengan fasilitas rujukan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ibu dan melakukan penyesuaian asuhan jika diperlukan.

- **Dukungan psikososial**

Lanjutkan pemberian dukungan emosional kepada ibu dan keluarga untuk mengatasi stres dan memfasilitasi adaptasi pascapersalinan yang sehat.

#### **4. Dokumentasi Rujukan**

Pendokumentasian seluruh proses rujukan harus dilakukan secara lengkap dan akurat. Hal ini meliputi pencatatan alasan rujukan, waktu dan jenis komunikasi dengan fasilitas rujukan, data medis yang disampaikan, serta respons fasilitas tujuan. Dokumentasi juga mencakup tindak lanjut setelah rujukan untuk memastikan kelangsungan asuhan dan evaluasi hasil pelayanan. Dokumentasi yang baik adalah dasar akuntabilitas profesional dan sangat berguna dalam audit mutu serta peningkatan kualitas layanan.

### **D. Pengembangan Kebijakan dan Program Kesehatan Maternal**

Peran bidan dalam pelayanan kesehatan maternal tidak hanya terbatas pada pemberian asuhan langsung kepada ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas, tetapi juga mencakup kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan yang berdampak luas pada kualitas dan cakupan pelayanan maternal secara nasional dan lokal. Bidan sebagai praktisi yang berinteraksi langsung dengan ibu dan keluarga memiliki wawasan yang sangat berharga untuk mendorong perubahan sistemik, memastikan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mengoptimalkan hasil kesehatan ibu dan bayi.

#### **1. Partisipasi dalam Perencanaan Program**

Bidan yang aktif di lapangan memiliki pengetahuan praktis tentang kebutuhan nyata ibu dan keluarga, termasuk tantangan, hambatan akses, dan kesenjangan pelayanan yang ada. Melalui partisipasi dalam perencanaan program kesehatan maternal, bidan dapat memberikan masukan berbasis bukti lapangan yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan penyusun program. Keterlibatan ini memastikan program yang dirancang relevan dengan kondisi lokal, tepat sasaran, dan memiliki strategi implementasi yang efektif. Selain itu, bidan dapat membantu melakukan evaluasi dan pemantauan program sehingga dapat dilakukan perbaikan berkelanjutan.

#### **2. Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman tertulis yang menjadi acuan pelaksanaan asuhan kebidanan masa nifas secara konsisten dan berbasis bukti. Bidan memiliki peran sentral dalam merancang SOP yang mengintegrasikan protokol klinis terbaru, standar keselamatan pasien, dan praktik terbaik. Proses pengembangan SOP meliputi analisis kebutuhan, kolaborasi lintas profesi, uji coba di lapangan, serta evaluasi efektivitasnya. Dengan SOP yang terstandarisasi, kualitas asuhan dapat terjaga, risiko kesalahan medis berkurang, dan pelayanan menjadi lebih efisien dan aman.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat dan Edukasi Publik**

Bidan juga aktif dalam program promotif dan preventif yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perawatan masa nifas dan kesehatan reproduksi. Melalui berbagai kegiatan edukasi seperti penyuluhan, pelatihan kader kesehatan, dan kampanye kesehatan, bidan berperan sebagai agen perubahan yang memberdayakan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kesehatan ibu dan keluarga. Materi edukasi mencakup pengenalan tanda bahaya komplikasi nifas, cara menjaga kebersihan, pola hidup sehat, dan pentingnya akses ke pelayanan kesehatan berkualitas. Pemberdayaan ini meningkatkan keterlibatan komunitas dan mendukung keberlanjutan program kesehatan maternal.

### **4. Advokasi Kesehatan Maternal**

Sebagai praktisi dan ahli di bidang kebidanan, bidan dapat menjadi advokat yang kuat untuk hak-hak ibu dan bayi dalam berbagai forum, baik di tingkat lokal maupun nasional. Advokasi ini meliputi peningkatan akses layanan kesehatan, penghapusan diskriminasi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan peningkatan sumber daya manusia kesehatan. Bidan berperan menyuarakan kebutuhan ibu hamil dan nifas, mengusulkan kebijakan yang pro-ibu, serta mempengaruhi pembuat keputusan agar kebijakan dan anggaran kesehatan memperhatikan prioritas kesehatan maternal. Advokasi efektif membutuhkan kemampuan komunikasi, kerja sama dengan berbagai stakeholder, dan pemahaman tentang kebijakan publik.

### **5. Pengembangan Kompetensi Profesional**

Pengembangan kompetensi adalah proses berkelanjutan yang krusial untuk menjaga kualitas pelayanan kebidanan. Bidan harus terus mengikuti pelatihan, workshop, seminar, dan pendidikan lanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan dan teknologi. Selain itu, bidan dapat terlibat dalam penelitian kebidanan yang bertujuan menghasilkan inovasi dan bukti baru dalam praktik klinis. Kolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga kesehatan meningkatkan kapasitas profesional dan memberikan kontribusi positif terhadap mutu pelayanan maternal yang lebih baik.

## E. Latihan Soal

### Tugas

---

#### Tugas 1

Uraikan secara mendalam bagaimana bidan dapat berkolaborasi dengan dokter spesialis kebidanan dalam menangani komplikasi masa nifas seperti hemoragi postpartum dan infeksi berat. Jelaskan juga manfaat komunikasi yang efektif dalam kolaborasi tersebut dan bagaimana bidan dapat memastikan implementasi rekomendasi dokter secara optimal.

#### Tugas 2

Anda adalah seorang bidan yang harus melakukan pendokumentasian asuhan nifas secara manual dan digital. Jelaskan langkah-langkah pendokumentasian yang harus dilakukan agar memenuhi standar kualitas dan legalitas, serta bagaimana Anda menjaga kerahasiaan dan privasi data pasien selama proses tersebut.

#### Tugas 3

Berikan contoh kasus seorang ibu nifas dengan risiko tinggi yang memerlukan rujukan. Jelaskan kriteria apa saja yang harus dipenuhi untuk melakukan rujukan, bagaimana prosedur rujukan yang benar, serta bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh bidan setelah pasien dirujuk.

#### Tugas 4

Jelaskan secara komprehensif peran bidan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan maternal di tingkat institusi kesehatan maupun komunitas. Sertakan pula bagaimana partisipasi bidan dalam penyusunan SOP dan pemberdayaan masyarakat dapat berdampak pada kualitas layanan kebidanan.

#### Tugas 5

Diskusikan pentingnya pelatihan dan pengembangan kompetensi profesional bagi bidan dalam meningkatkan mutu pelayanan masa nifas. Bagaimana bidan dapat berkontribusi dalam penelitian kebidanan dan kolaborasi lintas institusi untuk mendukung pengembangan kebijakan kesehatan maternal?

## Pilihan Ganda

---

1. Seorang ibu nifas mengalami hemoragi postpartum berat yang tidak kunjung berhenti setelah upaya awal penanganan di puskesmas. Bidan sudah memberikan uterotonik dan melakukan kompresi bimanual, tetapi perdarahan tetap ada. Apa langkah kolaborasi selanjutnya yang harus dilakukan bidan?
  - A. Menunggu hingga perdarahan berhenti secara spontan
  - B. Melakukan rujukan cepat ke dokter spesialis kebidanan di rumah sakit
  - C. Memberikan obat analgesik untuk mengurangi rasa nyeri
  - D. Meminta keluarga ibu untuk membawa ibu ke rumah sakit tanpa pengantar
  - E. Mengganti jenis uterotonik tanpa konsultasi
2. Dalam mendukung keberhasilan menyusui, bidan perlu berkolaborasi dengan konselor laktasi. Tanda-tanda apa yang harus dikenali bidan sebagai indikasi rujukan ke konselor laktasi?
  - A. Ibu mengalami kesulitan menyusui akibat pelekatan yang buruk
  - B. Ibu tidak mengalami nyeri saat menyusui
  - C. Bayi dapat menghisap ASI dengan normal
  - D. Ibu memiliki asupan gizi yang baik
  - E. Ibu menyusui dengan posisi yang nyaman
3. Seorang ibu nifas menunjukkan tanda-tanda depresi postpartum berat, termasuk perasaan putus asa dan pikiran menyakiti diri sendiri. Apa peran bidan dalam kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait kondisi ini?
  - A. Memberikan obat sendiri tanpa konsultasi
  - B. Mengabaikan karena depresi adalah hal wajar
  - C. Mengidentifikasi gejala, memberikan dukungan emosional, dan merujuk ke psikolog atau psikiater
  - D. Meminta keluarga mengawasi tanpa intervensi profesional
  - E. Mengurangi waktu kunjungan rumah karena kondisi ibu tidak stabil
4. Dalam pendokumentasian asuhan nifas, format SOAP sering digunakan. Apa yang dimaksud dengan bagian "Assessment" dalam format tersebut?
  - A. Data subjektif yang dilaporkan oleh pasien
  - B. Data objektif dari hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium
  - C. Analisis dan interpretasi dari data yang dikumpulkan
  - D. Rencana tindakan dan intervensi yang akan dilakukan
  - E. Catatan hasil edukasi kepada pasien

5. Bidan yang aktif berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan maternal dapat memberikan kontribusi melalui kegiatan berikut, kecuali:
- A. Memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan
  - B. Merancang dan mengevaluasi SOP asuhan nifas
  - C. Memberikan edukasi dan pemberdayaan masyarakat
  - D. Menghindari keterlibatan dalam perencanaan program karena bukan tugasnya
  - E. Melakukan advokasi untuk hak-hak ibu dan peningkatan akses layanan

### Kunci Jawaban

---

1. **Kunci Jawaban:** B

**Pembahasan:** Bila perdarahan PPH tidak dapat dikendalikan, bidan harus segera berkolaborasi dengan dokter spesialis dan melakukan rujukan cepat ke fasilitas yang memiliki kemampuan menangani kegawatdaruratan seperti transfusi darah dan operasi.

2. **Kunci Jawaban:** A

**Pembahasan:** Pelekatan yang buruk adalah tanda kesulitan menyusui yang memerlukan bantuan konselor laktasi agar ibu dapat mengatasi masalah dan meningkatkan keberhasilan menyusui.

3. **Kunci Jawaban:** C

**Pembahasan:** Bidan harus berperan aktif mengenali tanda depresi berat, memberikan dukungan dasar, dan melakukan rujukan ke tenaga kesehatan mental profesional untuk penanganan lebih lanjut.

4. **Kunci Jawaban:** C

**Pembahasan:** Assessment adalah bagian di mana tenaga kesehatan menganalisis dan menginterpretasikan data subjektif dan objektif untuk menentukan masalah dan diagnosis keperawatan.

5. **Kunci Jawaban:** D

**Pembahasan:** Bidan memiliki peran penting dalam pengembangan kebijakan dan program, sehingga menghindari keterlibatan bertentangan dengan perannya sebagai agen perubahan dalam kesehatan maternal.

## F. Rangkuman Materi

Kolaborasi antar tenaga kesehatan merupakan fondasi penting dalam memberikan pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas, khususnya pada masa nifas. Masa nifas sebagai periode transisi yang kompleks memerlukan perhatian medis, psikologis, dan sosial secara terpadu, di mana bidan berperan sebagai koordinator utama yang mampu menjalin kerja sama efektif dengan berbagai profesi kesehatan lain untuk memenuhi kebutuhan ibu secara holistik, meningkatkan hasil kesehatan, dan mencegah komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Dalam menghadapi komplikasi serius seperti hemoragi postpartum yang tidak terkontrol, infeksi berat, atau gangguan psikologis, kolaborasi erat antara bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan sangat diperlukan. Komunikasi efektif yang terjalin melalui konsultasi mendalam, pelaporan kondisi pasien secara akurat, serta pelaksanaan rekomendasi dokter secara tepat waktu memastikan penanganan medis optimal. Kolaborasi ini juga mencakup koordinasi rujukan, penanganan darurat, dan perencanaan asuhan lanjutan bagi pasien risiko tinggi, sehingga keputusan klinis dapat diambil secara cepat dan tepat berdasarkan bukti.

Selain itu, kerjasama bidan dengan konselor laktasi memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan menyusui pada masa nifas. Bidan wajib mengenali tanda-tanda kesulitan menyusui dan proaktif merujuk ibu ke konselor laktasi untuk mendapatkan bantuan khusus. Edukasi terpadu yang dilakukan bidan bersama konselor meningkatkan keberhasilan menyusui dan mengurangi risiko komplikasi seperti mastitis, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ibu. Sinergi dengan psikolog dan tenaga kesehatan mental juga sangat vital, karena ibu nifas rentan terhadap gangguan psikologis seperti depresi postpartum, kecemasan, dan stres. Bidan harus mampu mengidentifikasi gejala awal gangguan mental dan menjembatani penanganan bersama psikolog, termasuk melakukan rujukan dan tindak lanjut secara berkelanjutan serta memberikan dukungan psikososial dan edukasi pentingnya kesehatan mental pascapersalinan.

Kerjasama lintas profesi lainnya seperti dengan farmasis, nutrisisionis, dan tenaga sosial turut memperkuat asuhan nifas. Farmasis memastikan pemberian obat tepat, manajemen efek samping, dan edukasi penggunaan obat, sedangkan nutrisisionis membantu penyusunan program gizi untuk mendukung pemulihan dan produksi ASI ibu. Tenaga sosial memberikan dukungan sosial yang esensial, menghubungkan ibu dengan sumber daya komunitas, membantu keluarga memahami dinamika perawatan, dan mengatasi hambatan sosial-ekonomi yang dapat mempengaruhi proses pemulihan. Kolaborasi lintas profesi ini menjadikan asuhan nifas lebih komprehensif,

terpadu secara medis, nutrisi, psikologis, dan sosial sehingga kesehatan dan kesejahteraan ibu dapat terjaga secara menyeluruh.

Pendokumentasian asuhan masa nifas merupakan bagian esensial dalam praktik kebidanan dan layanan kesehatan secara umum. Dokumentasi yang akurat, lengkap, dan sistematis berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bukti tertulis mutu asuhan, legalitas tindakan, serta keberlangsungan pelayanan pasien. Kompleksitas perubahan fisik dan psikologis ibu pada masa nifas menuntut pendokumentasian yang menyeluruh, meliputi hasil pemeriksaan fisik, pengukuran tanda vital, intervensi keperawatan, edukasi dan konseling, serta respons ibu. Dokumentasi yang baik memudahkan asuhan lanjutan yang konsisten dan terintegrasi serta membantu dalam audit mutu dan perlindungan hukum tenaga kesehatan dan pasien. Standar dokumentasi mengikuti format yang telah ditetapkan institusi atau regulasi kesehatan seperti model SOAP, PIE, atau DAR dengan bahasa jelas dan akuntabel. Sistem rekam medis elektronik (RME) makin berkembang sebagai alternatif pendokumentasian digital yang mempermudah akses data, mengurangi risiko kesalahan dan mendukung telemedisin, meskipun catatan manual masih digunakan di beberapa tempat. Etika dan privasi data sangat dijaga dalam proses pendokumentasian dengan mematuhi kode etik dan regulasi perlindungan data, sehingga informasi pasien hanya diakses oleh pihak berwenang.

Rujukan dan tindak lanjut pasien dengan risiko tinggi menjadi aspek fundamental dalam pelayanan masa nifas, terutama bagi ibu dengan komplikasi serius atau kondisi yang dapat memburuk dengan cepat. Kemampuan bidan untuk mengenali tanda bahaya, menentukan kriteria rujukan seperti perdarahan hebat, infeksi berat, tanda tromboemboli, gangguan psikologis berat, dan penyakit kronis, sangat penting dalam menentukan waktu dan jenis rujukan. Proses rujukan dilakukan secara sistematis dengan komunikasi efektif antara bidan dan fasilitas rujukan, penyampaian data medis lengkap, koordinasi transportasi dan pendampingan, serta persiapan mental ibu dan keluarga. Setelah rujukan, bidan berperan dalam pemantauan kondisi ibu di komunitas, edukasi berkelanjutan, koordinasi komunikasi dua arah dengan fasilitas rujukan, serta memberikan dukungan psikososial untuk mendukung adaptasi dan pemulihan ibu. Pendokumentasian proses rujukan dilakukan secara lengkap sebagai bukti akuntabilitas dan untuk evaluasi mutu layanan.

Pengembangan kebijakan dan program kesehatan maternal merupakan bagian penting dari peran bidan yang tidak hanya fokus pada pelayanan langsung. Bidan berkontribusi dalam perencanaan program berdasarkan pengalaman lapangan, memberikan masukan mengenai kebutuhan ibu, hambatan akses, dan strategi



pelayanan yang efektif. Bidan juga terlibat dalam merancang dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memastikan kualitas asuhan yang aman dan berbasis bukti. Selain itu, bidan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perawatan nifas dan kesehatan reproduksi. Bidan juga menjadi advokat dalam berbagai forum untuk memperjuangkan hak ibu dan peningkatan akses layanan, serta mengusulkan kebijakan yang pro-ibu. Pengembangan kompetensi profesional bidan melalui pelatihan, seminar, dan penelitian kebidanan mendukung peningkatan mutu pelayanan maternal secara berkelanjutan dan efektif.

## G. Glosarium

**Advokasi Kesehatan:** Upaya untuk mempengaruhi kebijakan publik dan sistem kesehatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pasien dan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

**Asuhan Nifas:** Perawatan dan pendampingan yang diberikan kepada ibu selama masa nifas, yaitu periode setelah persalinan hingga tubuh ibu kembali ke kondisi sebelum kehamilan.

**Audit Mutu:** Proses evaluasi dan pengawasan untuk memastikan pelayanan kesehatan memenuhi standar kualitas dan meningkatkan mutu pelayanan.

**Bidan:** Tenaga kesehatan profesional yang memberikan pelayanan kebidanan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga kesehatan reproduksi wanita.

**Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan:** Dokter dengan spesialisasi dalam bidang kehamilan, persalinan, dan penyakit kandungan yang menangani kasus-kasus medis kompleks.

**Kolaborasi Antar Tenaga Kesehatan:** Kerja sama dan koordinasi yang efektif antara berbagai profesi kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan holistik.

**Konselor Laktasi:** Tenaga kesehatan atau ahli yang memberikan dukungan dan edukasi kepada ibu mengenai teknik menyusui dan masalah-masalah terkait ASI.

**Pendokumentasian:** Proses pencatatan secara sistematis mengenai asuhan yang diberikan kepada pasien, termasuk hasil pemeriksaan, tindakan, edukasi, dan respons pasien.

**Rekam Medis Elektronik (RME):** Sistem pencatatan data kesehatan pasien secara digital yang memudahkan penyimpanan, akses, dan koordinasi layanan.

**Rujukan:** Proses pemindahan tanggung jawab pelayanan pasien dari satu fasilitas atau tenaga kesehatan ke fasilitas atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kemampuan lebih lengkap.

**Standar Operasional Prosedur (SOP):** Pedoman tertulis yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan asuhan secara sistematis dan konsisten untuk memastikan mutu dan keselamatan pasien.

**Tindak Lanjut:** Serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pelayanan awal untuk memastikan keberlanjutan perawatan dan pemantauan kondisi pasien.

**Tenaga Kesehatan Mental:** Profesional kesehatan yang menangani masalah psikologis dan psikiatri, termasuk psikolog dan psikiater.

**Tenaga Sosial:** Tenaga yang memberikan dukungan sosial, membantu keluarga dan pasien dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada kesehatan.

**Tanda Vital:** Parameter dasar kesehatan yang meliputi tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan yang digunakan untuk memantau kondisi pasien.

## H. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Practice Bulletin No. 183: Postpartum Hemorrhage. *Obstetrics & Gynecology*, 130(4), e168–e186. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002238>
- Bohren, M. A., Hunter, E. C., Munthe-Kaas, H., Souza, J. P., Vogel, J. P., & Gülmezoglu, A. M. (2017). Facilitators and barriers to facility-based delivery in low- and middle-income countries: a qualitative evidence synthesis. *Reproductive Health*, 14(1), 71. <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0342-8>
- Dyson, L., McCormick, F. M., & Renfrew, M. J. (2013). Interventions for promoting the initiation of breastfeeding. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (7), CD001688. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD001688.pub3>
- Glasgow, N. J., & Kitchener, H. C. (2020). Multidisciplinary collaboration in mental health care. *Advances in Psychiatric Treatment*, 26(1), 18–25. <https://doi.org/10.1192/apt.2019.010>
- Hussein, J., Kanguru, L., Astin, M., & Munjanja, S. (2012). The effectiveness of emergency obstetric referral interventions in developing countries: a systematic review. *PLoS Medicine*, 9(7), e1001264. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001264>
- Khan, K. S., Wojdyla, D., Say, L., Gülmezoglu, A. M., & Van Look, P. F. A. (2006). WHO analysis of causes of maternal death: a systematic review. *The Lancet*, 367(9516), 1066–1074. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)68397-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68397-9)
- Lehmann, U., & Gilson, L. (2013). Action learning for health system governance: the need to embrace complexity. *Health Policy and Planning*, 28(6), 565–568. <https://doi.org/10.1093/heapol/czs103>

- Mander, R. (2017). Documentation and record keeping in nursing practice. *British Journal of Nursing*, 26(21), 1200-1204. <https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.21.1200>
- McLellan, J., & Lee, A. (2017). Improving clinical documentation in healthcare. *Nursing Times*, 113(12), 24-27.
- Muller, M., & Dreyer, G. (2017). Enhancing the role of the nurse in maternal mental health care. *International Journal of Nursing Practice*, 23(6), e12503. <https://doi.org/10.1111/ijn.12503>
- World Health Organization. (2018). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2019). WHO recommendations on health promotion interventions for maternal and newborn health. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2020). WHO recommendations on digital health interventions for health system strengthening. Geneva: WHO.
- Yuen, H. K., Tully, K. P., & Stuebe, A. (2014). A review of breastfeeding interventions to improve postpartum depression. *Archives of Women's Mental Health*, 17(5), 387-397. <https://doi.org/10.1007/s00737-014-0423-7>
- Zwart, J. J., Richters, J., Ory, F., De Vries, J. I., & Bloemenkamp, K. W. (2009). Severe maternal morbidity during pregnancy, delivery and puerperium in the Netherlands: a nationwide population-based study of 371,000 pregnancies. *British Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 116(9), 453-461. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2009.02173.x>

# Bab 8

## Aspek Etik, Legal, dan Budaya dalam Asuhan Nifas

Masa nifas merupakan periode penting bagi pemulihan fisik dan psikologis ibu setelah persalinan. Dalam memberikan asuhan pada masa ini, tenaga kesehatan, khususnya bidan, harus mengedepankan aspek etik, legal, dan budaya untuk memastikan pelayanan yang aman, bermartabat, dan menghormati hak ibu. Aspek etik menuntut tenaga kesehatan bertindak sesuai dengan prinsip moral dan kode etik profesi. Aspek legal mengatur hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi ibu dan tenaga kesehatan. Sementara itu, penghormatan terhadap budaya lokal menjadi bagian penting agar pelayanan dapat diterima dan efektif sesuai konteks sosial masyarakat. Pemahaman yang mendalam mengenai hak ibu nifas, privasi dan kerahasiaan, serta etika dalam edukasi dan konseling merupakan fondasi penting untuk praktik kebidanan yang profesional dan humanis.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etik, legal, dan budaya dalam asuhan nifas untuk memberikan pelayanan yang bermutu, menghargai hak ibu, serta menjaga privasi dan kerahasiaan pasien sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada bab ini, mahasiswa dapat secara tepat menjelaskan dan menerapkan aspek-aspek hak ibu nifas, penghormatan terhadap kepercayaan dan budaya lokal, prinsip privasi dan kerahasiaan pasien, serta etika dalam edukasi dan konseling yang relevan dalam praktik asuhan nifas.

### Sub-CPMK

Berikut rincian capaian pembelajaran khusus yang diharapkan:

1. Menjelaskan hak ibu nifas dalam pelayanan kesehatan sesuai prinsip etik dan hukum.
2. Mengidentifikasi dan menghormati kepercayaan serta budaya lokal yang terkait dengan masa nifas.
3. Menjelaskan pentingnya menjaga privasi dan kerahasiaan pasien dalam asuhan nifas.
4. Menerapkan etika komunikasi dalam edukasi dan konseling selama masa nifas.

## A. Hak Ibu Nifas dalam Pelayanan Kesehatan

Hak ibu nifas merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dihormati oleh setiap tenaga kesehatan selama memberikan pelayanan. Masa nifas adalah fase yang rentan, dimana ibu memerlukan perhatian khusus secara fisik, psikologis, dan sosial. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap hak ibu selama masa ini tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang diatur oleh perundang-undangan di bidang kesehatan.

Beberapa hak utama ibu nifas yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan antara lain:

- **Hak Mendapatkan Pelayanan yang Aman dan Berkualitas:** Ibu nifas berhak menerima asuhan yang memenuhi standar profesi, meminimalkan risiko komplikasi, dan memprioritaskan keselamatan serta kenyamanan ibu. Tenaga kesehatan harus kompeten dan berperilaku profesional dalam melakukan tindakan medis maupun keperawatan.
- **Hak Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Lengkap:** Ibu nifas berhak memperoleh penjelasan tentang kondisi kesehatannya, tindakan atau prosedur yang akan dilakukan, serta potensi risiko dan manfaatnya. Informasi harus diberikan secara komunikatif dan mudah dimengerti, sehingga ibu dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab (prinsip informed consent).
- **Hak Membuat Keputusan atas Pelayanannya Sendiri:** Setelah memperoleh informasi lengkap, ibu nifas memiliki hak untuk menerima atau menolak tindakan medis atau perawatan tertentu tanpa paksaan. Tenaga kesehatan harus menghormati keputusan tersebut dan mencari solusi terbaik secara bersama.
- **Hak atas Perlindungan Privasi dan Kerahasiaan:** Informasi medis dan pribadi ibu harus dijaga kerahasiaannya. Pengungkapan informasi hanya boleh dilakukan dengan izin ibu atau sesuai ketentuan hukum.
- **Hak Mendapatkan Dukungan Emosional dan Sosial:** Masa nifas seringkali diwarnai perubahan hormonal dan psikologis yang memerlukan dukungan moral dari tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan. Dukungan ini penting agar ibu dapat menjalani proses pemulihan secara optimal dan mencegah gangguan mental seperti depresi postpartum.
- **Hak Mendapatkan Perlindungan Hukum:** Jika terjadi malapraktik atau pelanggaran hak selama asuhan nifas, ibu berhak mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke mekanisme pengaduan yang adil dan transparan.

Penghormatan terhadap hak ibu nifas secara menyeluruh akan meningkatkan kepercayaan ibu kepada tenaga kesehatan, memperbaiki kepatuhan terhadap pengobatan, serta mendorong hasil kesehatan yang lebih baik. Oleh karena itu, tenaga

kesehatan harus selalu menyadari dan menerapkan prinsip-prinsip hak pasien dalam praktik sehari-hari.

## **B. Penghormatan terhadap Kepercayaan dan Budaya Lokal terkait Nifas**

Setiap komunitas atau suku bangsa memiliki kepercayaan dan budaya unik yang memengaruhi cara mereka menjalani masa nifas. Praktik budaya ini sering kali berkaitan dengan kepercayaan spiritual, tradisi keluarga, atau norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Misalnya, beberapa masyarakat menerapkan larangan aktivitas fisik tertentu, pengaturan pola makan khusus, ritual penyucian, atau aturan kunjungan selama masa nifas.

Penghormatan terhadap kepercayaan dan budaya lokal dalam asuhan nifas memiliki beberapa alasan penting:

- **Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Asuhan:** Bila tenaga kesehatan menghormati nilai dan kebiasaan lokal, ibu dan keluarganya cenderung lebih menerima intervensi medis dan lebih kooperatif selama perawatan.
- **Menghindari Konflik dan Ketegangan:** Penolakan atau sikap tidak menghargai budaya lokal dapat menimbulkan ketegangan, menurunkan kepercayaan, bahkan membuat ibu enggan berkunjung ke fasilitas kesehatan.
- **Menjaga Martabat dan Identitas Sosial:** Budaya merupakan bagian dari identitas seseorang. Menghormatinya membantu menjaga martabat ibu dan memperkuat hubungan baik antara tenaga kesehatan dan pasien.

Namun, ada kalanya praktik budaya bertentangan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan, misalnya tradisi penggunaan ramuan berbahaya atau penolakan terhadap pengobatan tertentu. Dalam hal ini, bidan perlu melakukan:

- **Pendekatan Komunikasi Sensitif Budaya:** Mendengarkan secara empatik, menghargai pandangan ibu, dan menjelaskan risiko serta manfaat intervensi medis dengan bahasa yang mudah dipahami dan tanpa menghakimi.
- **Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat atau Pemuka Adat:** Melibatkan tokoh budaya atau agama dapat membantu menyampaikan edukasi yang diterima secara lebih luas dan mengurangi resistensi.
- **Penyesuaian Asuhan yang Fleksibel:** Bila memungkinkan, tenaga kesehatan dapat mengakomodasi praktik budaya yang tidak membahayakan, sehingga asuhan menjadi lebih holistik dan kontekstual.

Dengan demikian, penghormatan terhadap budaya lokal bukan berarti mengabaikan aspek ilmiah kesehatan, melainkan mengintegrasikan keduanya demi pelayanan yang aman, bermutu, dan diterima oleh ibu nifas.

## C. Privasi dan Kerahasiaan Pasien

Privasi dan kerahasiaan adalah aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat dan hak individu. Pada masa nifas, ibu seringkali mengalami kondisi fisik dan psikologis yang rentan, sehingga perlindungan privasi menjadi sangat krusial.

- **Privasi** mengacu pada hak pasien untuk dilindungi dari pengungkapan yang tidak diinginkan atas informasi pribadi maupun pengawasan fisik yang tidak perlu. Misalnya, ibu nifas berhak untuk mendapat ruang pemeriksaan yang tertutup dan tidak diperlihatkan kepada orang lain yang tidak berkepentingan.
- **Kerahasiaan** berkaitan dengan kewajiban tenaga kesehatan menjaga informasi kesehatan dan pribadi pasien agar tidak tersebar tanpa izin. Informasi medis harus disimpan dengan aman dan hanya boleh diakses oleh tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam perawatan.

Pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan dapat menimbulkan konsekuensi serius, seperti:

- **Kehilangan Kepercayaan:** Ibu nifas mungkin menjadi enggan berbagi informasi penting yang dapat memengaruhi diagnosis dan perawatan.
- **Stigma dan Diskriminasi:** Informasi yang bocor dapat menimbulkan penilaian negatif atau perlakuan tidak adil dari keluarga dan masyarakat.
- **Konsekuensi Hukum:** Tenaga kesehatan dapat dikenakan sanksi hukum dan etika profesi atas pelanggaran privasi pasien.

Untuk menjaga privasi dan kerahasiaan dalam praktik, tenaga kesehatan harus:

- Menyediakan ruang pemeriksaan yang aman dan privat.
- Membatasi akses data pasien hanya untuk pihak yang berwenang.
- Memastikan pembicaraan mengenai kondisi pasien dilakukan secara tertutup.
- Menggunakan sistem penyimpanan data yang aman dan terpercaya.
- Meminta persetujuan tertulis jika ada kebutuhan berbagi informasi dengan pihak lain.

Penerapan prinsip privasi dan kerahasiaan yang konsisten merupakan wujud profesionalisme dan penghormatan terhadap hak ibu nifas.



## D. Etika dalam Edukasi dan Konseling Nifas

Edukasi dan konseling merupakan komponen penting dalam asuhan nifas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ibu dalam merawat dirinya dan bayi setelah persalinan. Pelaksanaan edukasi dan konseling harus berdasarkan prinsip-prinsip etik yang menjamin kualitas interaksi dan penghormatan terhadap hak ibu.

Prinsip etika yang harus diterapkan dalam edukasi dan konseling meliputi:

- **Kejujuran dan Transparansi:** Memberikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipercaya, tanpa menutup-nutupi fakta yang penting.
- **Penghormatan terhadap Otonomi:** Menghargai keputusan ibu, tidak memaksa, dan mendukung ibu untuk membuat pilihan berdasarkan pemahaman yang baik.
- **Kerahasiaan:** Menjaga semua informasi yang dibagikan selama sesi konseling tetap rahasia.
- **Empati dan Sensitivitas:** Memahami kondisi psikologis dan latar belakang budaya ibu, memberikan dukungan moral yang positif, serta bersikap sabar dan penuh pengertian.
- **Keadilan:** Memberikan layanan edukasi yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, atau budaya.

Dalam praktiknya, tenaga kesehatan harus menyesuaikan metode komunikasi dengan kemampuan dan kebutuhan ibu. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami, alat bantu visual, dan pendekatan interaktif akan meningkatkan efektivitas edukasi. Selain itu, sesi konseling juga harus memberi ruang bagi ibu untuk bertanya dan menyampaikan kekhawatiran secara terbuka.

Dengan menerapkan etika dalam edukasi dan konseling, diharapkan ibu nifas dapat memperoleh pengetahuan yang cukup untuk mengelola kesehatan diri dan bayinya secara mandiri, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendorong keberhasilan pemulihan.



## E. Latihan Soal

### Tugas

---

#### Tugas 1:

##### Deskripsi:

Baca dan analisis studi kasus berikut: Seorang ibu nifas mengeluhkan kurangnya informasi yang diberikan tenaga kesehatan mengenai tanda bahaya setelah persalinan. Ia merasa keputusan perawatan yang diambil tanpa persetujuannya dan merasa kurang dihormati privasinya selama pemeriksaan.

##### Tugas:

- Identifikasi hak-hak ibu nifas yang dilanggar dalam kasus tersebut.
- Jelaskan bagaimana tenaga kesehatan seharusnya memenuhi hak ibu sesuai standar etik dan legal.
- Buat rekomendasi tindakan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki pelayanan tersebut.

#### Tugas 2:

##### Deskripsi:

Tuliskan esai minimal 500 kata yang membahas:

- Pentingnya menghormati kepercayaan dan budaya lokal dalam pelayanan nifas.
- Contoh praktik budaya yang umum dan bagaimana tenaga kesehatan dapat mengakomodasi atau mengedukasi tanpa menimbulkan konflik.
- Strategi komunikasi sensitif budaya yang efektif dalam konteks asuhan nifas.

#### Tugas 3:

##### Deskripsi:

Dalam kelompok kecil, lakukan simulasi peran dengan skenario: seorang ibu nifas sedang menjalani pemeriksaan, namun ada keluarga yang ingin masuk dan mendengarkan pembicaraan medis.

##### Tugas:

- Demonstrasikan cara tenaga kesehatan menjaga privasi dan kerahasiaan pasien dalam situasi tersebut.
- Buat skrip singkat tentang dialog yang menunjukkan penerapan prinsip privasi dan kerahasiaan.
- Refleksikan tantangan dan solusi dalam menjaga privasi di lingkungan pelayanan yang terbatas.

#### **Tugas 4:**

##### **Deskripsi:**

Buat modul edukasi singkat (bisa berupa presentasi atau leaflet) yang berisi materi edukasi dan konseling untuk ibu nifas dengan memperhatikan aspek etika, seperti: kejujuran, otonomi, empati, dan keadilan.

##### **Tugas:**

- Sertakan contoh bahasa yang digunakan agar edukasi dapat diterima dan dipahami ibu.
- Jelaskan bagaimana modul ini mengakomodasi kebutuhan psikologis dan budaya ibu.
- Berikan contoh pertanyaan terbuka yang dapat digunakan tenaga kesehatan untuk mengajak ibu berdiskusi selama konseling.

#### **Tugas 5:**

##### **Deskripsi:**

Tuliskan refleksi pribadi minimal 300 kata mengenai pengalaman atau pemahaman Anda tentang pentingnya aspek etik, legal, dan budaya dalam praktik asuhan nifas. Sertakan:

- Tantangan yang mungkin dihadapi tenaga kesehatan dalam menerapkan aspek-aspek tersebut.
- Upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut demi memberikan pelayanan yang berkualitas dan manusiawi.
- Bagaimana refleksi ini memengaruhi sikap dan perilaku Anda sebagai calon tenaga kesehatan.

#### **Pilihan Ganda**

---

1. Seorang ibu nifas hari ke-3 datang ke klinik dengan keluhan merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang tanda bahaya masa nifas. Selama pemeriksaan, ibu juga menyatakan bahwa keputusan pengobatan dilakukan tanpa persetujuannya, dan ruang pemeriksaan tidak tertutup sehingga percakapan antara dokter dan ibu dapat didengar oleh anggota keluarga lain.

Apa hak ibu nifas yang paling jelas dilanggar dalam kasus ini?

- A. Hak atas pelayanan medis tanpa diskriminasi
- B. Hak atas informasi yang jelas dan *informed consent*
- C. Hak mendapatkan dukungan sosial
- D. Hak atas privasi dan kerahasiaan pasien
- E. Hak atas perlindungan hukum

2. Dalam suatu wilayah, terdapat tradisi masa nifas yang melarang ibu melakukan aktivitas fisik apapun selama 40 hari dan hanya mengonsumsi makanan tertentu. Bidan menghadapi ibu yang ingin mengikuti tradisi tersebut namun khawatir efek negatifnya bagi kesehatan. Sikap bidan yang paling tepat adalah:
  - A. Melarang keras dan menegaskan bahwa tradisi berbahaya
  - B. Memaksa ibu mengikuti anjuran medis tanpa kompromi
  - C. Mendengarkan dan menghormati budaya, lalu menjelaskan risiko dengan bahasa mudah
  - D. Mengabaikan tradisi karena tidak ilmiah dan tetap melakukan perawatan standar
  - E. Minta keluarga ibu untuk membujuk agar tradisi ditinggalkan
3. Seorang ibu nifas meminta agar hasil pemeriksaan kesehatan dan informasi pribadinya tidak dibagikan kepada siapapun, termasuk keluarga dekat. Tenaga kesehatan sebaiknya:
  - A. Menolak permintaan ibu karena keluarga harus diberi tahu
  - B. Menghormati permintaan ibu dan menjaga kerahasiaan informasi
  - C. Memberikan informasi kepada keluarga karena demi kebaikan ibu
  - D. Membagikan informasi secara terbatas sesuai kebutuhan keluarga
  - E. Memberi tahu pihak ketiga hanya jika terjadi keadaan darurat
4. Dalam sesi konseling nifas, seorang ibu tampak ragu menerima saran pemberian ASI eksklusif karena keluarga menganut tradisi memberi tambahan air kelapa. Pendekatan etis bidan yang paling tepat adalah:
  - A. Menegaskan bahwa hanya ASI eksklusif yang benar dan menolak tradisi keluarga
  - B. Mengabaikan kekhawatiran ibu dan langsung melanjutkan edukasi
  - C. Memberikan informasi lengkap dan jujur, menghormati keputusan ibu, serta menawarkan solusi bersama
  - D. Membiarkan ibu mengikuti tradisi tanpa diskusi agar tidak terjadi konflik
  - E. Meminta tokoh adat mengintervensi agar ibu setuju dengan saran medis
5. Seorang ibu nifas merasa cemas dan takut saat menjalani pemeriksaan karena ruangnya terbuka dan banyak orang lalu-lalang. Ia merasa tidak nyaman dan malu. Apa yang harus menjadi prioritas tenaga kesehatan terkait hak ibu?
  - A. Menyelesaikan pemeriksaan secepat mungkin tanpa menghiraukan keluhan
  - B. Memindahkan ibu ke ruang privat yang tertutup dan menjaga privasinya
  - C. Meminta keluarga menunggu di luar ruangan tanpa menjelaskan
  - D. Meminta ibu beradaptasi dengan kondisi yang ada agar pelayanan lancar
  - E. Menjelaskan bahwa fasilitas terbatas dan ibu harus maklum

1. Jawaban: B

Pembahasan: Keluhan utama ibu adalah kurangnya informasi tentang kondisi dan tindakan medis yang dilakukan tanpa persetujuan, yang merupakan pelanggaran paling mendasar terhadap hak atas informasi dan informed consent. Hak ini mencakup hak pasien untuk:

- Mendapat penjelasan yang lengkap dan mudah dipahami tentang kondisi kesehatan dan pilihan tindakan medis.
- Memberikan persetujuan secara sadar (informed) sebelum tindakan dilakukan.

Meski ada pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan (opsi D), hal itu merupakan masalah tambahan. Fokus utama dan pelanggaran paling serius dalam skenario ini adalah tidak dipenuhinya hak ibu terhadap informasi dan persetujuan medis, sehingga jawaban paling tepat adalah B.

2. Jawaban: C

Pembahasan: Pendekatan sensitif budaya sangat penting (opsi C). Bidan harus menghargai kepercayaan ibu dan keluarganya serta menjelaskan risiko medis secara komunikatif tanpa memaksakan. Melarang atau memaksa dapat menimbulkan resistensi dan merusak hubungan. Kolaborasi dan edukasi adalah kunci keberhasilan.

3. Jawaban: B

Pembahasan: Hak privasi dan kerahasiaan pasien harus dihormati (opsi B). Informasi hanya boleh dibagikan dengan persetujuan pasien kecuali dalam kondisi tertentu yang mengancam keselamatan. Menghormati permintaan ibu menjaga kepercayaan dan profesionalisme tenaga kesehatan.

4. Jawaban: C

Pembahasan: Dalam edukasi dan konseling, prinsip kejujuran, penghormatan otonomi, dan empati harus diterapkan (opsi C). Memberi informasi lengkap dan mendukung keputusan ibu adalah etika profesional. Memaksa atau mengabaikan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan menurunkan keberhasilan intervensi.

5. Jawaban: B

Pembahasan: Menjaga privasi dan kenyamanan ibu adalah bagian dari hak dasar pasien (opsi B). Ruang pemeriksaan harus memadai agar ibu merasa aman secara fisik dan psikologis. Ini meningkatkan kepercayaan dan kualitas asuhan.

## F. Rangkuman Materi

Hak ibu nifas adalah hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati oleh tenaga kesehatan selama memberikan pelayanan, terutama pada masa nifas yang merupakan fase rentan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Penghormatan hak ini bukan hanya kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum yang diatur dalam perundang-undangan kesehatan. Ibu nifas berhak mendapatkan pelayanan yang aman dan berkualitas sesuai standar profesi, yang memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan ibu. Selain itu, ibu berhak memperoleh informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya, tindakan medis yang akan dilakukan, termasuk risiko dan manfaatnya, sehingga dapat membuat keputusan yang sadar dan bertanggung jawab berdasarkan prinsip informed consent. Hak ibu juga meliputi kebebasan untuk menerima atau menolak tindakan medis tanpa adanya paksaan dari tenaga kesehatan, serta hak atas perlindungan privasi dan kerahasiaan informasi medis pribadi yang hanya boleh diakses dengan izin ibu atau sesuai ketentuan hukum. Selama masa nifas, dukungan emosional dan sosial sangat penting mengingat perubahan hormonal dan psikologis yang terjadi, sehingga ibu berhak mendapat dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan untuk mencegah gangguan mental seperti depresi postpartum. Dalam hal terjadi pelanggaran hak atau malapraktik, ibu nifas berhak mendapatkan perlindungan hukum serta akses ke mekanisme pengaduan yang adil dan transparan. Pelaksanaan penghormatan hak secara menyeluruh akan memperkuat kepercayaan ibu kepada tenaga kesehatan, memperbaiki kepatuhan terhadap pengobatan, dan mendorong hasil kesehatan yang optimal.

Setiap komunitas atau suku bangsa memiliki kepercayaan dan budaya yang unik yang memengaruhi praktik masa nifas, seperti larangan aktivitas fisik, pengaturan pola makan, atau ritual penyucian yang diwariskan secara turun-temurun. Penghormatan terhadap nilai dan kebiasaan budaya ini sangat penting untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan ibu serta menghindari konflik atau ketegangan yang dapat menurunkan kepercayaan dan membuat ibu enggan mengakses fasilitas kesehatan. Budaya merupakan bagian dari identitas sosial yang perlu dijaga martabatnya agar hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien tetap harmonis. Namun, jika praktik budaya bertentangan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan, tenaga kesehatan harus menggunakan pendekatan komunikasi sensitif budaya dengan mendengarkan secara empatik dan menghargai pandangan ibu, sekaligus menjelaskan risiko dan manfaat intervensi medis secara mudah dipahami tanpa menghakimi. Melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka adat dapat membantu menyampaikan edukasi yang diterima secara luas serta mengurangi resistensi. Penyesuaian asuhan yang fleksibel

dan holistik dapat mengakomodasi praktik budaya yang tidak membahayakan, sehingga pelayanan menjadi bermutu dan diterima ibu.

Privasi dan kerahasiaan merupakan aspek fundamental dalam pelayanan kesehatan yang merefleksikan penghormatan terhadap martabat dan hak individu. Pada masa nifas, kondisi fisik dan psikologis ibu yang rentan menuntut perlindungan privasi yang ketat agar informasi pribadi dan medis tidak terungkap tanpa izin. Privasi berarti melindungi pasien dari pengungkapan informasi yang tidak diinginkan dan pengawasan fisik yang tidak perlu, misalnya dengan menyediakan ruang pemeriksaan tertutup dan terjaga. Kerahasiaan berarti tenaga kesehatan berkewajiban menyimpan dan menjaga informasi pasien dengan aman, hanya boleh diakses oleh yang berkepentingan langsung. Pelanggaran terhadap privasi dan kerahasiaan dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan, stigma sosial, diskriminasi, bahkan berimplikasi hukum bagi tenaga kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memastikan pembicaraan medis dilakukan secara tertutup, membatasi akses data, menggunakan sistem penyimpanan aman, dan meminta persetujuan tertulis jika berbagi informasi diperlukan. Konsistensi dalam menerapkan prinsip ini adalah wujud profesionalisme dan penghormatan hak ibu nifas.

Edukasi dan konseling adalah bagian esensial dalam asuhan nifas untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan ibu dalam merawat diri dan bayi. Pelaksanaan edukasi dan konseling harus didasarkan pada prinsip etika yang menjamin kualitas interaksi dan menghormati hak ibu. Prinsip-prinsip ini meliputi kejujuran dan transparansi dalam memberikan informasi yang benar dan lengkap tanpa menutupi fakta penting; penghormatan terhadap otonomi ibu dengan tidak memaksa dan mendukung pilihan ibu; menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama konseling; empati dan sensitivitas terhadap kondisi psikologis dan latar belakang budaya ibu; serta keadilan dalam memberikan layanan tanpa diskriminasi apapun. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan harus menyesuaikan metode komunikasi agar mudah dipahami dan sesuai dengan kemampuan ibu, menggunakan alat bantu visual dan pendekatan interaktif, serta menyediakan ruang bagi ibu untuk bertanya dan menyampaikan kekhawatiran secara terbuka. Dengan menerapkan etika dalam edukasi dan konseling, diharapkan ibu dapat memperoleh pengetahuan yang cukup untuk mandiri mengelola kesehatan diri dan bayinya, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendukung proses pemulihan yang sukses.

## G. Glosarium

**Alat Bantu Visual:** Media seperti gambar atau video yang digunakan untuk membantu menjelaskan informasi kesehatan agar mudah dipahami.

**Asuhan Holistik dan Kontekstual:** Pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan aspek medis dengan kebutuhan budaya dan sosial pasien secara menyeluruh.

**Dukungan Emosional dan Sosial:** Bantuan moral yang diberikan oleh tenaga kesehatan, keluarga, dan lingkungan untuk mendukung proses pemulihan ibu secara psikologis dan sosial.

**Empati:** Kemampuan memahami dan merasakan perasaan serta kondisi psikologis pasien.

**Etika dalam Edukasi dan Konseling:** Prinsip moral yang menuntut kejujuran, penghormatan otonomi, kerahasiaan, empati, sensitivitas budaya, dan keadilan dalam memberikan informasi dan dukungan kepada pasien.

**Informed Consent (Persetujuan Berdasarkan Informasi):** Hak pasien untuk menerima informasi lengkap tentang kondisi kesehatan dan prosedur medis sehingga dapat membuat keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

**Keadilan dalam Pelayanan Kesehatan:** Memberikan layanan yang setara tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, budaya, agama, atau latar belakang lain.

**Kepercayaan dan Budaya Lokal:** Nilai, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dalam suatu komunitas yang memengaruhi cara menjalani masa nifas.

**Kerahasiaan:** Kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga informasi medis pasien agar tidak tersebar kepada pihak yang tidak berwenang.

**Hak Ibu Nifas:** Hak-hak dasar yang dimiliki ibu pada masa nifas yang meliputi hak atas pelayanan yang aman dan berkualitas, informasi yang jelas, keputusan atas pelayanannya, privasi dan kerahasiaan, dukungan emosional, serta perlindungan hukum.

**Masa Nifas:** Periode setelah persalinan dimana tubuh ibu mengalami pemulihan secara fisik, psikologis, dan sosial.

**Pelayanan Kesehatan Aman dan Berkualitas:** Pelayanan yang memenuhi standar profesi kesehatan, mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien, serta meminimalkan risiko komplikasi.

**Privasi:** Hak pasien untuk dilindungi dari pengungkapan informasi pribadi tanpa izin dan dari pengawasan fisik yang tidak perlu.

**Perlindungan Hukum:** Jaminan hukum terhadap pasien terkait malapraktik atau pelanggaran hak dalam pelayanan kesehatan.

**Pendekatan Komunikasi Sensitif Budaya:** Cara berkomunikasi yang menghargai dan memahami nilai-nilai budaya pasien serta menjelaskan intervensi medis secara empatik dan tidak menghakimi.

**Tokoh Masyarakat atau Pemuka Adat:** Orang yang dihormati dalam komunitas yang dapat membantu menjembatani edukasi kesehatan dan tradisi budaya.

## H. Daftar Pustaka

- American College of Nurse-Midwives. (2017). *ACNM Core Competencies for Basic Midwifery Practice*. ACNM.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Chamberlain, G., & Porter, R. (2020). *Midwifery: Preparation for Practice* (3rd ed.). Elsevier.
- Davis-Floyd, R. (2020). *Birth as an American Rite of Passage* (2nd ed.). University of California Press.
- Davis, M. M., & Greene, M. (2021). *Maternal and Child Health Nursing: Care of the Childbearing and Childrearing Family* (8th ed.). Wolters Kluwer.
- Edwards, N., & Evans, J. (2019). Cultural competence in maternal healthcare: Embracing diversity for improved outcomes. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 64(3), 245-252. <https://doi.org/10.1111/jmwh.12937>
- Fouquier, K., & Stern, D. T. (2021). Privacy and confidentiality in maternity care. In M. Ryan & K. Mortimer (Eds.), *Ethics in Obstetrics and Gynecology* (pp. 145-160). Springer.
- Jenkins, B., & Othman, M. (2020). Respecting cultural beliefs in maternal care: A framework for health workers. *Global Health Action*, 13(1), 1709823. <https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1709823>
- Kirkham, M. (2019). *The Midwife-Mother Relationship* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on maternal health: Guidelines on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO Press. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/250796>
- Yelland, J., Riggs, E., & Szwarc, J. (2017). Promoting respectful maternity care in culturally diverse settings. *Midwifery*, 44, 38-44. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2016.10.009>



# Bab 9

## Evaluasi dan Dokumentasi Asuhan Nifas

Masa nifas merupakan periode penting pasca-persalinan dimana tubuh ibu mengalami proses pemulihan fisik dan psikologis. Evaluasi hasil asuhan kebidanan selama masa nifas sangat penting untuk memastikan pemulihan optimal dan mencegah komplikasi. Dokumentasi yang lengkap dan sistematis selama dan setelah masa nifas adalah bagian integral dari praktik kebidanan profesional yang menjamin komunikasi efektif antar tenaga kesehatan serta menjadi bukti tertulis untuk akuntabilitas pelayanan. Selain itu, penggunaan alat ukur dan instrumen evaluasi membantu mendapatkan data objektif sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami pentingnya evaluasi hasil asuhan kebidanan pada masa nifas untuk menjamin keselamatan dan kesehatan ibu.
2. Menguasai prinsip dan teknik dokumentasi yang lengkap dan sistematis selama dan setelah masa nifas.
3. Mengaplikasikan penggunaan alat ukur dan instrumen evaluasi dalam monitoring kondisi ibu nifas secara tepat dan efektif.
4. Mengintegrasikan hasil evaluasi dan dokumentasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam praktik kebidanan.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil asuhan kebidanan pada ibu masa nifas yang mencakup aspek fisiologis, psikologis, dan sosial.
2. Menyusun dokumentasi asuhan nifas yang lengkap, sistematis, dan sesuai standar profesi kebidanan.
3. Mengidentifikasi dan menggunakan alat ukur serta instrumen evaluasi yang tepat untuk memonitor kondisi ibu selama masa nifas.
4. Menyajikan laporan evaluasi dan dokumentasi asuhan nifas secara profesional dan komunikatif kepada tim kesehatan.

### **Sub-CPMK**

1. Mengidentifikasi parameter evaluasi hasil asuhan kebidanan pada masa nifas.  
Mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan aspek yang harus dievaluasi selama dan setelah masa nifas.
2. Melaksanakan evaluasi hasil asuhan kebidanan berdasarkan data objektif dan subyektif.  
Mahasiswa dapat melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pemeriksaan fisik, wawancara, dan observasi kondisi ibu.
3. Mengaplikasikan teknik dokumentasi yang benar sesuai standar profesi.  
Mahasiswa mampu membuat catatan asuhan yang sistematis, lengkap, dan mudah dipahami oleh tenaga kesehatan lain.
4. Memilih dan menggunakan alat ukur yang sesuai dalam evaluasi kondisi ibu nifas.  
Mahasiswa dapat menggunakan tensimeter, termometer, pita ukur, dan instrumen psikologis dengan benar.
5. Menggunakan instrumen evaluasi psikologis seperti skala depresi postpartum secara tepat.  
Mahasiswa mampu mengaplikasikan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) atau instrumen lain secara tepat dan akurat.
6. Menginterpretasikan hasil evaluasi untuk menentukan tindakan lanjut yang diperlukan.  
Mahasiswa dapat membuat keputusan klinis berdasarkan hasil evaluasi dan dokumentasi yang ada.
7. Menyusun laporan evaluasi dan dokumentasi asuhan nifas yang dapat digunakan untuk koordinasi dan tindak lanjut.  
Mahasiswa mampu menyusun laporan tertulis yang komunikatif dan profesional untuk mendukung kontinuitas pelayanan.

## A. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Evaluasi hasil asuhan kebidanan pada masa nifas adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas asuhan yang telah diberikan dan kondisi ibu secara keseluruhan selama masa pemulihan setelah persalinan. Evaluasi ini harus mencakup berbagai aspek agar tidak ada tanda bahaya atau komplikasi yang terlewat.

### 1. Evaluasi Aspek Fisiologis

#### a. Pemeriksaan tanda vital:

- Tekanan darah: Memantau untuk deteksi hipertensi atau hipotensi postpartum. Hipertensi dapat menandakan preeklamsia yang belum sembuh atau eklamsia postpartum.
- Denyut nadi: Deteksi takikardia yang mungkin menandakan perdarahan atau infeksi.
- Suhu tubuh: Memantau kemungkinan adanya infeksi, terutama demam yang mengindikasikan endometritis atau infeksi luka.

#### b. Evaluasi involusi uterus:

- Posisi fundus uteri harus terletak pada garis tengah abdomen dan menurun setiap hari sekitar 1 cm.
- Konsistensi uterus harus keras (kontraktil), karena uterus yang lembek (atoni) meningkatkan risiko perdarahan postpartum.

#### c. Pengamatan lochia:

- Jumlah dan warna lochia dievaluasi: lochia rubra (merah), lochia serosa (kemerahan muda/coklat muda), dan lochia alba (kuning keputihan).
- Volume berlebih atau bau tidak sedap dapat menandakan infeksi atau retensi sisa plasenta.

#### d. Pemeriksaan luka perineum atau bekas operasi:

- Tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri, atau keluarnya nanah harus dideteksi dini.
- Evaluasi proses penyembuhan luka harus dilakukan untuk mencegah komplikasi.

### 2. Evaluasi Aspek Psikologis

#### a. Deteksi postpartum blues dan depresi:

- Memantau perubahan mood, tingkat kecemasan, gangguan tidur, dan perilaku ibu.
- Menggunakan alat evaluasi psikologis seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) untuk identifikasi dini risiko depresi.

**b. Bonding ibu dan bayi:**

- Memeriksa hubungan emosional dan interaksi ibu dengan bayi, karena bonding yang baik sangat penting untuk keberhasilan menyusui dan perkembangan bayi.

**3. Evaluasi Aspek Sosial dan Edukasi**

**a. Pemahaman ibu tentang perawatan:**

- Evaluasi apakah ibu memahami cara perawatan diri, teknik pemberian ASI, tanda bahaya yang harus diwaspadai, serta metode kontrasepsi pascapersalinan.

**b. Dukungan sosial:**

- Menilai ketersediaan dukungan dari keluarga, pasangan, dan komunitas yang dapat mempercepat pemulihan dan mencegah stres postpartum.

**4. Evaluasi Risiko dan Komplikasi**

- Mendeteksi tanda-tanda perdarahan postpartum abnormal, seperti perdarahan masif, yang memerlukan intervensi segera.
- Mendeteksi tanda infeksi, seperti demam, nyeri, atau bau lochia yang tidak normal.
- Mengidentifikasi komplikasi lain seperti trombosis vena dalam, emboli, dan masalah psikologis serius.

**5. Penentuan Tindak Lanjut**

- Berdasarkan evaluasi, bidan harus menentukan apakah ibu dapat melanjutkan pemantauan rutin, memerlukan terapi tambahan, atau harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih lanjut.

## **B. Dokumentasi yang diperlukan Selama dan Setelah Masa Nifas**

Dokumentasi adalah aktivitas mencatat seluruh proses asuhan dengan jelas, akurat, dan sistematis agar data tersebut dapat digunakan untuk perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelayanan kesehatan.

**1. Fungsi Dokumentasi**

- Alat komunikasi: Memudahkan tenaga kesehatan lain untuk memahami kondisi dan riwayat asuhan pasien.
- Bukti legal: Melindungi tenaga kesehatan dari klaim hukum dengan bukti tertulis tindakan yang dilakukan.
- Data evaluasi mutu: Menjadi bahan audit dan evaluasi mutu pelayanan kebidanan.
- Sumber data penelitian: Memberikan data untuk pengembangan ilmu kebidanan dan kesehatan.

## **2. Komponen Dokumentasi**

- Data identitas pasien: Nama, usia, alamat, nomor rekam medis.
- Riwayat kehamilan dan persalinan: Kondisi selama hamil dan persalinan yang dapat memengaruhi masa nifas.
- Hasil pemeriksaan fisik dan psikologis: Tanda vital, kondisi uterus, luka, status mental.
- Intervensi dan edukasi yang diberikan: Deskripsi tindakan yang dilakukan dan materi edukasi yang disampaikan.
- Respon ibu terhadap asuhan: Perubahan yang terjadi pada kondisi ibu dan respon terhadap edukasi.
- Rujukan dan tindak lanjut: Jika diperlukan, catat dengan lengkap.

## **3. Bentuk Dokumentasi**

- Catatan harian atau catatan perkembangan (progress notes).
- Formulir standar (checklist pemantauan tanda vital, evaluasi lochia, penyembuhan luka).
- Grafik perkembangan uterus atau tanda vital.
- Rekam medis elektronik (EMR) jika tersedia, yang memudahkan pencarian dan pembagian informasi.

## **4. Prinsip Dokumentasi yang Baik**

- Lengkap dan akurat
- Ditulis segera setelah asuhan
- Jelas dan mudah dibaca
- Objektif, menghindari opini tanpa fakta
- Menggunakan terminologi yang baku dan profesional
- Menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien

## **C. Penggunaan Alat Ukur dan Instrumen Evaluasi**

Penggunaan alat ukur dan instrumen yang tepat sangat penting untuk memperoleh data yang valid dan reliabel selama evaluasi asuhan nifas.

### **1. Alat Ukur Fisiologis**

- Tensimeter dan stetoskop: Memantau tekanan darah dan denyut jantung. Pemantauan ini penting untuk mendeteksi hipertensi postpartum maupun hipotensi yang berisiko.
- Termometer: Mengukur suhu tubuh untuk mendeteksi infeksi seperti endometritis atau mastitis.
- Pita ukur: Digunakan untuk mengukur jarak dari fundus uteri ke pusar, sebagai indikator involusi uterus. Pengukuran ini harus dilakukan secara konsisten untuk melihat perubahan.

- Alat ukur perdarahan: Misalnya, catatan jumlah pembalut yang digunakan atau penggunaan alat ukur khusus untuk memperkirakan volume lochia.
2. Instrumen Evaluasi Psikologis
    - Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): Skala yang digunakan untuk menilai risiko depresi postpartum dengan 10 item pertanyaan yang mudah digunakan.
    - Wawancara terstruktur: Untuk mengeksplorasi kondisi psikologis dan sosial ibu secara lebih mendalam.
  3. Instrumen Edukasi dan Monitoring
    - Checklist edukasi: Memastikan semua topik edukasi penting telah disampaikan dan dipahami oleh ibu.
    - Form observasi perilaku: Memantau interaksi ibu dengan bayi dan kepatuhan pada anjuran asuhan.
  4. Teknologi Pendukung
    - Rekam medis elektronik (EMR): Memudahkan pencatatan, pengarsipan, dan berbagi data antar tenaga kesehatan dengan cepat dan aman.
    - Aplikasi mobile kesehatan: Digunakan untuk pemantauan jarak jauh, pengingat minum obat, jadwal kontrol, dan edukasi interaktif untuk ibu nifas.

## D. Latihan Soal

### Tugas

#### Tugas 1:

##### Evaluasi Kasus Klinis Fisiologis Masa Nifas

Buatlah laporan evaluasi menyeluruh mengenai aspek fisiologis seorang ibu nifas yang baru saja menjalani persalinan normal 3 hari lalu. Dalam laporan tersebut, jelaskan hasil pemeriksaan tanda vital, involusi uterus, pengamatan lochia, dan kondisi luka perineum. Identifikasi potensi komplikasi dan rekomendasikan tindakan lanjut yang harus dilakukan.

*Catatan:* Gunakan data fiktif yang realistis dan sertakan parameter normal serta abnormal.

#### Tugas 2:

##### Penggunaan dan Interpretasi Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Lakukan simulasi wawancara menggunakan EPDS untuk mengevaluasi kondisi psikologis ibu nifas pada hari ke-7 setelah persalinan.

- Buatlah 10 pertanyaan EPDS dan jawab sesuai skenario kasus yang Anda buat.

- Interpretasikan hasil skor dan berikan rekomendasi intervensi psikologis yang sesuai jika ditemukan risiko depresi postpartum.
- Jelaskan pentingnya bonding ibu dan bayi serta cara menilai interaksi tersebut.

### **Tugas 3:**

#### **Menyusun Dokumentasi Asuhan Nifas yang Lengkap dan Sistematis**

Buatlah contoh dokumentasi asuhan nifas selama 1 minggu yang mencakup:

- Data identitas dan riwayat persalinan ibu.
- Hasil pemeriksaan harian (tanda vital, kondisi uterus, lochia, luka).
- Intervensi dan edukasi yang diberikan.
- Respons ibu terhadap asuhan.
- Catatan rujukan atau tindak lanjut jika ada.

Dokumentasi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip dokumentasi yang baik dan mudah dipahami oleh tenaga kesehatan lain.

### **Tugas 4:**

#### **Pemilihan dan Penggunaan Alat Ukur dalam Evaluasi Asuhan Nifas**

Buatlah sebuah panduan singkat yang menjelaskan:

- Cara menggunakan alat ukur fisiologis (tensimeter, termometer, pita ukur fundus uteri) dengan benar.
- Cara mengukur dan mencatat volume lochia secara tepat.
- Fungsi dan cara menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).  
Sertakan alasan mengapa alat dan instrumen tersebut penting dalam evaluasi asuhan nifas.

### **Tugas 5:**

#### **Analisis Studi Kasus dan Penentuan Tindak Lanjut**

Berikan sebuah studi kasus ibu nifas dengan berbagai hasil evaluasi yang berbeda (fisiologis, psikologis, sosial). Misalnya: tekanan darah tinggi, lochia berlebihan, hasil EPDS tinggi, dan kurangnya dukungan sosial.

- Analisis setiap hasil evaluasi tersebut secara detail.
- Tentukan prioritas tindakan yang harus dilakukan oleh bidan.
- Buat rencana tindak lanjut yang mencakup terapi, edukasi, dan kemungkinan rujukan.
- Jelaskan bagaimana dokumentasi yang baik dapat membantu pelaksanaan rencana tersebut.

## Pilihan Ganda

---

1. Seorang ibu nifas 4 hari setelah persalinan normal datang dengan keluhan perdarahan yang lebih banyak dari biasanya. Pemeriksaan tanda vital menunjukkan tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 110 kali/menit, dan suhu 37,5°C. Pemeriksaan fundus uteri menunjukkan uterus lunak dan terasa sedikit membesar, serta posisi sedikit ke kanan. Warna lochia masih merah dan bau tidak menyenangkan. Apakah langkah terbaik yang harus dilakukan oleh bidan?
  - A. Memberikan edukasi tanda bahaya dan menyarankan ibu untuk istirahat lebih banyak
  - B. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kemungkinan retensi plasenta dan merujuk ke dokter
  - C. Memberikan obat antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh
  - D. Menyarankan ibu untuk minum banyak air dan kontrol kembali 1 minggu kemudian
  - E. Melakukan pemijatan uterus secara rutin dan memonitor tanda vital setiap jam
2. Ibu nifas 10 hari pasca persalinan menunjukkan gejala mudah menangis, susah tidur, dan cemas berlebihan. Hasil penilaian dengan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) menunjukkan skor 14. Apa tindakan yang paling tepat yang harus dilakukan bidan?
  - A. Memberikan edukasi tentang pemulihan fisik setelah persalinan
  - B. Memberikan obat tidur untuk mengatasi gangguan tidur
  - C. Melakukan konseling dan merujuk ke layanan psikolog atau psikiater
  - D. Meminta keluarga meningkatkan dukungan sosial tanpa tindakan medis
  - E. Menyarankan ibu untuk mengurangi kontak dengan bayi agar tidak stres
3. Pada kunjungan nifas hari ke-7, bidan mencatat tanda vital ibu dalam rentang normal, posisi fundus di tengah dan 1 cm di bawah pusar, lochia serosa, dan luka perineum sembuh baik tanpa tanda infeksi. Namun, ibu mengaku belum paham sepenuhnya tentang tanda bahaya nifas. Apa langkah dokumentasi yang harus dilakukan?
  - A. Tidak perlu mencatat karena pemeriksaan semua normal
  - B. Mencatat hasil pemeriksaan dan edukasi yang sudah diberikan serta respon ibu
  - C. Mencatat hanya hasil pemeriksaan fisik tanpa edukasi
  - D. Menunda edukasi tanda bahaya sampai kunjungan berikutnya
  - E. Mencatat keluhan ibu tanpa memberikan edukasi



4. Bidan menggunakan pita ukur untuk mengukur jarak fundus uteri dari pusar seorang ibu nifas 3 hari setelah persalinan. Pengukuran menunjukkan jarak 3 cm di bawah pusar. Bagaimana interpretasi hasil ini?
- A. Invulusi uterus berjalan normal sesuai waktu postpartum
  - B. Invulusi uterus terlambat, kemungkinan adanya komplikasi
  - C. Ukuran uterus terlalu kecil, perlu evaluasi lebih lanjut
  - D. Ukuran uterus terlalu besar, tapi tidak perlu dikhawatirkan
  - E. Pengukuran tidak penting selama tanda vital normal
5. Seorang ibu nifas mengeluh demam 38,5°C, nyeri perineum yang memburuk, dan lochia berbau tidak sedap. Pemeriksaan menunjukkan luka perineum kemerahan, bengkak, dan keluar nanah. Apa diagnosis yang paling tepat dan langkah awal penanganannya?
- A. Endometritis; berikan antibiotik dan perawatan luka
  - B. Infeksi luka perineum (lokal); berikan kompres hangat dan analgesik
  - C. Mastitis; anjurkan menyusui dan antibiotik oral
  - D. Infeksi saluran kemih; berikan antibiotik sesuai hasil urin
  - E. Infeksi luka perineum berat; rujuk segera ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut

### Kunci Jawaban

---

1. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Tanda fundus uteri yang lunak (atoni) dan posisi yang tidak normal, serta perdarahan berlebihan dengan bau lochia tidak sedap menunjukkan kemungkinan retensi sisa plasenta atau infeksi. Denyut nadi yang cepat juga mendukung adanya perdarahan. Oleh karena itu, perlu evaluasi lebih lanjut dan kemungkinan rujukan ke dokter untuk penanganan segera. Edukasi saja atau menunggu kontrol tidak cukup, dan antipiretik tanpa penanganan infeksi juga tidak tepat.

2. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Skor EPDS  $\geq 13$  mengindikasikan risiko depresi postpartum yang memerlukan penanganan khusus. Konseling psikologis dan rujukan ke psikiater adalah tindakan tepat. Edukasi fisik atau obat tidur saja tidak menyelesaikan masalah psikologis. Dukungan sosial penting tapi tidak cukup sebagai satu-satunya penanganan, dan mengurangi kontak bayi justru mengganggu bonding.

3. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Dokumentasi yang baik mencakup hasil pemeriksaan, edukasi yang diberikan, dan respon ibu. Walaupun kondisi fisik normal, kurangnya pemahaman ibu harus dicatat dan direspons dengan edukasi. Ini penting untuk komunikasi antar tenaga kesehatan dan akuntabilitas.

4. Kunci Jawaban: A

Pembahasan:

Pada hari ke-3 pasca persalinan, posisi fundus uteri normalnya sekitar 2-3 cm di bawah pusar, menunjukkan involusi uterus yang baik. Ini menandakan pemulihan fisiologis yang sesuai. Pengukuran rutin penting untuk mendeteksi komplikasi.

5. Kunci Jawaban: E

Pembahasan:

Tanda infeksi lokal luka perineum dengan demam tinggi dan keluarnya nanah bisa mengindikasikan infeksi berat atau abses. Penanganan segera di rumah sakit diperlukan, termasuk kemungkinan tindakan bedah dan antibiotik intravena. Antibiotik oral dan perawatan sederhana tidak cukup.

## E. Rangkuman Materi

Evaluasi hasil asuhan kebidanan pada masa nifas merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana intervensi yang telah diberikan efektif serta kondisi ibu secara menyeluruh selama masa pemulihan pasca-persalinan. Evaluasi ini harus mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, serta deteksi risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi agar tanda-tanda bahaya tidak terlewat. Aspek fisiologis meliputi pemeriksaan tanda vital seperti tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi atau hipotensi postpartum, denyut nadi yang dapat mengindikasikan perdarahan atau infeksi, serta suhu tubuh yang penting untuk mengidentifikasi kemungkinan infeksi seperti endometritis. Selain itu, evaluasi involusi uterus dilakukan dengan memastikan posisi fundus uteri berada di garis tengah abdomen dan menurun sekitar satu sentimeter setiap hari, serta konsistensinya harus keras untuk mencegah risiko perdarahan akibat atoni uterus. Pengamatan terhadap lochia, baik jumlah, warna, maupun bau, juga dilakukan untuk menilai kondisi ibu, sebab volume yang berlebihan atau bau tidak sedap dapat menandakan infeksi atau retensi plasenta. Pemeriksaan luka perineum atau bekas operasi harus dilakukan secara cermat untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, nyeri, atau keluarnya nanah agar komplikasi dapat dicegah.

Pada aspek psikologis, evaluasi difokuskan pada deteksi dini postpartum blues dan depresi dengan memantau perubahan mood, kecemasan, gangguan tidur, dan perilaku ibu. Penggunaan alat evaluasi psikologis seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) sangat membantu dalam mengidentifikasi risiko depresi postpartum secara tepat. Bonding antara ibu dan bayi juga menjadi fokus utama karena hubungan emosional yang kuat penting untuk keberhasilan menyusui dan perkembangan bayi. Evaluasi aspek sosial dan edukasi berfokus pada pemahaman ibu terhadap perawatan diri, teknik pemberian ASI, tanda bahaya masa nifas, dan metode kontrasepsi pascapersalinan. Selain itu, dukungan sosial dari keluarga, pasangan, dan komunitas menjadi faktor pendukung pemulihan yang signifikan serta mencegah stres postpartum.

Dalam evaluasi risiko dan komplikasi, penting untuk mendeteksi tanda-tanda perdarahan postpartum abnormal yang membutuhkan intervensi segera, adanya infeksi yang ditandai dengan demam, nyeri, atau bau lochia yang tidak normal, serta komplikasi lain seperti trombosis vena dalam, emboli, atau masalah psikologis serius. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, bidan bertanggung jawab menentukan apakah ibu dapat melanjutkan pemantauan rutin, memerlukan terapi tambahan, atau harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk penanganan lebih lanjut.

Dokumentasi selama dan setelah masa nifas merupakan aktivitas pencatatan seluruh proses asuhan dengan cara yang jelas, akurat, dan sistematis. Dokumentasi ini memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bukti legal yang melindungi tenaga kesehatan dari klaim hukum, data evaluasi mutu pelayanan, serta sumber data untuk penelitian dan pengembangan ilmu kebidanan. Komponen dokumentasi meliputi data identitas pasien, riwayat kehamilan dan persalinan, hasil pemeriksaan fisik dan psikologis, intervensi dan edukasi yang diberikan, respon ibu terhadap asuhan, serta catatan rujukan dan tindak lanjut bila diperlukan. Dokumentasi dapat berupa catatan harian, formulir checklist, grafik perkembangan uterus atau tanda vital, dan rekam medis elektronik yang memudahkan pencatatan dan pencarian informasi. Prinsip dokumentasi yang baik meliputi kelengkapan dan akurasi data, penulisan segera setelah asuhan, keterbacaan yang jelas, objektivitas tanpa opini, penggunaan terminologi baku dan profesional, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan data pasien.

Penggunaan alat ukur dan instrumen evaluasi yang tepat sangat krusial untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya selama proses evaluasi asuhan nifas. Alat ukur fisiologis seperti tensimeter dan stetoskop digunakan untuk memantau tekanan darah dan denyut jantung, yang sangat penting dalam mendeteksi hipertensi

atau hipotensi postpartum. Termometer berfungsi untuk mengukur suhu tubuh dalam mendeteksi tanda infeksi. Pita ukur dipakai untuk mengukur jarak fundus uteri ke pusar sebagai indikator involusi uterus dan harus dilakukan secara konsisten. Alat ukur perdarahan, seperti pencatatan jumlah pembalut yang digunakan, membantu memperkirakan volume lochia secara akurat. Instrumen evaluasi psikologis seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) dan wawancara terstruktur digunakan untuk mengeksplorasi kondisi psikologis dan sosial ibu secara mendalam. Instrumen edukasi dan monitoring seperti checklist edukasi dan form observasi perilaku memantau pemahaman ibu terhadap edukasi serta interaksinya dengan bayi. Teknologi pendukung seperti rekam medis elektronik dan aplikasi mobile kesehatan semakin mempermudah pencatatan, pengarsipan, serta pemantauan jarak jauh dan edukasi interaktif pada masa nifas.

Dengan demikian, evaluasi menyeluruh yang didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan penggunaan alat ukur yang tepat merupakan fondasi utama dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas yang berkualitas dan aman, serta mendukung proses pemulihan ibu secara optimal.

## F. Glosarium

**Atoni Uterus:** Kondisi di mana otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan baik setelah persalinan, menyebabkan uterus menjadi lunak dan berisiko perdarahan postpartum.

**Bonding:** Proses pembentukan hubungan emosional dan interaksi antara ibu dan bayi yang sangat penting untuk keberhasilan menyusui dan perkembangan bayi.

**Depresi Postpartum:** Gangguan mood serius yang dialami ibu setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan, kecemasan, dan gangguan tidur, dapat diukur dengan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).

**Dokumentasi:** Pencatatan sistematis dan akurat dari seluruh proses asuhan kebidanan yang meliputi data pasien, hasil pemeriksaan, intervensi, edukasi, dan tindak lanjut, sebagai alat komunikasi, bukti legal, dan bahan evaluasi mutu pelayanan.

**Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS):** Instrumen psikologis berupa kuesioner yang digunakan untuk menilai risiko depresi postpartum pada ibu setelah melahirkan.

**Endometritis:** Infeksi pada lapisan dalam rahim (endometrium) yang biasanya terjadi setelah persalinan, ditandai dengan demam, nyeri, dan bau lochia tidak sedap.

**Evaluasi Asuhan Kebidanan:** Proses sistematis menilai efektivitas dan hasil dari intervensi kebidanan yang diberikan pada masa nifas, mencakup aspek fisiologis, psikologis, sosial, dan risiko komplikasi.

**Involusi Uterus:** Proses penyusutan uterus kembali ke ukuran dan kondisi sebelum kehamilan setelah persalinan, yang biasanya berlangsung selama 6 minggu.

**Lochia:** Perdarahan dan cairan yang keluar dari rahim setelah persalinan, terdiri dari lochia rubra (merah), lochia serosa (kemerahan muda), dan lochia alba (kuning keputihan).

**Nifas:** Periode pasca-persalinan selama sekitar 6 minggu di mana tubuh ibu mengalami pemulihan fisiologis dan psikologis.

**Perdarahan Postpartum:** Perdarahan yang terjadi setelah persalinan; perdarahan abnormal dapat menandakan komplikasi serius seperti atoni uterus atau retensi plasenta.

**Pemantauan Tanda Vital:** Pengukuran tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan pernapasan untuk menilai kondisi kesehatan ibu secara umum selama masa nifas.

**Pengukuran Fundus Uteri:** Pengukuran jarak dari fundus uteri ke pusar yang digunakan untuk menilai involusi uterus.

**Retensi Plasenta:** Kondisi di mana sisa plasenta tidak keluar seluruhnya setelah persalinan, berisiko menyebabkan perdarahan dan infeksi.

**Tanda Bahaya Nifas:** Gejala yang menunjukkan adanya komplikasi serius selama masa nifas seperti perdarahan hebat, demam tinggi, bau lochia tidak normal, atau nyeri hebat.

**Tanda Vital:** Parameter fisiologis penting berupa tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan laju pernapasan yang dipantau untuk menilai keadaan kesehatan ibu.

**Trombosis Vena Dalam (TVI):** Pembentukan bekuan darah di dalam vena dalam tubuh, yang berisiko serius jika tidak segera ditangani.

## G. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). *Postpartum care*. ACOG Committee Opinion No. 666. *Obstetrics & Gynecology*, 129(1), e140–e150. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001938>
- Bakker, R., Depla, M., & Hage, J. J. (2020). Postpartum hemorrhage: Pathophysiology and management. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*, 247, 52–58. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.01.009>
- Dennis, C. L., & Falah-Hassani, K. (2019). Shining light on postpartum depression screening: A review of Edinburgh Postnatal Depression Scale validation studies. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 40(1), 64–77. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2018.1524476>
- Geller, S. E., Koch, A. R., Martin, N. C., Rosenberg, D., & Callaghan, W. M. (2021). A global view of severe maternal morbidity: Moving beyond maternal mortality. *Obstetrics & Gynecology*, 137(3), 421–429. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004274>
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on maternal health: Guidelines for health care providers*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/275453>

# Bab 10

## Konsep Tren dan Isu Terkini Dalam Asuhan Nifas

Masa nifas merupakan periode kritis bagi ibu pascapersalinan yang membutuhkan asuhan komprehensif agar proses pemulihan berjalan optimal dan komplikasi dapat dicegah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi, peningkatan akses informasi, dan perubahan sosial telah memengaruhi cara pemberian asuhan nifas. Digitalisasi dan telehealth kini menjadi tren yang berkembang pesat, mempermudah monitoring dan edukasi ibu dari jarak jauh. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based practice) semakin diutamakan untuk memastikan intervensi kebidanan efektif dan aman. Selain itu, kesehatan mental ibu mulai mendapat perhatian serius sebagai bagian penting dari asuhan nifas, dengan integrasi layanan yang melibatkan keluarga dan komunitas menjadi kunci keberhasilan pemulihan ibu. Peran menyusui dan inisiasi menyusui dini tidak hanya penting untuk kesehatan bayi, tetapi juga mendukung ikatan emosional ibu dan bayi serta kesehatan ibu. Di sisi lain, isu kesetaraan akses pelayanan menjadi perhatian utama dalam memastikan semua ibu mendapatkan asuhan nifas yang berkualitas tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, maupun geografis. Bab ini mengulas tren dan isu terkini yang relevan dalam asuhan nifas, sebagai landasan pemahaman bagi mahasiswa kebidanan agar mampu memberikan pelayanan yang modern, holistik, dan berkeadilan.

### Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami perkembangan tren digitalisasi dan telehealth serta penerapannya dalam asuhan nifas.
2. Mengaplikasikan pendekatan berbasis bukti dalam perencanaan dan pelaksanaan asuhan nifas.
3. Mengidentifikasi dan mengelola isu kesehatan mental ibu selama masa nifas.
4. Menjelaskan pentingnya integrasi layanan nifas dengan keluarga dan komunitas.
5. Memahami peran menyusui dan inisiasi menyusui dini dalam mendukung kesehatan ibu dan bayi.
6. Menganalisis isu kesetaraan akses pelayanan nifas dan strategi mengatasinya.

### Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran dalam bab ini, mahasiswa mampu:

1. Mendeskripsikan konsep digitalisasi dan telehealth serta manfaatnya dalam asuhan nifas.
2. Menggunakan sumber evidence-based practice untuk meningkatkan mutu asuhan nifas.
3. Melakukan penilaian dan intervensi awal pada masalah kesehatan mental ibu nifas.
4. Menyusun rencana asuhan yang melibatkan keluarga dan komunitas sebagai bagian dari pelayanan nifas.

5. Mengoptimalkan pemberian ASI melalui inisiasi menyusui dini dan dukungan menyusui.
6. Mengidentifikasi hambatan kesetaraan akses pelayanan nifas dan merancang solusi yang sesuai.

**Sub-CPMK**

1. Menjelaskan konsep dan aplikasi digitalisasi dan telehealth dalam asuhan nifas serta implikasinya pada pelayanan kesehatan.
2. Mengidentifikasi sumber dan prinsip evidence-based practice yang relevan untuk asuhan nifas.
3. Melakukan skrining awal dan penanganan kesehatan mental ibu menggunakan alat yang tepat.
4. Merancang program asuhan nifas yang melibatkan keluarga dan komunitas secara efektif.
5. Menguraikan mekanisme dan manfaat inisiasi menyusui dini serta teknik mendukung proses menyusui.
6. Mengkaji isu sosial dan geografis terkait kesetaraan akses pelayanan serta strategi intervensi.



## A. Digitalisasi dan Telehealth dalam Asuhan Nifas

### 1. Latar Belakang

Digitalisasi di bidang kesehatan, yang mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, telah menjadi pilar utama dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan modern. Telehealth, sebagai bagian dari digitalisasi, menawarkan model pelayanan yang inovatif dengan menjembatani jarak fisik antara tenaga kesehatan dan pasien melalui media digital seperti video call, aplikasi mobile, dan platform online lainnya.

### 2. Peran Telehealth dalam Asuhan Nifas

Dalam konteks masa nifas, telehealth memberikan kemudahan akses bagi ibu, terutama yang tinggal di daerah terpencil, pulau-pulau kecil, atau kawasan yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan. Melalui telehealth, bidan dapat melakukan:

- a. Konsultasi virtual secara berkala untuk memantau tanda-tanda vital ibu dan kondisi bayi, seperti berat badan, suhu tubuh, tanda-tanda infeksi, dan kelancaran menyusui.
- b. Pemberian edukasi dan informasi tentang perawatan diri pasca persalinan, teknik menyusui yang benar, tanda bahaya yang harus diwaspadai, dan nutrisi yang dianjurkan.
- c. Pendampingan psikologis dengan sesi konseling online yang membantu ibu mengatasi stres, kecemasan, dan gangguan mood yang kerap muncul pada masa nifas.
- d. Pemantauan komplikasi dini sehingga tindakan cepat dapat dilakukan bila ditemukan tanda-tanda seperti perdarahan berlebih, infeksi, atau gangguan kesehatan mental.

### 3. Studi Kasus dan Contoh Implementasi

Selama pandemi COVID-19, banyak layanan kesehatan nifas di Indonesia dan dunia yang mengadopsi telehealth untuk mencegah penularan virus sekaligus memastikan kontinuitas asuhan. Misalnya, bidan di Jawa Timur menggunakan aplikasi WhatsApp dan Zoom untuk melakukan follow-up ibu nifas secara rutin, menyampaikan video tutorial ASI eksklusif, serta sesi tanya jawab interaktif.

### 4. Kelebihan dan Keuntungan

- a. Efisiensi waktu dan biaya: Ibu tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan, menghemat biaya transportasi dan waktu.
- b. Meningkatkan kepatuhan ibu terhadap jadwal kontrol: Fleksibilitas waktu membuat ibu lebih mudah mengikuti jadwal kunjungan.
- c. Pencegahan risiko infeksi: Mengurangi kontak fisik yang tidak perlu, terutama pada masa pandemi atau wabah penyakit menular.

## 5. Tantangan dan Hambatan

- a. Akses teknologi dan jaringan internet: Masih banyak wilayah di Indonesia yang mengalami keterbatasan jaringan, sehingga menghambat pelaksanaan telehealth.
- b. Literasi digital: Baik tenaga kesehatan maupun ibu nifas memerlukan pelatihan untuk menggunakan aplikasi digital dengan efektif.
- c. Privasi dan keamanan data: Penggunaan platform yang kurang aman dapat menimbulkan risiko kebocoran data pribadi pasien.
- d. Keterbatasan pemeriksaan fisik: Telehealth tidak dapat menggantikan sepenuhnya pemeriksaan fisik, sehingga diperlukan model hybrid antara kunjungan online dan offline.

## 6. Upaya Pengembangan dan Rekomendasi

- a. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi oleh pemerintah dan sektor swasta di daerah-daerah tertinggal.
- b. Pengembangan aplikasi khusus asuhan nifas yang user-friendly dan memiliki fitur keamanan data.
- c. Pelatihan rutin bagi bidan dan tenaga kesehatan lain dalam literasi digital dan telemedicine.
- d. Integrasi telehealth dalam sistem pelayanan kesehatan nasional sebagai pelengkap layanan konvensional.

## B. Pendekatan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*) dalam Asuhan Nifas

### 1. Definisi dan Konsep

Pendekatan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice/EBP*) adalah proses pengambilan keputusan klinis yang memadukan hasil penelitian terbaik dengan keahlian klinis dan preferensi pasien. Dalam asuhan nifas, EBP menjamin bahwa intervensi dan tindakan yang dilakukan telah melalui evaluasi ilmiah sehingga efektif dan aman.

### 2. Perkembangan EBP di Bidang Kebidanan

EBP telah menjadi standar global dalam praktik kesehatan, termasuk kebidanan. Banyak pedoman nasional dan internasional, seperti WHO dan NICE, mengembangkan protokol asuhan nifas berdasarkan bukti terbaru yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan. EBP juga menuntut tenaga kesehatan untuk terus melakukan pembaruan ilmu dan mengikuti riset terkini.

### **3. Komponen EBP dalam Asuhan Nifas**

- a. *Best Research Evidence*: Data dan hasil riset terbaru mengenai intervensi nifas seperti pengelolaan perdarahan postpartum, perawatan luka episiotomi, dan strategi penyusuan.
- b. *Clinical Expertise*: Keahlian dan pengalaman bidan dalam menangani kasus-kasus nyata serta kemampuan beradaptasi terhadap kondisi ibu yang beragam.
- c. *Patient Values and Preferences*: Memperhatikan keinginan, budaya, dan kondisi psikososial ibu sehingga asuhan bersifat personal dan bermakna.

### **4. Contoh Praktik EBP dalam Asuhan Nifas**

- a. Penggunaan magnesium sulfat pada kasus preeklamsia berat sesuai rekomendasi WHO.
- b. Implementasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dalam satu jam pertama setelah lahir yang telah terbukti menurunkan angka kematian neonatal.
- c. Pemberian antibiotik profilaksis hanya pada indikasi jelas untuk mencegah resistensi dan efek samping.

### **5. Manfaat EBP**

- a. Mengurangi kesalahan klinis dan komplikasi.
- b. Meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi.
- c. Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan.
- d. Memperkuat profesionalisme tenaga kesehatan.

### **6. Hambatan dalam Pelaksanaan EBP**

- a. Keterbatasan akses literatur ilmiah terutama di daerah dengan sumber daya terbatas.
- b. Kurangnya pelatihan dan pembinaan EBP bagi tenaga kesehatan.
- c. Budaya praktik yang masih tradisional dan resistensi terhadap perubahan.
- d. Beban kerja yang tinggi sehingga sulit meluangkan waktu untuk membaca dan mengkaji literatur terbaru.

### **7. Solusi dan Strategi**

- a. Penyediaan akses jurnal dan sumber referensi yang mudah dan gratis.
- b. Pelatihan rutin EBP dan workshop di institusi kesehatan.
- c. Pengembangan sistem mentoring dan peer review untuk mendorong budaya EBP.
- d. Integrasi EBP dalam kurikulum pendidikan kebidanan dan pelatihan berkelanjutan.

## C. Fokus pada Kesehatan Mental Ibu selama Masa Nifas

### 1. Pentingnya Kesehatan Mental

Kesehatan mental ibu pada masa nifas merupakan aspek yang tidak kalah penting dibandingkan kesehatan fisik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gangguan mental pada masa nifas, seperti postpartum blues, depresi postpartum, dan kecemasan, dapat memengaruhi kemampuan ibu dalam merawat diri dan bayi, serta berdampak pada perkembangan psikososial anak.

### 2. Jenis Gangguan Mental yang Umum Terjadi

- a. Baby Blues: Perubahan mood ringan yang dialami hingga 80% ibu, biasanya berlangsung selama beberapa hari.
- b. Depresi Postpartum: Gangguan yang lebih berat dan berkepanjangan, ditandai dengan perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat.
- c. Gangguan Kecemasan: Termasuk panic attack dan gangguan stres pasca trauma (PTSD).
- d. Psikosis Postpartum: Kasus langka namun sangat serius yang membutuhkan penanganan medis segera.

### 3. Faktor Risiko

- a. Riwayat gangguan mental sebelumnya.
- b. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan.
- c. Komplikasi persalinan atau kelahiran bayi dengan masalah kesehatan.
- d. Stres ekonomi dan permasalahan keluarga.
- e. Isolasi sosial terutama di masa pandemi atau daerah terpencil.

### 4. Peran Tenaga Kesehatan dalam Asuhan Mental

- a. Screening dan Deteksi Dini: Menggunakan alat skrining seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS).
- b. Edukasi dan Konseling: Memberikan informasi tentang tanda-tanda gangguan dan cara mengatasinya.
- c. Kolaborasi Multidisipliner: Merujuk kepada psikolog, psikiater, atau pekerja sosial bila perlu.
- d. Dukungan Psikososial: Mengajak keluarga untuk memberikan dukungan emosional.

### 5. Intervensi dan Pendampingan

- a. Konseling individual dan kelompok.
- b. Terapi perilaku kognitif.
- c. Dukungan komunitas seperti kelompok ibu nifas dan pendamping sebaya.
- d. Pendekatan holistik yang memperhatikan aspek fisik, psikologis, dan sosial.

## **6. Peran Telehealth dalam Mendukung Kesehatan Mental**

Telehealth juga membuka akses layanan konseling dan pendampingan psikologis secara online, yang sangat membantu ibu yang memiliki keterbatasan akses fisik.

## **D. Integrasi Layanan Nifas dengan Keluarga dan Komunitas**

### **1. Peran Keluarga dalam Asuhan Nifas**

Keluarga merupakan sistem pendukung utama bagi ibu selama masa nifas. Dukungan keluarga dapat berupa bantuan fisik, emosional, maupun finansial. Keterlibatan keluarga dalam proses asuhan meningkatkan kepatuhan ibu terhadap rekomendasi kesehatan dan mempercepat proses pemulihan.

### **2. Fungsi Komunitas**

Komunitas dapat menyediakan lingkungan sosial yang kondusif melalui program-program kesehatan ibu dan anak, seperti posyandu, kader kesehatan, dan kelompok dukungan ibu. Komunitas juga menjadi sumber informasi, edukasi, dan dukungan sosial yang membantu ibu menyesuaikan diri dengan peran barunya.

### **3. Strategi Integrasi Layanan**

- a. Pendekatan keluarga-sentris: Melibatkan anggota keluarga dalam konsultasi dan edukasi.
- b. Penguatan peran kader kesehatan dan posyandu untuk memantau kondisi ibu dan bayi di lingkungan.
- c. Kolaborasi lintas sektor antara fasilitas kesehatan dengan lembaga sosial dan keagamaan.
- d. Pendekatan budaya lokal agar pelayanan lebih diterima dan efektif.

### **4. Manfaat Integrasi**

- a. Meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi.
- b. Memperkuat jejaring sosial yang menopang ibu.
- c. Mempermudah akses informasi dan layanan.
- d. Mengurangi beban tenaga kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

## **E. Peran Menyusui dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dalam Asuhan Nifas**

### **1. Pentingnya Menyusui**

Menyusui memberikan manfaat fisiologis dan psikologis yang sangat besar bagi ibu dan bayi. ASI mengandung nutrisi lengkap dan antibodi yang melindungi bayi dari berbagai infeksi. Selain itu, menyusui membantu kontraksi uterus ibu sehingga mempercepat pemulihan setelah persalinan.

Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

IMD adalah proses menempelkan bayi pada payudara ibu dalam waktu satu jam pertama setelah kelahiran. IMD memiliki banyak manfaat:

- a. Mengoptimalkan produksi ASI.
- b. Meningkatkan bonding ibu dan bayi.
- c. Menurunkan angka kematian neonatal dan morbiditas.
- d. Mendorong menyusui eksklusif hingga 6 bulan.

## **2. Hambatan dalam Menyusui dan IMD**

- a. Faktor medis seperti kelahiran caesar, bayi prematur, atau kondisi ibu yang kurang sehat.
- b. Kurangnya pengetahuan dan dukungan dari tenaga kesehatan dan keluarga.
- c. Praktik budaya dan mitos yang menghambat pemberian ASI dini.
- d. Lingkungan rumah sakit yang tidak mendukung praktik IMD.

## **3. Upaya Meningkatkan Peran Menyusui**

- a. Pelatihan dan edukasi tenaga kesehatan mengenai teknik menyusui dan IMD.
- b. Penyediaan ruang dan waktu yang mendukung IMD di fasilitas kesehatan.
- c. Edukasi dan pemberdayaan keluarga agar mendukung ibu menyusui.
- d. Kampanye nasional tentang pentingnya ASI dan IMD.

# **F. Isu Kesetaraan Akses Pelayanan**

## **1. Kondisi Saat Ini**

Kesetaraan akses menjadi isu utama dalam pelayanan kesehatan nifas. Perbedaan signifikan masih terjadi antara ibu di wilayah perkotaan dan pedesaan, ibu dari berbagai strata sosial ekonomi, serta antar kelompok etnis dan budaya.

Faktor Penghambat

- a. Geografi: Jarak dan kondisi medan sulit menyebabkan keterlambatan atau ketidaktersediaan layanan.
- b. Ekonomi: Biaya transportasi dan pelayanan menjadi kendala bagi keluarga miskin.
- c. Sosial Budaya: Norma, kepercayaan, dan diskriminasi dapat menghambat ibu untuk mengakses layanan.
- d. Keterbatasan sumber daya: Jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang belum merata.

## **2. Dampak Ketidaksetaraan**

- Angka kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi di kelompok rentan.
- Penurunan kualitas asuhan nifas yang diterima.
- Ketimpangan hasil kesehatan yang berkelanjutan.

## **3. Upaya dan Kebijakan**

- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjamin akses tanpa biaya langsung.

- Pengembangan layanan kesehatan bergerak (mobile clinic) dan telehealth.
- Pemberdayaan kader dan kelompok masyarakat.
- Penyuluhan dan edukasi berbasis komunitas untuk mengatasi hambatan budaya.

## G. Latihan Soal

### Tugas

---

#### Tugas 1:

##### Deskripsi:

Buatlah sebuah esai minimal 1000 kata yang membahas pemanfaatan telehealth dalam asuhan nifas. Dalam esai Anda, jelaskan latar belakang perkembangan telehealth, manfaat utama bagi ibu nifas, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Berikan contoh nyata atau studi kasus implementasi telehealth selama pandemi COVID-19 di Indonesia atau negara lain.

##### Tujuan:

- Memahami konsep digitalisasi dan telehealth dalam asuhan nifas.
- Mampu mengidentifikasi kelebihan dan kendala telehealth secara kritis.
- Melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam konteks pelayanan kesehatan modern.

#### Tugas 2:

##### Deskripsi:

Lakukan pencarian literatur ilmiah terbaru (tahun 2018-2025) mengenai penerapan Evidence-Based Practice (EBP) dalam asuhan nifas. Buatlah ringkasan dengan minimal 5 artikel ilmiah yang relevan dan tuliskan bagaimana EBP meningkatkan kualitas asuhan nifas, contoh protokol atau intervensi yang menggunakan EBP, serta hambatan dan solusi yang ditemukan. Sertakan daftar pustaka sesuai format APA.

##### Tujuan:

- Meningkatkan kemampuan mencari dan mengolah informasi ilmiah terkini.
- Memahami pentingnya EBP dalam praktik kebidanan.
- Melatih penulisan ilmiah dan pengelolaan referensi.

#### Tugas 3:

##### Deskripsi:

Buatlah sebuah makalah yang memetakan berbagai jenis gangguan kesehatan mental yang umum terjadi pada ibu nifas, faktor risiko yang memengaruhi, serta strategi asuhan yang dapat dilakukan bidan untuk mendeteksi dan mendampingi ibu yang

mengalami gangguan mental tersebut. Jelaskan pula peran telehealth sebagai alternatif layanan kesehatan mental.

**Tujuan:**

- Memahami aspek psikologis dalam asuhan nifas secara mendalam.
- Mampu merancang intervensi sesuai kebutuhan ibu.
- Mengapresiasi pentingnya integrasi teknologi dalam asuhan psikososial.

**Tugas 4:**

**Deskripsi:**

Susunlah laporan observasi atau wawancara minimal 2 keluarga dan/atau kader kesehatan di komunitas mengenai peran mereka dalam mendukung ibu masa nifas. Jelaskan bagaimana keluarga dan komunitas berkontribusi dalam proses pemulihan ibu dan bayi, hambatan yang mereka hadapi, serta rekomendasi untuk memperkuat integrasi layanan nifas di tingkat keluarga dan komunitas.

**Tujuan:**

- Melatih keterampilan observasi dan wawancara lapangan.
- Mengidentifikasi dinamika sosial yang mempengaruhi asuhan nifas.
- Mendorong pemahaman pentingnya dukungan sosial dalam kesehatan ibu dan bayi.

**Tugas 5:**

**Deskripsi:**

Buatlah sebuah paper analisis mengenai hambatan yang sering dihadapi dalam praktik menyusui dan IMD di fasilitas kesehatan dan lingkungan rumah, serta upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan keluarga untuk mengatasi hambatan tersebut. Sertakan kajian mengenai pentingnya edukasi, pelatihan tenaga kesehatan, dan kebijakan pendukung yang memfasilitasi keberhasilan IMD dan pemberian ASI eksklusif.

**Tujuan:**

- Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyusui dan IMD.
- Melatih kemampuan analisis masalah dan perumusan solusi.
- Mengaplikasikan teori dalam konteks kebijakan dan praktik nyata.



## Pilihan Ganda

---

1. Seorang ibu nifas usia 28 tahun tinggal di daerah terpencil yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan. Selama masa nifas, bidan melakukan pemantauan kondisi ibu dan bayinya melalui video call rutin menggunakan aplikasi telehealth. Pada sesi tersebut, bidan meminta ibu mengukur suhu tubuh dan berat badan bayi serta menanyakan kelancaran menyusui. Pada kunjungan virtual berikutnya, ibu melaporkan adanya perdarahan berlebih dan keluhan nyeri. Langkah yang tepat yang harus dilakukan bidan adalah?
  - A. Memberi resep obat melalui telehealth tanpa harus bertemu langsung
  - B. Menyampaikan edukasi dan mengarahkan ibu untuk memperbanyak istirahat
  - C. Segera merujuk ibu untuk pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat
  - D. Menunda intervensi dan memonitor kondisi selama 3 hari ke depan
  - E. Mengabaikan keluhan karena tidak bisa pemeriksaan fisik langsung
2. Seorang bidan menangani ibu nifas dengan riwayat preeklamsia berat. Berdasarkan pedoman terbaru WHO, penggunaan obat yang direkomendasikan untuk mencegah kejang adalah?
  - A. Magnesium sulfat
  - B. Diazepam
  - C. Fenitoin
  - D. Klorpromazin
  - E. Paracetamol
3. Seorang ibu nifas 3 minggu yang baru melahirkan mengalami perubahan mood berat, sering menangis tanpa sebab jelas, merasa putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari. Keluarga mengeluhkan bahwa ibu sulit diajak komunikasi dan cenderung menarik diri. Apa langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan?
  - A. Memberikan obat penenang secara langsung
  - B. Melakukan screening menggunakan Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
  - C. Mengabaikan karena ini wajar terjadi pada masa nifas
  - D. Mengajak ibu melakukan olahraga berat untuk mengurangi stress
  - E. Memberikan edukasi menyusui agar ibu lebih fokus
4. Di sebuah desa, bidan bekerja sama dengan kader kesehatan dan keluarga ibu nifas untuk memantau kondisi ibu dan bayi. Salah satu manfaat utama integrasi ini adalah?

- A. Mengurangi kebutuhan ibu untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan secara total
  - B. Mempercepat pemberian obat-obatan tanpa supervisi tenaga kesehatan
  - C. Meningkatkan dukungan sosial yang mempercepat proses pemulihan ibu
  - D. Menghilangkan peran bidan dalam asuhan masa nifas
  - E. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung pemerintah
5. Seorang ibu yang baru melahirkan melalui persalinan caesar mengeluhkan kesulitan melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) karena rasa nyeri dan bayi sulit melekat. Apa pendekatan terbaik bidan untuk membantu ibu tersebut?
- A. Menyarankan ibu menunggu sampai nyeri hilang baru mulai menyusui
  - B. Memberikan susu formula sebagai pengganti sementara
  - C. Mengabaikan IMD karena persalinan caesar tidak memungkinkan IMD
  - D. Menyarankan bayi diberi dot agar tidak kesulitan menyusu
  - E. Memberikan dukungan dan edukasi teknik menyusui yang tepat serta mengurangi nyeri dengan posisi nyaman

### Kunci Jawaban

---

1. **Kunci Jawaban: C**

**Pembahasan:**

Telehealth berguna untuk monitoring dan edukasi, namun tidak dapat menggantikan pemeriksaan fisik jika ditemukan tanda-tanda komplikasi serius seperti perdarahan berlebih. Segera merujuk ibu untuk pemeriksaan langsung adalah tindakan tepat agar penanganan medis dapat diberikan secara optimal.

2. **Kunci Jawaban: A**

**Pembahasan:**

Magnesium sulfat adalah obat yang terbukti secara ilmiah efektif untuk mencegah kejang pada preeklamsia berat dan direkomendasikan WHO sebagai standar praktik EBP. Obat lain tidak memiliki bukti sekuat magnesium sulfat untuk indikasi tersebut.

3. **Kunci Jawaban: B**

**Pembahasan:**

Screening dengan alat valid seperti EPDS merupakan langkah awal penting untuk mendeteksi gangguan depresi postpartum. Penanganan yang tepat bisa direncanakan setelah hasil screening. Memberikan obat tanpa diagnosis atau mengabaikan gejala bukan tindakan tepat.

4. **Kunci Jawaban: C**

**Pembahasan:**

Integrasi layanan dengan keluarga dan komunitas meningkatkan dukungan sosial, yang sangat berpengaruh positif terhadap kesehatan fisik dan mental ibu serta mempercepat pemulihan. Ini bukan menggantikan peran bidan tetapi memperkuat jejaring pendukung.

5. **Kunci Jawaban:** E

**Pembahasan:**

Pendampingan menyusui dengan teknik yang benar dan posisi yang nyaman dapat membantu mengurangi nyeri dan mempermudah bayi melekat. Edukasi dan dukungan sangat penting agar IMD tetap dapat dilaksanakan meski ada hambatan medis seperti persalinan caesar. Penggunaan susu formula atau dot sebaiknya dihindari jika memungkinkan.

## H. Rangkuman Materi

Digitalisasi dalam bidang kesehatan telah menjadi pilar penting dalam pengembangan sistem pelayanan modern. Telehealth, sebagai bagian dari digitalisasi ini, menawarkan cara inovatif untuk menghubungkan tenaga kesehatan dengan pasien melalui media digital seperti video call dan aplikasi mobile, sehingga memungkinkan pelayanan jarak jauh yang efektif. Dalam konteks asuhan nifas, telehealth sangat membantu ibu terutama yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau fasilitas kesehatan. Melalui telehealth, bidan dapat melakukan konsultasi virtual secara berkala untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi, memberikan edukasi mengenai perawatan pascapersalinan, teknik menyusui yang benar, serta tanda bahaya yang harus diwaspadai. Telehealth juga membuka akses pendampingan psikologis bagi ibu yang mengalami stres dan gangguan mood selama masa nifas, sekaligus memungkinkan deteksi dini komplikasi yang membutuhkan intervensi cepat. Contoh implementasi telehealth terlihat jelas selama pandemi COVID-19, di mana layanan ini mencegah penularan virus sekaligus memastikan kelangsungan asuhan nifas melalui aplikasi seperti WhatsApp dan Zoom. Telehealth memberikan efisiensi waktu dan biaya, meningkatkan kepatuhan ibu terhadap jadwal kontrol, dan mengurangi risiko infeksi. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses teknologi, literasi digital yang rendah, serta privasi dan keamanan data tetap perlu diatasi. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, dan pengembangan aplikasi khusus menjadi rekomendasi penting agar telehealth dapat terintegrasi sebagai pelengkap layanan kesehatan konvensional.

Pendekatan berbasis bukti (EBP) adalah proses pengambilan keputusan klinis yang menggabungkan hasil penelitian terbaik dengan keahlian klinis dan nilai-nilai serta preferensi pasien. Dalam asuhan nifas, EBP memastikan intervensi yang diberikan

efektif dan aman berdasarkan evaluasi ilmiah. Standar ini telah menjadi pedoman global yang diterapkan dalam praktik kebidanan, dengan berbagai protokol nasional dan internasional yang diperbarui sesuai perkembangan riset terkini. Komponen utama EBP meliputi bukti riset terbaik, keahlian klinis bidan, dan perhatian terhadap kebutuhan serta kondisi psikososial ibu. Contoh praktik EBP termasuk penggunaan magnesium sulfat untuk mencegah kejang pada preeklamsia berat, pelaksanaan inisiasi menyusui dini yang terbukti menurunkan kematian neonatal, dan penggunaan antibiotik profilaksis dengan indikasi jelas. Manfaat pendekatan ini adalah menurunkan kesalahan klinis, meningkatkan hasil kesehatan, memperkuat kepercayaan pasien, dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Hambatan seperti keterbatasan akses literatur, kurangnya pelatihan, budaya praktik lama, dan beban kerja tinggi harus diatasi melalui akses jurnal gratis, pelatihan rutin, sistem mentoring, dan integrasi EBP dalam kurikulum pendidikan.

Kesehatan mental ibu selama masa nifas merupakan aspek yang sangat penting dan berpengaruh langsung pada kemampuan ibu dalam merawat dirinya dan bayinya. Gangguan mental yang sering dijumpai antara lain baby blues, depresi postpartum, kecemasan, dan psikosis postpartum. Faktor risiko meliputi riwayat gangguan mental sebelumnya, kurangnya dukungan sosial, komplikasi persalinan, stres ekonomi, dan isolasi sosial. Tenaga kesehatan berperan dalam melakukan screening dan deteksi dini dengan alat valid seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale, memberikan edukasi dan konseling, serta merujuk ke tenaga profesional jika diperlukan. Pendampingan dapat dilakukan melalui konseling individual atau kelompok, terapi perilaku kognitif, dukungan komunitas, dan pendekatan holistik. Telehealth juga mempermudah akses layanan kesehatan mental, terutama untuk ibu yang memiliki keterbatasan akses fisik.

Integrasi layanan nifas dengan keluarga dan komunitas sangat penting untuk menunjang keberhasilan asuhan. Keluarga berfungsi sebagai sistem pendukung utama, menyediakan bantuan fisik, emosional, dan finansial. Komunitas memberikan lingkungan sosial yang kondusif melalui program-program kesehatan, kader, dan kelompok dukungan ibu. Strategi integrasi mencakup pendekatan keluarga-sentris, penguatan peran kader dan posyandu, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan budaya lokal agar layanan lebih diterima. Integrasi ini meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi, memperkuat jejaring sosial pendukung, mempermudah akses informasi, dan mengurangi beban tenaga kesehatan.

Menyusui dan inisiasi menyusui dini (IMD) merupakan komponen utama dalam asuhan nifas yang memiliki manfaat fisiologis dan psikologis besar bagi ibu dan bayi. ASI mengandung nutrisi lengkap dan antibodi penting, serta membantu mempercepat

pemulihan ibu melalui kontraksi uterus. IMD, yaitu menempelkan bayi pada payudara dalam satu jam pertama setelah lahir, meningkatkan produksi ASI, memperkuat bonding, menurunkan angka kematian neonatal, dan mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Hambatan dalam menyusui dan IMD termasuk kondisi medis ibu atau bayi, kurangnya pengetahuan dan dukungan, praktik budaya yang menghambat, serta lingkungan rumah sakit yang tidak mendukung. Upaya peningkatan peran menyusui dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, penyediaan ruang dan waktu yang memadai, edukasi keluarga, dan kampanye nasional.

Isu kesetaraan akses pelayanan asuhan nifas menjadi perhatian utama karena masih terdapat perbedaan signifikan antara ibu di wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok sosial dan budaya. Faktor penghambat akses meliputi geografi yang sulit, biaya ekonomi, hambatan sosial budaya, dan keterbatasan sumber daya kesehatan. Dampaknya terlihat dari tingginya angka kematian ibu dan bayi pada kelompok rentan serta penurunan kualitas asuhan. Upaya mengatasi masalah ini dilakukan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional, pengembangan layanan bergerak dan telehealth, pemberdayaan kader serta kelompok masyarakat, serta edukasi berbasis komunitas untuk mengatasi hambatan budaya dan sosial.

## I. Rangkuman Materi

**Antibiotik Profilaksis:** Penggunaan antibiotik untuk mencegah infeksi pada kondisi atau prosedur tertentu dengan indikasi yang jelas.

**Asuhan Nifas:** Perawatan dan pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan untuk memastikan pemulihan dan pencegahan komplikasi.

**Bonding:** Ikatan emosional yang terbentuk antara ibu dan bayi, penting untuk perkembangan psikologis dan kesehatan bayi.

**Depresi Postpartum:** Gangguan mental yang lebih serius dan berkepanjangan setelah melahirkan, ditandai oleh perasaan sedih dan kehilangan minat yang signifikan.

**Digitalisasi:** Proses integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan.

**Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS):** Alat skrining yang digunakan untuk mendeteksi gejala depresi postpartum pada ibu nifas.

**Evidence-Based Practice (EBP):** Pendekatan pengambilan keputusan klinis yang menggabungkan bukti ilmiah terbaru, keahlian klinis, dan nilai serta preferensi pasien untuk memberikan intervensi yang efektif dan aman.

**Inisiasi Menyusui Dini (IMD):** Proses menempelkan bayi pada payudara ibu dalam waktu satu jam pertama setelah lahir guna meningkatkan produksi ASI dan memperkuat ikatan ibu-bayi.

**Integrasi Layanan Keluarga dan Komunitas:** Pendekatan yang melibatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari sistem pendukung utama dalam memberikan asuhan kesehatan kepada ibu nifas.

**Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):** Program pemerintah Indonesia yang menjamin akses layanan kesehatan secara universal dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

**Kader Kesehatan:** Sukarelawan atau petugas di tingkat komunitas yang membantu memantau dan mendukung kesehatan ibu dan anak di lingkungan mereka.

**Literasi Digital:** Kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif dan aman, baik oleh tenaga kesehatan maupun pasien.

**Mobile Clinic:** Layanan kesehatan bergerak yang mendekatkan pelayanan ke masyarakat di daerah terpencil atau sulit dijangkau.

**Magnesium Sulfat:** Obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati kejang pada kasus preeklamsia berat dalam praktik kebidanan berbasis bukti.

**Privasi dan Keamanan Data:** Perlindungan informasi pribadi pasien agar tidak disalahgunakan dalam penggunaan platform digital.

**Postpartum Blues:** Perubahan mood ringan yang dialami ibu nifas pada beberapa hari pertama setelah melahirkan, biasanya bersifat sementara.

**Telehealth:** Pelayanan kesehatan jarak jauh yang menggunakan teknologi digital seperti video call, aplikasi mobile, dan platform online untuk konsultasi, edukasi, dan monitoring pasien tanpa tatap muka langsung.

## J. Daftar Pustaka

- Almathami, H. K. Y., Win, K. T., & Vlahu-Gjorgievska, E. (2020). Barriers and facilitators that influence telemedicine-based, real-time, online consultation at patients' homes: Systematic literature review. *Journal of Medical Internet Research*, 22(2), e16407. <https://doi.org/10.2196/16407>
- Bohren, M. A., Hunter, E. C., Munthe-Kaas, H., Souza, J. P., Vogel, J. P., & Gülmezoglu, A. M. (2017). Facilitators and barriers to facility-based delivery in low- and middle-income countries: A qualitative evidence synthesis. *Reproductive Health*, 11(1), 71. <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0328-9>
- Craig, J., & Patterson, V. (2005). Introduction to the practice of telemedicine. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 11(1), 3-9. <https://doi.org/10.1258/1357633053081484>
- Dennis, C.-L., & Falah-Hassani, K. (2019). Shining a light on perinatal mental health: Major depressive disorder and anxiety disorders in pregnancy and postpartum. *Canadian Journal of Psychiatry*, 64(9), 585-586. <https://doi.org/10.1177/0706743719867894>
- Holland, K. E., Patel, D. H., & Bianchi, J. (2021). Use of telehealth to support breastfeeding in the United States during the COVID-19 pandemic. *Journal of Human Lactation*, 37(2), 364-369. <https://doi.org/10.1177/0890334420987501>
- Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academies Press.
- Kang, S., & Kim, Y. (2019). The effect of telehealth on breastfeeding rates: A systematic review. *Journal of Advanced Nursing*, 75(9), 1818-1832. <https://doi.org/10.1111/jan.13971>
- Moore, G. F., Audrey, S., Barker, M., Bond, L., Bonell, C., Hardeman, W., ... & Baird, J. (2015). Process evaluation of complex interventions: Medical Research Council guidance. *BMJ*, 350, h1258. <https://doi.org/10.1136/bmj.h1258>
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on maternal health: Guidelines approved by the WHO Guidelines Review Committee*. WHO Press.
- World Health Organization. (2020). *Digital health*. [https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1)
- Yeh, H.-C., & Chang, P.-J. (2021). Evidence-based practice and its application in maternal and child nursing. *Journal of Nursing and Healthcare*, 6(4), 71-77. <https://doi.org/10.11648/j.jnh.20210604.12>

Buku Ajar Nifas merupakan buku referensi kebidanan yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fase nifas yaitu masa pemulihan penting bagi ibu setelah proses persalinan. Buku ini membahas berbagai aspek fisiologis, psikologis, dan sosial yang dialami oleh ibu nifas, mulai dari perubahan hormonal, involusi uterus, produksi ASI, hingga tantangan emosional seperti baby blues dan depresi postpartum. Materi disusun secara sistematis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan praktik klinik.

Buku ini mencakup berbagai tema utama seperti konsep dasar masa nifas, pemeriksaan dan pengkajian kondisi ibu, perubahan sistem tubuh, edukasi dan konseling, serta pendekatan asuhan holistik. Dilengkapi dengan soal pilihan ganda, tugas studi kasus, serta strategi manajemen waktu dan peran sosial ibu, buku ini menjadi sumber belajar yang interaktif dan kontekstual. Penyajian yang berbasis capaian pembelajaran memudahkan mahasiswa memahami keterkaitan antara teori dan praktik pelayanan kebidanan.

Ditujukan bagi mahasiswa kebidanan, bidan praktisi, dan tenaga kesehatan lainnya, buku ini juga relevan digunakan sebagai bahan ajar di institusi pendidikan kesehatan. Dengan pendekatan ilmiah dan praktis, buku ini diharapkan mampu membekali para pembacanya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif pada masa nifas, serta mendukung kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan.



Buku Ajar Nifas merupakan buku referensi kebidanan yang dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fase nifas yaitu masa pemulihan penting bagi ibu setelah proses persalinan. Buku ini membahas berbagai aspek fisiologis, psikologis, dan sosial yang dialami oleh ibu nifas, mulai dari perubahan hormonal, involusi uterus, produksi ASI, hingga tantangan emosional seperti baby blues dan depresi postpartum. Materi disusun secara sistematis dan aplikatif sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan praktik klinik.

Buku ini mencakup berbagai tema utama seperti konsep dasar masa nifas, pemeriksaan dan pengkajian kondisi ibu, perubahan sistem tubuh, edukasi dan konseling, serta pendekatan asuhan holistik. Dilengkapi dengan soal pilihan ganda, tugas studi kasus, serta strategi manajemen waktu dan peran sosial ibu, buku ini menjadi sumber belajar yang interaktif dan kontekstual. Penyajian yang berbasis capaian pembelajaran memudahkan mahasiswa memahami keterkaitan antara teori dan praktik pelayanan kebidanan.

Ditujukan bagi mahasiswa kebidanan, bidan praktisi, dan tenaga kesehatan lainnya, buku ini juga relevan digunakan sebagai bahan ajar di institusi pendidikan kesehatan. Dengan pendekatan ilmiah dan praktis, buku ini diharapkan mampu membekali para pembacanya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif pada masa nifas, serta mendukung kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan.

Penerbit:

**PT Optimal Untuk Negeri**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7426-01-7



9

786347

426017